



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PELAYANAN GIZI**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nomor : 571.84/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Gizi

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Gizi



(**Ericha Risdawati, AMd.Gz**)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(**Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP**)

Ditetapkan oleh :
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Gizi dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Gizi ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2026 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Gizi ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 6 Juni 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN GIZI

Pengarah & Editor : Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

Penyusun:

1. Dwi Novianti, A. Md.A.K., M.Kes
2. Veni Lestari Puri Purnami, AMd.Gz
3. Ericha Risdawati, AMd.Gz
4. Suci Nur Pratiwi, S.Gz
5. Chandrawati Mustikasari, S.Tr.Gz
6. Alfira Chaerunisa, S.Tr.Gz
7. Nafisah Ulfa Hasanah, S.Gz
8. Mahesa Yudistiranti, S. AP

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Ruang Lingkup 2

 1.3 Pengertian dan Batasan Operasional 2

BAB II STANDAR KETENAGAAN 4

 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia 4

 2.2 Distribusi Ketenagaan 4

 2.3 Pengaturan Jaga/Dinas 5

BAB III STANDAR FASILITAS 6

 3.1 Denah Ruang 6

 3.2 Standar Fasilitas 6

BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN 16

 4.1 Pengertian Pelayanan Gizi Rumah Sakit 16

 4.2 Kemampuan Pelayanan Gizi di RS Prima Husada 17

BAB V TATA LAKSANA 20

 5.1 Asuhan Gizi 20

 5.2 Pelayanan Makanan di Rumah Sakit 26

 5.3 Pelayanan Gizi Terintegrasi 35

 5.4 Pelayanan Gizi Pasien HIV 36

 5.5 Pelayanan Gizi Pasien Stunting Wasting 36

BAB VI LOGISTIK 44

BAB VII KESELAMATAN PASIEN 47

 7.1 Pengertian 47

 7.2 Tujuan 47

 7.3 Tata Laksana Keselamatan Pasien 47

BAB VIII KESELAMATAN KERJA 55

BAB IX PENGENDALIAN MUTU 60

 9.1 Pengertian 60

 9.2 Bentuk-bentuk Pengawasan dan Pengendalian 60

BAB X PENUTUP 65

DAFTAR TABEL

TABEL 1 KUALIFIKASI SDM 4

TABEL 2 DISTRIBUSI KETENAGAAN 4

TABEL 3 DAFTAR JAGA..... 5

TABEL 4 DAFTAR PERALATAN KESEHATAN DI INSTALASI GIZI..... 9

TABEL 5 INSTRUMEN SELF ASSESSMENT IZIN OPERASIONAL..... 12

TABEL 6 PROSEDUR KERJA ASUHAN GIZI RAWAT INAP 22

TABEL 7 PENYIMPANAN BAHAN MAKANAN BASAH 29

TABEL 8 STANDART PENYIMPANAN BAHAN MAKANAN BASAH DAN KERING 30

TABEL 9 JADWAL PEMBERIAN MAKANAN DI RAWAT INAP 34

TABEL 10 JADWAL PEMBERIAN MAKANAN PASIEN RAWAT INAP ISOLASI..... 35

TABEL 11 PERKIRAAN RDA/AKG BERDASARKAN USIA 42

TABEL 12 KATEGORI KESALAHAN DALAM INSTALASI GIZI..... 51

TABEL 13 PENILAIAN DAMPAK KLINIS/KONSEKUENSI/SEVERITY 52

TABEL 14 PENILAIAN PROBABILITAS/ FREKUENSI..... 52

TABEL 15 MATRIKS GRADING RISIKO 53

TABEL 16 TINDAKAN SESUAI TINGKAT DAN BAND RISIKO 54

TABEL 17 IDENTIFIKASI BAHAYA POTENSIAL 56

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.84/I-PDM/DIR/VI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN GIZI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. Bahwa pedoman pelayanan gizi rumah sakit merupakan hal pokok dalam pelayanan penyelenggaraan makanan rumah sakit dan memerlukan acuan agar dapat dilaksanakan secara seragam, konsisten dan terintegrasi;
- b. Bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang Nomor 571.84/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Gizi perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelayanan kesehatan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu adanya pembaharuan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Gizi.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Keselamatan Pasien;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang tandar Antropometri Anak
10. Kepdrijen Nomor HK 0107/MENKES/1596/2024 tentang Instrumen Survey Akreditasi Rumah Sakit.
11. Kepdrijen Nomor HK.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman survey Akreditasi Rumah Sakit
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting

Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPM-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN GIZI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu angkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit
- (3) Terapi gizi adalah pelayanan gizi yang diberikan kepada klien berdasarkan pengkajian gizi, yang meliputi terapi diet, konseling gizi dan atau pemberian makanan khusus dalam rangka penyembuhan penyakit pasien
- (4) Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) adalah Pendekatan sistematis memberikan pelayanan asuhan gizi yang berkualitas, melalui serangkaian aktivitas yang teroginisir meliputi identifikasi kebutuhan gizi sampai pemberian pelayanannya untuk memenuhi kebutuha gizi
- (5) Konseling Gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah yang dilakukan ahli gizi untuk meningkatkan pengertian pasien dalam mengatasi masalh gizi pasien
- (6) Penyuluhan Gizi adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan-pesan gizi dan kesehatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan pengertian pasien dan lingkungannya.
- (7) Tenaga gizi adalah setiap orag yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria kemanan pangan, kandungan gizi dan standar terhadap bahan makanan dan minuman
- (9) Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan tumbuh dan berkembangnya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan

-
- manusia
- (10) Ahli gizi melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Standar Pelayanan Gizi di Ruma Sakit bertujuan untuk :

- (1) Terciptanya sistem pelayanan gizi yang bermutu dan paripurna sebagai bagian dari pelayanan sehat di rumah sakit
- (2) Menciptakan penyelenggaraan asuhan gizi terstandar
- (3) Menciptakan penyelenggaraan makanan sesuai standar kebutuhan gizi dan aman dikonsumsi

BAB III STANDAR PELAYANAN GIZI

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Gizi di Rumah sakit meliputi standar:
 - a. Pemberian Asuhan Gizi Rawat Jalan
 - b. Pemberian Asuhan Gizi Rawat Inap
 - c. Penyelenggaraan makanan
 - d. Penyuluhan Gizi
 - e. Pemberian Asuhan Gizi pasien stunting
- (2) Asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi:
 - a. Pengkajian gizi
 - b. Penentuan diagnosa gizi
 - c. Intervensi gizi
 - d. Monitoring dan evaluasi
- (3) Pelayanan penyelenggaraan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pemesanan bahan makanan
 - b. Penerimaan bahan makanan
 - c. Penyimpanan bahan makanan
 - d. Pengolahan bahan makanan
 - e. Pemorsian makanan
 - f. Distribusi makanan

BAB IV PEMBERIAN ASUHAN GIZI RAWAT JALAN

Pasal 4

- (1) Pasien poli gizi merupakan pasien yang telah melakukan pendaftaran bagi pasien umum atau pasien rujukan dokter dari poliklinik spesialis
 - (2) Pasien diskriminasi untuk risiko nutrisi sebagai bagian dari pengkajian awal
 - (3) Pasien dengan risiko nutrisi dilanjutkan dengan pengkajian gizi rawat jalan
 - (4) Pasien dengan risiko nutrisi dilakukan pencatatan data pasien, hasil pengkajian, diagnosa gizi, dan pemberian intervensi pada lembar asuhan gizi rawat jalan
 - (5) Intervensi gizi rawat jalan berupa edukasi dan konseling dengan menjelaskan leaflet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi pasien
 - (6) Ahli gizi menganjurkan pasien melakukan kunjungan ulang untuk melakukan evaluasi melihat keberhasilan intervensi
-

- (7) Pencatatan hasil konseling gizi menggunakan format ADIME (Asesmen, Diagnosis, Intervensi, Monitoring, dan Evaluasi)

BAB V PEMBERIAN ASUHAN GIZI RAWAT INAP

Pasal 5

- (1) Skrining gizi dilakukan pada semua pasien rawat inap sebagai bagian dari pengkajian awal
- (2) Skrining gizi dilakukan dalam 1x24 jam setelah pasien masuk rumah sakit oleh perawat dalam pengawasan ahli gizi
- (3) Setelah pasien dilakukan skrining, pasien dengan risiko nutrisi dilakukan pengkajian gizi dengan memberikan asuhan gizi lebih lanjut oleh ahli gizi. Untuk pasien dengan status gizi normal dan tidak ada kebutuhan diet khusus evaluasi dilakukan setelah 3 hari

Pasal 6

- (1) Asuhan gizi dilakukan pada pasien yang mengalami malnutrisi yang didapatkan dari hasil skrining gizi.
- (2) Asuhan gizi dilakukan juga terhadap pasien yang obesitas, pasien pasca bedah, bumil dengan HEG, dan pasien ICU.
- (3) Asuhan gizi dilakukan mulai asesmen pasien meliputi pengkajian data antropometri, fisik klinis kemudian dilanjutkan dengan menegakkan diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelayanan Konsultasi Gizi dilaksanakan oleh petugas gizi.
- (2) Petugas gizi harus melakukan identifikasi, komunikasi dan penjelasan mengenai makanan yang diberikan kepada pasien.
- (3) Pemberian komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga dilakukan dengan cara yang seragam.
- (4) Pemberian komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga wajib didokumentasikan pada form edukasi disertai tanda tangan sebagai penerima edukasi

Pasal 8

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi untuk terapi gizi terintegrasi.
- (2) Pemberian terapi gizi terintegrasi pada pasien risiko nutrisi (gizi kurang, gizi lebih/ Obesitas, pasien pasca bedah, bumil dengan HEG, pasien ICU, pasien anak dengan stunting dan wasting).
- (3) Asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi.
- (4) Evaluasi dan monitoring terapi gizi dicatat di rekam medis pasien.
- (5) Pencatatan hasil terapi gizi menggunakan format ADIME (Asesmen, Diagnosis, Intervensi, Monitoring, dan Evaluasi) di CPPT pasien

Pasal 9

Petugas gizi yang bertugas harus memiliki Surat Izin sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI

Pasal 10

- (1) Siklus menu yang digunakan adalah siklus menu 5 hari
- (2) Pemesanan bahan makanan basah dilakukan 2 kali dalam satu minggu
- (3) Pemesanan bahan kering dilakukan 2 kali dalam satu minggu
- (4) Pemesanan daging ayam dan sapi dilakukan setiap hari
- (5) Sistem pembelian bahan makanan basah langsung ke pasar (The Open Market of Buying)
- (6) Sistem Pembelian bahan makanan kering melalui pemesanan dengan mitra rumah sakit
- (7) Apabila terdapat bahan makanan kering yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan makanan maka bahan makanan dapat dikembalikan atau ditukar dengan bahan makanan dengan kondisi lebih baik

Pasal 11

- (1) Penyimpanan bahan makanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan
- (2) Suhu penyimpanan bahan makanan harus sesuai yaitu 25°C untuk bahan makanan kering dan -5°C untuk bahan makanan beku
- (3) Penyimpanan dan pengambilan bahan makanan menggunakan sistem FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*)

Pasal 12

- (1) Proses pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien serta dicatat di rekam medis.
- (2) Makanan disiapkan dan disimpan dengan mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan.
- (3) Distribusi makanan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jika keluarga membawa makanan bagi pasien, mereka diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan risiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi.
- (5) Makanan yang dibawa keluarga pasien atau orang lain disimpan didalam nakas secara benar untuk mencegah kontaminasi.

Pasal 13

- (1) Peralatan dilakukan pemeliharaan dengan baik.
- (2) Pencucian peralatan makanan dilakukan secara sentral dan dilakukan oleh tenaga yang terlatih.
- (3) Pelayanan gizi harus senantiasa berorientasi pada kecukupan gizi pasien, serta mutu dan keselamatan pasien.
- (4) Pemeriksaan rectal swab petugas penjamah makanan dan pemeriksaan swab alat makan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Pasal 14

- (1) Bentuk sediaan dan kandungan gizi harus sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan atas permintaan dokter.
- (2) Penyediaan bahan makanan, pengolahan bahan makanan dan pendistribusian makanan harus memperhatikan kualitas dan persyaratan kesehatan dan harus dibawah pengawasan ahli gizi (D3/D4/S1 Gizi).
- (3) Pola penyediaan makan untuk pasien terdiri dari 3 kali makan dan

1 kali snack dalam waktu tertentu, dan disesuaikan dengan kondisi pasien.

Pasal 15

- (1) Pemberlakuan estimasi pemesanan makanan diluar jam estimasi yang di jadwalkan, maka tidak dilayani.
- (2) Pengambilan peralatan makan diambil satu jam setelah makanan terbagi.
- (3) Penentuan porsi makanan pasien ditentukan dengan standar rumah tangga.

Pasal 16

- (1) Kriteria pemilihan makanan di instalasi gizi adalah Halal.
- (2) Pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, sesuai dengan regulasi RS Prima Husada.

Pasal 17

- (1) Pasien tidak diperkenankan membawa makanan dari luar rumah sakit dan harus mengikuti aturan diet dari ahli gizi rumah sakit Prima Husada
- (2) Skrining barang bawaan pasien saat jam berkunjung dilakukan oleh petugas security dan petugas ruang perawatan.
- (3) Jika keluarga membawa makanan bagi pasien, mereka diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan risiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi.

Pasal 18

Petugas gizi tidak diperkenankan meminjamkan segala macam peralatan makan yang ada di pantry kepada pasien/keluarga pasiennya lainnya untuk mengurangi infeksi tertular yang diakibatkan penyakit pasien.

BAB VII PENYULUHAN GIZI

Pasal 19

- (1) Penyuluhan gizi dilakukan pada kelompok masyarakat seperti pasien dan keluarga pasien di poli spesialis, komunitas berbasis rumah sakit seperti kelompok geriatri, kelompok senam hamil.
- (2) Penyuluhan gizi diberikan satu minggu sekali
- (3) Penyuluhan gizi wajib disertai pengisian form daftar hadir dan tanda tangan bagi penerima edukasi penyuluhan

BAB VIII ASUHAN GIZI PASIEN STUNTING

Pasal 20

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi untuk terapi gizi pasien stunting dan wasting
- (2) Terapi pasien stunting dan wasting diberikan terutama pada pasien balita
- (3) Setelah pasien di screening dan didapatkan stunting dan wasting pasien mendapatkan terapi mulai asesmen pasien meliputi pengkajian data antropometri, fisik klinis kemudian dilanjutkan dengan menegakkan diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi.
- (4) ~~Monitoring dan evaluasi lanjutan di rumah balita dilakukan dengan~~

BAB IX PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN

Pasal 21

- (1) Instalasi Gizi ikut serta dalam proses peningkatan mutu dan keselamatan pasien bersama Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- (2) Rumah Sakit menerapkan sistem pelaporan kesalahan dalam pelayanan gizi yang menjamin laporan akurat dan tepat waktu.
- (3) Setiap kesalahan dalam pelayanan gizi pada pasien harus membuat laporan insiden keselamatan pasien.
- (4) Rumah Sakit memiliki upaya untuk mendeteksi, mencegah dan mengurangi kesalahan pelayanan gizi.

Pasal 22

Seluruh pelayanan gizi berorientasi kepada kepuasan dan keselamatan pasien.

BAB X PENUTUP

Pasal 23

Setiap Tenaga Gizi yang menyelenggarakan Pelayanan Gizi di Rumah Sakit wajib mengikuti Pedoman Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut terkait Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 25

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 6 Juni 2025
Direktur RS Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.84/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
GIZI

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI GIZI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan adanya persaingan pada berbagai aspek, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing dengan negara lain. Kesehatan dan gizi merupakan faktor penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas SDM di suatu negara, yang digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi, umur harapan hidup dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi hanya dapat dicapai oleh orang sehat dan berstatus gizi baik. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui upaya perbaikan gizi dalam keluarga maupun pelayanan gizi individu yang karena suatu hal mereka harus tinggal di suatu institusi kesehatan, diantaranya rumah sakit.

Otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah dalam rangka percepatan sektor-sektor tertentu, meliputi pola perencanaan dan pola pelaksanaan program. Demikian pula peran dan tugas departemen harus beralih dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi dengan memberikan porsi operasional program kepada daerah. Peran dan tugas Departemen Kesehatan juga beralih dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi dimana tugas pokok dan fungsi Departemen Kesehatan terutama dalam menyusun standar kebijakan dan standar program. Sedangkan tugas pokok dan fungsi daerah adalah sebagai pelaksana operasional program sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu bentuk perubahan sistem pengelolaan program dalam rangka otonomi daerah adalah perubahan struktur organisasi departemen ditingkat Pusat. Reorganisasi di lingkungan Departemen kesehatan telah mengubah pula struktur unit-unit kerjanya, termasuk tugas pokok dan fungsi. Dalam hal ini Departemen Kesehatan berperan sebagai pengawas, pembina dan regulator, upaya perbaikan gizi dan pelayanan gizi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Masalah gizi klinis adalah masalah gizi klinis adalah masalah gizi yang ditinjau secara individual mengenai apa yang terjadi dalam tubuh seseorang, yang seharusnya ditanggulangi secara individu. Demikian pula masalah gizi pada berbagai keadaan sakit yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi proses penyembuhan, harus diperhatikan secara individual. Adanya kecenderungan peningkatan kasus penyakit yang terkait dengan gizi, *nutrition related disease* pada semua kelompok rentan dari ibu hamil, bayi, anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, semakin dirasakan perlunya penanganan khusus. Semua ini memerlukan pelayanan gizi yang bermutu untuk mempertahankan status gizi yang optimal, sehingga tidak terjadi kurang gizi dan untuk mempercepat penyembuhan.

Risiko kurang gizi akan muncul secara klinis pada orang sakit, terutama pada penderita anoreksia, kondisi mulut/gigi geligi buruk serta kesulitan menelan, penyakit saluran cerna disertai mual, muntah dan diare, infeksi berat, usila tidak sadar dalam waktu lama, kegagalan fungsi saluran pencernaan dan pasien yang mendapat kemoterapi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunita Almatsier di beberapa rumah sakit umum di Jakarta tahun 1991 menunjukkan 20%-60% pasien menderita kurang gizi pada saat dirawat di rumah sakit.

Oleh karena itu pelayanan gizi di rumah sakit yang merupakan hak setiap orang, memerlukan adanya sebuah pedoman agar diperoleh hasil pelayanan yang bermutu. Pedoman pelayanan gizi di dalam rumah sakit ini dikelola oleh pihak rumah sakit sendiri tidak melibatkan pihak ketiga.

Pelayanan gizi yang bermutu di rumah sakit akan membantu mempercepat proses penyembuhan pasien, yang berarti pula memperpendek lama hari rawat sehingga dapat menghemat biaya pengobatan. Keuntungan lain jika pasien cepat sembuh adalah mereka dapat segera kembali mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan perkembangan iptek dibidang kesehatan, dimana telah berkembang terapi gizi medis yang merupakan kesatuan dari asuhan medis, asuhan keperawatan dan asuhan gizi.

1.2 RUANG LINGKUP PELAYANAN

Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit terdiri dari:

1. Asuhan Gizi Pasien Rawat Jalan
2. Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap
3. Penyelenggaraan Makanan
4. Pelayanan Gizi Pasien Stunting dan Wasting

Untuk meningkatkan pelayanan paripurna kepada pasien, maka ahli gizi bertugas menyelenggarakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, termasuk pelayanan klinik gizi yang merupakan bagian dari instalasi rawat jalan.

1.3 BATASAN OPERASIONAL

- a. Pelayanan Gizi Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun mengoreksi kelainan metabolisme, dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif.
- b. Pelayanan gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetic dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
- c. Terapi Gizi adalah pelayanan gizi yang diberikan kepada klien berdasarkan pengkajian gizi, yang meliputi terapi diet, konseling gizi dan atau pemberian makanan khusus dalam rangka penyembuhan penyakit pasien.
- d. Asuhan Gizi adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir/terstruktur yang memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- e. Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) adalah Pendekatan sistematis dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, melalui serangkaian aktivitas yang terorganisir meliputi identifikasi kebutuhan gizi sampai pemberian pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan gizi.

-
- f. Dietetik adalah integrasi, aplikasi dan komunikasi dari prinsip-prinsip keilmuan makanan, gizi, sosial, bisnis dan keilmuan dasar untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal secara individual, melalui pengembangan, penyediaan dan pengelolaan pelayanan gizi dan makanan di berbagai area/ lingkungan /latar belakang praktek pelayanan.
 - g. Rencana diet adalah kebutuhan zat gizi klien/pasien yang dihitung berdasarkan status gizi degenerasi penyakit dan kondisi kesehatannya.
 - h. Konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu klien/pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi dilaksanakan oleh nutrisisionis/dietisien.
 - i. Nutrisisionis adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik, baik di masyarakat maupun rumah sakit, dan unit pelaksana kesehatan lainnya, berpendidikan dasar akademi gizi.
 - j. Dietisien adalah seorang nutrisisionis yang telah mendalami pengetahuan dan keterampilan dietetik baik melalui lembaga pendidikan formal maupun pengalaman bekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, atau yang mendapat sertifikasi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI), dan bekerja di unit pelayanan yang menyelenggarakan terapi dietetik.
 - k. Food model adalah bahan makanan atau contoh makanan yang terbuat dari bahan sintetis atau asli yang diawetkan, dengan ukuran dan satuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, yang digunakan untuk konseling gizi, kepada pasien rawat inap maupun pengunjung rawat jalan.
 - l. Klien adalah pengunjung poliklinik rumah sakit, dan atau pasien rumah sakit yang berstatus rawat jalan.
 - m. Nutrition related disease adalah penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi dan dalam tindakan serta pengobatan memerlukan terapi gizi.
 - n. Mutu pelayanan gizi adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan pelayanan gizi sesuai dengan standar dan memuaskan baik kualitas dari petugas maupun sarana serta prasarana untuk kepentingan klien/pasien.

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1 KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

Agar pelayanan gizi dapat terselenggarakan dengan mutu yang dapat dipertanggung jawabkan, maka pelayanan Gizi harus dilakukan oleh tenaga profesional yang berwenang berdasarkan undang-undang, memenuhi persyaratan baik dari aspek hukum, pendidikan, kualitas maupun kuantitas dengan jaminan kepastian adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap keprofesian terus menerus dalam rangka menjaga mutu profesi dan kepuasan pelanggan. Kualitas dan rasio kuantitas harus disesuaikan dengan beban kerja dan keluasan cakupan pelayanan serta perkembangan dan visi rumah sakit.

Tabel 1. Kualifikasi SDM:

No.	Nama Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi	Jumlah Kebutuhan
1.	Kepala Instalasi Gizi	D3 Gizi	Ijazah D3 Gizi	1
2.	Ahli Gizi	S1 Gizi D3 Gizi D4 Gizi	Ijazah S1 Gizi Ijazah D3 Gizi Ijazah D4 Gizi	5
3.	Juru Masak	SMK	Ijazah SMK	2
4.	Asisten juru masak	SLTP/ SMK	Ijazah SLTP/ SMK	2
5.	Pemorsian	SMA/K	Ijazah SMA/K	6
	Penyaji	SLTP/ SMK	Ijazah SLTP/ SMK	
Total				16

2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN

Tenaga Gizi yang terlibat di Rumah Sakit Prima Husada terdiri dari :

Tabel 2. Distribusi Ketenagaan:

No.	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Jumlah SDM
1.	Kepala Instalasi Gizi	1 Shift	1 Orang
2.	Ahli Gizi TRD	4 Shift	5 Orang
3.	Juru Masak	3 Shift	2 Orang
4.	Asisten juru masak	3 Shift	2 Orang
5.	Pemorsian	2 Shift	6 Orang
	Penyaji	2 Shift	

2.3 PENGATURAN JAGA

Pengaturan Jaga di Instalasi Gizi Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Pengaturan Jaga di Instalasi Gizi:

No.	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja	Jumlah SDM
1.	Kepala Instalasi Gizi	1 Shift	08.00–16.00	1 Orang
2.	Ahli Gizi TRD	4 Shift	Pagi : 06.30–14.30 QC : 05.30 – 13.30 NSD : 08.00-16.00 Middle : 10.00 – 18.00	5 Orang
3.	Juru Masak	3 Shift	Pagi: 03.00 – 11.00 Middle: 06.00 -14.00 Siang: 09.00 – 17.00	2 Orang
4.	Asisten juru masak	3 Shift	Pagi: 03.00 – 11.00 Middle: 06.00 -14.00 Siang:09.00 – 17.00	2 Orang
5.	Pemorsian	2 Shift	Pagi: 04.00 – 12.00 Siang:09.00 – 17.00	6 Orang
	Penyaji	2 Shift	Pagi: 04.00 – 12.00 Siang:09.00 – 17.00	

STANDAR FASILITAS

3.1 DENAH RUANG

(Ada pada lampiran)

3.2 STANDAR FASILITAS

3.2.1 Fasilitas Ruang yang Dibutuhkan

a. Ruang Penerimaan dan Penimbangan Makanan

Persyaratan Ruang :

1. Digunakan untuk penerimaan bahan makanan dan mengecek kualitas serta kuantitas bahan makanan
2. Letak ruangan mudah dicapai kendaraan, dekat dengan ruang penyimpanan serta persiapan bahan makanan
3. Luas ruangan tergantung dari jumlah bahan makanan yang akan diterima

b. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Basah

Persyaratan Ruang :

1. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
2. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik.
3. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat penyimpan makanan disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai

c. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Kering

Persyaratan Ruang :

1. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
2. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik.
3. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus.

d. Ruang/ Area Persiapan Bahan Makanan

Persyaratan Ruang :

1. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
2. Dekat dengan ruang penyimpanan serta pemasakan
3. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik.
4. Ruang persiapan bahan makanan digunakan untuk membersihkan, mencuci, mengupas, memotong, mengiris sebelum bahan makanan dimasak.

e. Ruang Pengolahan/ pemasakan dan penghangatan makanan

Persyaratan Ruang :

1. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
2. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dan udara langsung dibuang keluar gedung

-
3. Ruang pengolahan terpisah dari ruang penyimpanan bahan makanan
 4. Tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat mencapai suhu -5°C sampai -10°C dengan kapasitas yang cukup memadai sesuai jenis makanan yang digunakan
 5. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat penyimpanan makanan disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.
 6. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 7. Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan penangkap asap (hood), alat pembuangan asap, dan cerobong asap.
- f. Ruang/ Area Persiapan Distribusi Makanan
- Persyaratan Ruang :
1. Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.
 2. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik.
- g. Ruang / Area Pencucian dan Penyimpanan Alat masak
- Persyaratan Ruang :
1. Pencucian dilengkapi dengan sarana air panas, sabun, detergen, sikat
 2. Alat – alat dapur besar dan kecil dibersihkan dan disimpan di ruang khusus, sehingga mudah untuk inventarisasi alat
 3. Terletak terpisah dengan ruang pencucian bahan makanan dan alat makan pasien
 4. Tersedia fasilitas pengering/rak dan penyimpanan sementara yang bersih
 5. Dilengkapi alat untuk mengatasi sumbatan dan vector
 6. Tersedia air dengan tekanan cukup
- h. Ruang/ Area Pencucian alat makan
1. Pencucian dilengkapi dengan sarana air panas, sabun, detergen, sikat
 2. Pembuangan air kotor dilengkapi dengan penangkap lemak (*grease trap*) sebelum dialirkan ke bak penampungan air kotor atau tempat pembuangan lainnya
 3. Tersedia air panas untuk mencuci dengan suhu air panas 80°C
- i. Ruang Penyimpanan Troli Gizi
- Persyaratan Ruang :
- Ruang dalam kondisi tertutup dan agar tidak mudah terkontaminasi kotoran dan debu
- j. Tempat Pembuangan Sampah
- Persyaratan Ruang :
- Diperlukan tempat pembuangan sampah yang cukup untuk menampung sampah yang dihasilkan dan harus segera dikosongkan begitu sampah terkumpul.
- k. Ruang Fasilitas Pegawai
- Persyaratan Ruang :
- Ruang ini adalah ruangan-ruangan yang dibuat untuk tempat ganti pakaian pegawai, istirahat, ruang makan, kamar mandi dan kamar kecil. Ruang ini dapat terpisah dari tempat kerja, tetapi perlu dipertimbangkan agar dengan tempat kerja tidak terlalu jauh letaknya.

I. Ruang Pengawas/ Ahli Gizi Quality Control (QC)

Persyaratan Ruangan:

Diperlukan Ahli gizi QC untuk melakukan kegiatannya. Hendaknya ruangan ini terletak cukup baik, sehingga pengawas dapat mengawasi semua kegiatan di dapur. Suhu ruangan antara 22 – 25°C dengan kelembapan 50-60%

3.2.2 Bangunan

a. Lokasi

1. Tidak berdekatan dengan sumber pencemaran seperti tempat sampah umum, WC umum, pabrik cat dan sumber pencemaran lainnya.
2. Halaman bersih, tidak bersemak, tidak banyak lalat dan tersedia tempat sampah yang bersih dan tertutup, tidak terdapat tumpukan barang-barang yang dapat menjadi sarang tikus.
3. Mudah dicapai dari semua ruang perawatan, agar pelayanan dapat diberikan dengan baik dan merata untuk semua pasien
4. Kebisingan dan keributan di pengolahan tidak mengganggu ruangan lain disekitarnya
5. Mudah dicapai kendaraan dari luar, untuk memudahkan pengiriman bahan makanan sehingga perlu mempunyai jalan langsung dari luar
6. Konstruksi bangunan untuk kegiatan jasa boga harus kokoh dan aman. Konstruksi selain kuat juga selalu dalam keadaan bersih secara fisik dan bebas dari barang-barang sisa atau bekas yang ditempatkan sembarangan.
7. Lantai kedap air, rata, tidak retak, tidak licin, kemiringan/kelandaian cukup dan mudah dibersihkan.

b. Langit – langit

1. Bidang langit-langit harus menutupi seluruh atap bangunan, terbuat dari bahan yang permukaannya rata, mudah dibersihkan, tidak menyerap air dan berwarna terang.
2. Tinggi langit-langit minimal 2,4 meter di atas lantai

c. Pintu dan Jendela

1. Pintu ruang tempat pengolahan makanan dibuat membuka ke arah luar dan dapat menutup sendiri (*self closing*), dilengkapi peralatan anti serangga/lalat seperti kassa, tirai, pintu rangkap dan lain-lain.
2. Pintu dan jendela ruang tempat pengolahan makanan dilengkapi peralatan anti serangga/lalat seperti kassa, tirai, pintu rangkap dan lain-lain yang dapat dibuka dan dipasang untuk dibersihkan.

d. Pencahayaan

1. Intensitas pencahayaan harus cukup untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pembersihan serta melakukan pekerjaan pekerjaan secara efektif.
2. Setiap ruang tempat pengolahan makanan dan tempat cuci tangan intensitas pencahayaan sedikitnya 20 *foot candle*/fc (200 lux) pada titik 90 cm dari lantai. Pada tinggi ruang pengolahan 3 meter dibutuhkan 180 watt untuk memberikan pencahayaan maksimal tanpa mengganggu proses pelayanan.
3. Semua pencahayaan tidak boleh menimbulkan silau dan distribusinya sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bayangan.

e. Ventilasi

1. Bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi dengan ventilasi sehingga terjadi sirkulasi/peredaran udara.
2. Luas ventilasi 20% dari luas lantai

f. Fasilitas Sanitasi

1. Tersedia tempat cuci tangan yang terpisah dari tempat cuci peralatan maupun bahan makanan dilengkapi dengan air mengalir dan sabun.

- Tempat cuci tangan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau dan dekat dengan tempat bekerja.
- Jumlah tempat cuci tangan disesuaikan dengan jumlah karyawan. Dengan jumlah karyawan 1 - 10 orang dibutuhkan 1 buah tempat cuci tangan.
- Jumlah kamar mandi pada 1-30 orang dibutuhkan 1 buah kamar mandi

3.2.3 Arus Kerja

Arus kerja yang dimaksud adalah urutan-urutan kegiatan kerja dalam memproses bahan makanan menjadi hidangan, meliputi kegiatan dari penerimaan bahan makanan, persiapan, pemasakan, pembagian/distribusi makanan. Yang perlu diperhatikan adalah:

- Pekerjaan sedapat mungkin dilakukan searah atau satu jurusan.
- Pekerjaan dapat lancar sehingga energi dan waktu dapat dihemat
- Bahan makanan tidak dibiarkan lama sebelum diproses
- Jarak yang ditempuh pekerja sependek mungkin dan tidak bolak-balik
- Ruang dan alat dapat dipakai seefektif mungkin
- Biaya produksi dapat ditekan
- Peralatan dan Perlengkapan di Ruang Penyelenggaraan Makanan

1. DAFTAR PERALATAN KESEHATAN DI INSTALASI GIZI (Tabel 4):

NO	PERALATAN	RUMAH SAKIT			
		Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas D
A. ASUHAN GIZI RAWAT INAP					
a. Kegiatan asuhan gizi					
1.	Alat ukur TB dan BB	√	√	√	√
2.	Alat ukur LILA	√	√	√	√
3.	Alat ukur Tinggi Lutut (Knee hight)	√	√	√	√
4.	Food model	√	√	√	√
5.	Skinfold	√	√	√	√
6.	Timbangan bayi	√	√	√	√
7.	Alat ukur panjang badan bayi	√	√	√	√
8.	Bed scale	√	√	√	√
9.	Bioelectrical analisis impedance	√	√	√	√
10.	Chair scale	√	√	√	√
11.	Pita ukur lingkar pinggang dan Pinggul	√	√	√	√
b. Kegiatan pelayanan makanan di pantry					
1.	Meja Distribusi makanan	√	√	√	√
2.	Rak alat makan	√	√	√	√
3.	Lemari alat makan	√	√	√	√
4.	Alat pemanas (kompor)	√	√	√	√
5.	Refrigerator khusus makanan cair	√	√	√	√
6.	Refrigerator	√	√	√	√
7.	Tempat pencucian alat	√	√	√	√
8.	Food trolly sentralisasi	√	√	√	√
9.	Food trolly desentralisasi	√	√	√	√
10.	Trolly makanan kelas VIP	√	√	√	√
11.	Timbangan makanan	√	√	√	√
12.	Blender	√	√	√	√
13.	Alat makan khusus dewasa	√	√	√	√
14.	Alat makan pasien anak	√	√	√	√

B. ASUHAN GIZI RAWAT JALAN (DI RUANG KONSELING GIZI)					
1.	Alat ukur TB dan BB (Dewasa dan Anak)	√	√	√	√
2.	Alat ukur LILA	√	√	√	√
3.	Food model	√	√	√	√
4.	Skinfold	√	√	√	√
5.	Lemari kaca (untuk food sample)	√	√	√	√
1. Penyelenggaraan Makanan (Di ruang Penerimaan)					
1.	Timbangan lantai	√	√	√	-
2.	Timbangan duduk	√	√	√	√
3.	Timbangan digital	√	√	√	√
4.	Trolley barang	√	√	√	√
5.	Washtafel	√	√	√	√
6.	Tempat sampah	√	√	√	√
2. Di Ruang penyimpanan bahan makanan kering					
1.	Timbangan digital	√	√	√	√
2.	Timbangan duduk	√	√	√	√
3.	Pallet	√	√	√	√
4.	Refrigerator	√	√	√	√
5.	Tempat sampah	√	√	√	√
6.	Chiller 4 pintu	√	√	√	√
7.	Tangga lipat	√	√	√	√
8.	Hand lift	√	√	√	√
9.	Trolley barang	√	√	√	√
10.	Timbangan lantai	√	√	√	√
11.	Container tertutup	√	√	√	√
12.	AC split	√	√	√	√
3. Di Ruang penyimpanan bahan makanan segar					
1.	Timbangan digital	√	√	√	√
2.	Timbangan duduk	√	√	√	√
3.	Refrigerator	√	√	√	√
4.	Tempat sampah	√	√	√	√
5.	Chiller 4 pintu	√	√	√	-
6.	Trolley barang	√	√	√	√
7.	Timbangan lantai	√	√	√	-
8.	Container tertutup	√	√	√	√
9.	Freezer cabinet	√	√	√	√
10.	Cold room freezer (temp -15°C s.d -18°C)	√	√	√	-
11.	Cold room chiller (temp 2°C s.d 8°C)	√	√	√	√
12.	Insect killer	√	√	√	√
4. Di Ruang persiapan bahan makanan					
1.	Timbangan duduk	√	√	√	√
2.	Timbangan digital	√	√	√	√
3.	Mesin pemotong daging	√	√	√	√
4.	Mesin pemotong sayuran	√	√	√	√
5.	Bak cuci	√	√	√	√
6.	Penggiling daging	√	√	√	√

7.	Mixer	√	√	√	√
8.	Blender	√	√	√	√
9.	Penggiling bumbu	√	√	√	√
10.	Talenan	√	√	√	√
11.	Food processor	√	√	√	√
12.	Peeler	√	√	√	-
13.	Tempat sampah	√	√	√	√
14.	Insect killer	√	√	√	√
15.	Pisau	√	√	√	√
5. Di Ruang pengolahan makanan					
1.	Timbangan	√	√	√	√
2.	Cooking range (tungku)	√	√	√	√
3.	Frying pan	√	√	√	√
4.	Gelas ukur	√	√	√	√
5.	Bain marrie	√	√	√	√
6.	Blender	√	√	√	√
7.	Boiling pan	√	√	√	√
8.	Oven	√	√	√	√
9.	High pressure cooker	√	√	√	√
10.	Rice cooker	√	√	√	√
11.	Pan dadar	√	√	√	√
12.	Double sink heavy	√	√	√	√
13.	Tempat sampah	√	√	√	√
14.	Trolley	√	√	√	√
15.	Kuali range	√	√	√	√
16.	Refrigerator	√	√	√	√
17.	Freezer	√	√	√	√
18.	Chiller	√	√	√	√
19.	Lemari alat	√	√	√	√
20.	Rak alat	√	√	√	√
21.	Lemari makanan matang	√	√	√	√
22.	Mesin wrapping	√	√	√	√
23.	Panci set	√	√	√	√
24.	Insect killer	√	√	√	√
25.	Meja persiapan snack, makanan Cair	√	√	√	√
26.	Cetakan telur	√	√	√	√
27.	Wajan	√	√	√	√
28.	Container tertutup	√	√	√	√
6. Di Ruang distribusi					
1.	Food trolley makanan dengan Pemanas	√	√	√	√
2.	Food trolley makanan tanpa Pemanas	√	√	√	√
3.	Timbangan duduk	√	√	√	√
7. Di ruang pencuci dan penyimpanan alat					
1.	Mesin pencuci alat	√	√	√	-
2.	Bak pencuci alat	√	√	√	√
3.	Lemari	√	√	√	√

4.	Rak alat	√	√	√	√
5.	Tempat sampah	√	√	√	√
8. Di Ruang formula					
1.	Sterilisator	√	√	√	√
2.	Tempat sampah	√	√	√	√
3.	Gelas ukur	√	√	√	√
4.	Mixer	√	√	√	√
5.	Blender	√	√	√	√
6.	Kompor gas	√	√	√	√
7.	Tungku/ cooking range	√	√	√	-
8.	Refrigerator	√	√	√	√
9.	Mesin pencuci botol	√	√	√	√
10.	Bain marie	√	√	√	√
11.	Lemari bahan makanan kering	√	√	√	√
12.	Rak botol susu	√	√	√	√
13.	Trolley	√	√	√	√
14.	Rak alat	√	√	√	√
15.	Bak pencuci alat	√	√	√	√

2. INSTRUMEN SELF ASSESSMENT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C (Tabel 5):

NO.	PERSYARATAN	KELAS C	KEADAAN RS SAAT INI	KETERANGAN
ASUHAN GIZI RAWAT INAP				
Kegiatan asuhan gizi				
1.	Alat ukur TB dan BB	+	+	
2.	Alat ukur LILA	+	+	
3.	Knee hight	+	-	
4.	Food model	+	+	
5.	Skinfold	+	-	
6.	Timbangan bayi	+	+	
7.	Alat ukur panjang badan Bayi	+	+	
8.	Bed scale	+	-	
9.	Bioelectrical analisys Impedance	+	-	
10.	Chair scale	+	-	
11.	Pita ukur lingkaran pinggang dan pinggul	+	+	
Kegiatan pelayanan makanan				
1.	Meja distribusi Makanan	+	+	
2.	Rak alat makan	+	+	
3.	Lemari alat makan	+	+	
4.	Alat pemanas (kompor)	+	+	
5.	Refrigerator khusus makanan cair	+	-	
6.	Refrigerator	+	+	
7.	Tempat pencucian alat	+	+	

8.	Food trolley sentralisasi	+	+	
9.	Food trolley desentralisasi	+	-	
10.	Trolley makanan kelas VIP	+	+	
11.	Timbangan makanan	+	+	
12.	Blender	+	+	
13.	Alat makan khusus Dewasa	+	+	
14.	Alat makan pasien anak	+	+	
Asuhan gizi rawat jalan (Diruang konseling gizi)				
1.	Alat ukur TB dan BB (Dewasa dan Anak)	+	+	
2.	Alat ukur LILA	+	+	
3.	Food model	+	+	
4.	Skinfold	+	-	
5.	Lemari kaca (untuk food sample)	+	-	
Penyelenggaraan Makanan (Di ruang penerimaan)				
1.	Timbangan lantai	+	-	
2.	Timbangan duduk	+	+	
3.	Timbangan digital	+	+	
4.	Trolley barang	+	+	
5.	Washtafel	+	+	
6.	Tempat sampah	+	+	
Di Ruang penyimpanan bahan makanan kering				
1.	Timbangan digital	+	+	
2.	Timbangan duduk	+	+	
3.	Pallet	+	+	
4.	Refrigerator	+	+	
5.	Tempat sampah	+	+	
6.	Chiller 4 pintu	+	-	
7.	Tangga lipat	+	-	
8.	Hand lift	+	-	
9.	Trolley barang	+	+	
10.	Timbangan lantai	+	-	
11.	Container tertutup	+	+	
12.	AC split	+	-	
Di Ruang penyimpanan bahan makanan segar				
1.	Timbangan digital	+	+	
2.	Timbangan duduk	+	+	
3.	Refrigerator	+	+	
4.	Tempat sampah	+	+	
5.	Chiller 4 pintu	+	-	
6.	Trolley barang	+	+	
7.	Timbangan lantai	+	-	
8.	Container tertutup	+	+	
9.	Freezer cabinet	+	+	
10.	Cold room freezer (temp - 15°C s.d -18°C)	+	-	

11.	Cold room chiller (temp 2°C s.d 8°C)	+	-	
12.	Insect killer	+	-	
Di ruang persiapan bahan makanan				
1.	Timbangan duduk	+	+	
2.	Timbangan digital	+	+	
3.	Mesin pemotong daging	+	-	
4.	Mesin pemotong sayuran	+	-	
5.	Bak cuci	+	+	
6.	Penggiling daging	+	+	
7.	Mixer	+	+	
8.	Blender	+	+	
9.	Penggiling bumbu	+	+	
10.	Talenan	+	+	
11.	Food processor	+	+	
12.	Peeler	+	+	
13.	Tempat sampah	+	+	
14.	Insect killer	+	+	
15.	Pisau	+	+	
Di Ruang Pengolahan Makanan				
1.	Timbangan	+	+	
2.	Cooking range (tungku)	+	+	
3.	Frying pan	+	+	
4.	Gelas ukur	+	+	
5.	Bain marrie	+	+	
6.	Blender	+	+	
7.	Boiling pan	+	+	
8.	Oven	+	+	
9.	High pressure cooker	+	+	
10.	Rice cooker	+	+	
11.	Pan dadar	+	+	
12.	Double sink heavy	+	+	
13.	Tempat sampah	+	+	
14.	Trolley	+	+	
15.	Kuali range	+	+	
16.	Refrigerator	+	+	
17.	Freezer	+	-	
18.	Chiller	+	+	
19.	Lemari alat	+	-	
20.	Rak alat	+	+	
21.	Lemari makanan matang	+	-	
22.	Mesin wrapping	+	+	
23.	Panci set	+	+	
24.	Insect killer	+	-	
25.	Meja persiapan snack, makanan cair	+	-	
26.	Cetakan telur	+	+	
27.	Wajan	+	+	
28.	Container tertutup	+	+	

Di Ruang Distribusi				
1.	Food trolley makanan dengan pemanas	+	-	
2.	Food trolley makanan tanpa pemanas	+	+	
3.	Timbangan duduk	+	+	
Di Ruang Pencuci dan Penyimpanan alat				
1.	Mesin pencuci alat	+	+	
2.	Bak pencuci alat	+	+	
3.	Lemari	+	-	
4.	Rak alat	+	+	
5.	Tempat sampah	+	+	
Di Ruang Formula				
1.	Sterilisator	+	-	Tidak ada ruang formula
2.	Tempat sampah	+	-	
3.	Gelas ukur	+	-	
4.	Mixer	+	-	
5.	Blender	+	-	
6.	Kompor gas	+	-	
7.	Tungku/ cooking range	+	-	
8.	Refrigerator	+	-	
9.	Mesin pencuci botol	+	-	
10.	Bain marrie	+	-	
11.	Lemari bahan makanan kering	+	-	
12.	Rak botol susu	+	-	
13.	Trolley	+	-	
14.	Rak alat	+	-	
15.	Bak pencuci alat	+	-	

KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1 Pengertian Pelayanan Gizi Rumah Sakit

Pelayanan gizi di rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan dan disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh. Keadaan gizi pasien sangat berpengaruh pada proses penyembuhan penyakit, sebaliknya proses perjalanan penyakit dapat berpengaruh terhadap keadaan gizi pasien. Sering terjadi kondisi pasien yang semakin buruk karena tidak tercukupinya kebutuhan zat gizi untuk perbaikan organ tubuh. Fungsi organ yang terganggu akan lebih memburuk dengan adanya penyakit dan kekurangan gizi. Selain itu masalah gizi lebih dan obesitas erat hubungannya dengan penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan penyakit kanker, memerlukan terapi gizi untuk membantu penyembuhannya

4.2 Kemampuan Pelayanan Gizi RS Prima Husada

4.2.1 Pelayanan Gizi Rawat Jalan

Pelayanan Gizi rawat jalan adalah serangkaian proses kegiatan asuhan gizi yang berkesinambungan dimulai dari pengkajian, pemberian diagnosis, intervensi gizi dan monitoring evaluasi kepada pasien di rawat jalan

Pelayanan Gizi rawat jalan di RS Prima Husada terdiri dari :

1. Konseling Gizi

- a. Pasien datang ke ruang konseling gizi dengan membawa surat rujukan dokter dari poliklinik yang ada di rumah sakit atau dari luar rumah sakit
- b. Ahli gizi melakukan asesmen gizi dimulai dengan pengukuran antropometri pada pasien yang belum ada data TB, BB
- c. Ahli gizi melanjutkan asesmen/pengkajian gizi berupa anamnesa riwayat makan, riwayat personal, membaca hasil pemeriksaan lab dan fisik klinis (bila ada). Kemudian menganalisa semua data asesmen gizi.
- d. Ahli gizi menetapkan diagnosis gizi.
- e. Ahli gizi memberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling dengan langkah menyiapkan dan mengisi *leaflet flyer*/brosur diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi pasien serta menjelaskan tujuan diet, jadwal, jenis, jumlah bahan makanan sehari menggunakan alat peraga *food model*, menjelaskan tentang makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, cara pemasakan dan lain-lain yang disesuaikan dengan pola makan dan keinginan serta kemampuan pasien.
- f. Ahli gizi menganjurkan pasien melakukan kunjungan ulang, untuk mengetahui keberhasilan intervensi (monev) dilakukan monitoring dan evaluasi gizi.
- g. Ahli gizi mengisi formulir permintaan konseling gizi rawat jalan.
- h. Ahli gizi melakukan pencatatan data pasien dalam spreadsheet registrasi konseling pasien rawat jalan .

2. Penyuluhan Gizi

Penyuluhan gizi berkelompok seperti: pemberian edukasi di kelompok pasien diabetes, ibu hamil dan menyusui, pasien jantung koroner, pasien kanker, dll. Penyuluhan ini dilakukan bersama Tim PKRS RS. Prima Husada.

Mekanisme pasien berkunjung untuk mendapatkan asuhan gizi di rawat jalan berupa penyuluhan gizi adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyuluhan :
 - 1) Menentukan materi sesuai kebutuhan

- 2) Membuat susunan materi yang akan disajikan
 - 3) Merencanakan media yang akan digunakan
 - 4) Pengumuman jadwal dan tempat penyuluhan
 - 5) Persiapan ruangan dan alat bantu/media yang dibutuhkan
- b. Pelaksanaan Penyuluhan :
- 1) Peserta mengisi daftar hadir (absensi)
 - 2) Dietisien menyampaikan materi penyuluhan
 - 3) Tanya jawab

4.2.2 Pelayanan Gizi Rawat Inap

a. Skrining Gizi

Tahapan pelayanan gizi rawat inap diawali dengan skrining/penapisan gizi oleh perawat ruangan dan penetapan order diet awal (preskripsi diet awal) oleh dokter. Skrining gizi bertujuan untuk mengidentifikasi pasien/klien yang berisiko, tidak berisiko malnutrisi atau kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksud adalah pasien dengan kondisi kritis (pasien ICU) , pasien post op, pasien dengan malnutrisi (gizi lebih/ gizi kurang), pasien hamil dengan HEG. Skrining dilakukan pada pasien baru 1 x 24 jam setelah pasien masuk RS. Metoda skrining sebaiknya singkat, cepat dan disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan di masing-masing rumah sakit. Contoh metoda skrining antara lain yaitu:

- 1) *Malnutrition Screening Tools (MST)* untuk dewasa
- 2) *Strong Kids* untuk pasien anak
- 3) Skrining *gizi pasien obstetric*
- 4) Skrining gizi pasien Geriatri

Pasien dengan status gizi baik atau tidak berisiko malnutrisi, dianjurkan dilakukan skrining ulang/skrining lanjut setelah 1 minggu.

Bila hasil skrining gizi menunjukkan pasien berisiko malnutrisi, maka dilakukan pengkajian/assesmen gizi dan dilanjutkan dengan langkah-langkah proses asuhan gizi terstandar oleh Ahli gizi.

b. Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

Proses Asuhan gizi Terstandar dilakukan pada pasien yang berisiko kurang gizi, sudah mengalami kurang gizi dan atau kondisi khusus dengan penyakit tertentu. Langkah PAGT terdiri dari :

1) Assesment/Pengkajian gizi

Assesmen gizi dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu anamnesis riwayat gizi, data biokimia, Pengukuran antropometri, Pemeriksaan fisik klinis, Riwayat personal.

a) Anamnesa Riwayat Gizi

Anamnesis riwayat gizi adalah data meliputi asupan makanan termasuk komposisi, pola makan, diet saat ini dan data lain yang terkait. Selain itu diperlukan data kepedulian pasien terhadap gizi dan kesehatan, aktivitas fisik dan olahraga dan ketersediaan makanan di lingkungan klien.

b) Data Biokimia

Data biokimia meliputi hasil pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan status gizi, status metabolik dan gambaran fungsi organ yang berpengaruh terhadap timbulnya masalah gizi.

c) Pengukuran Antropometri

Antropometri merupakan pengukuran fisik pada individu. Antropometri dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pengukuran Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB), Lingkar Lengan Atas (LiLA).

Penilaian status gizi dilakukan dengan membandingkan beberapa ukuran tersebut diatas misalnya Indeks Massa Tubuh (IMT) yaitu ratio BB terhadap TB.

Parameter antropometri yang penting untuk melakukan evaluasi status gizi pada bayi, anak dan remaja adalah Pertumbuhan. Pada anak dengan usia 1-5 Tahun status gizi dapat diukur menggunakan *WHO Child Growth Standards*, pada anak usia 6-17 Tahun menggunakan *CDC Chart Growth*, sedangkan pada pasien usia 18 tahun keatas menggunakan IMT.

Pemeriksaan fisik yang paling sederhana untuk melihat status gizi pada pasien rawat inap adalah BB. Pasien sebaiknya ditimbang dengan menggunakan timbangan yang akurat/terkalibrasi dengan baik. Pencatatan BB pada pasien gizi kurang dilakukan setiap hari dan dicatat di kolom monitoring evaluasi di e-RM.

d) Pemeriksaan Fisik klinis

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan klinis yang berkaitan dengan gangguan gizi atau dapat menimbulkan masalah gizi.

e) Riwayat personal

Data riwayat personal meliputi riwayat obat-obatan atau suplemen yang sering dikonsumsi, sosial budaya, riwayat penyakit.

2. Diagnosis Gizi

Penulisan diagnosa gizi terstruktur dengan konsep PES atau *Problem Etiologi* dan *Signs/ Symptoms*.

Diagnosis gizi dikelompokkan menjadi tiga domain yaitu:

- a) Domain Asupan adalah masalah aktual yang berhubungan dengan asupan energi, zat gizi, cairan, substansi bioaktif dari makanan baik yang melalui oral maupun parenteral dan enteral.
- b) Domain Klinis adalah masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi medis atau fisik/fungsi organ.
- c) Domain Perilaku / lingkungan adalah masalah gizi yang berkaitan dengan pengetahuan, perilaku/kepercayaan, lingkungan fisik dan akses dan keamanan pangan

Contoh penulisan Diagnosis gizi adalah:

Asupan protein yang kurang (P) berkaitan dengan perubahan indera perasa dan nafsu makan pasien ditandai dengan asupan protein rata-rata sehari kurang dari 40% kebutuhan (S)

3. Intervensi Gizi

Intervensi gizi dibuat merujuk pada diagnosis gizi yang ditegakkan. Tentukan pula jadwal dan frekuensi asuhan. Intervensi dilakukan dengan membuat preskripsi diet sebagai berikut:

a) Perhitungan Kebutuhan Gizi

Penentuan kebutuhan zat gizi yang diberikan kepada pasien/klien atas dasar diagnosis gizi, kondisi pasien dan jenis penyakitnya.

b) Jenis Diet

Pada umumnya pasien masuk ke ruang rawat sudah dibuat permintaan makanan berdasarkan pesanan/ *order* diet awal dari dokter jaga/DPJP. Ahli gizi Bersama tim atau secara mandiri akan menetapkan jenis diet berdasarkan diagnosis gizi. Bila jenis diet yang

ditentukan sesuai dengan diet order maka diet tersebut diteruskan dengan dilengkapi dengan rancangan diet. Bila diet tidak sesuai akan dilakukan usulan perubahan jenis diet dengan mendiskusikannya terlebih dahulu bersama (DPJP).

c) Modifikasi diet

Modifikasi diet merupakan perubahan dari makanan biasa (normal). Perubahan dapat berupa perubahan dalam konsistensi; meningkatkan/menurunkan nilai energi; menambah/mengurangi jenis bahan makanan atau zat gizi yang dikonsumsi; *membatasi* jenis atau kandungan makanan tertentu; menyesuaikan komposisi zat gizi (protein, lemak, KH, cairan dan zat gizi lain); mengubah jumlah, frekuensi makan dan rute makanan. Makanan di rumah sakit umumnya berbentuk makanan biasa, lunak, saring dan cair.

d) Jadwal pemberian diet

Jadwal pemberian diet / makanan dituliskan sesuai dengan jenis diet dan jumlah kalori pasien. Contoh penulisan label makan pasien: nama, tanggal lahir pasien, jenis diet dan kebutuhan kalori pasien.

e) Jalur Makanan

Jalur makanan yang diberikan dapat melalui oral dan enteral atau parenteral

4. Monitoring dan Evaluasi Gizi

Kegiatan monitoring dan evaluasi gizi dilakukan untuk mengetahui respon pasien/klien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya.

4.2.3 Penyelenggaraan Makanan

Penyelenggaraan makanan rumah sakit merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu, perencanaan kebutuhan bahan makanan, perencanaan anggaran belanja, pengadaan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan, pemasakan bahan makanan, distribusi dan pencatatan, pelaporan serta evaluasi. Langkah penyelenggaraan makanan rumah sakit adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Menu
- 2) Pengadaan Bahan
- 3) Penerimaan dan Penyimpanan
- 4) Persiapan dan Pengolahan Makanan
- 5) Distribusi Makanan
- 6) Penyajian Makanan di Ruang
- 7) Pelayanan Makanan Pasien

4.2.4 Pelayanan Gizi Pasien Stunting dan Wasting

Stunting merupakan perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO.

Wasting adalah kondisi Dimana berat badan anak jauh dibawah standar kurva pertumbuhan yang diukur berdasarkan tinggi badan.

Kurva pertumbuhan yang digunakan untuk diagnosis stunting dan wasting adalah kurva WHO *child growth standard* tahun 2006 yang merupakan baku emas pertumbuhan optimal seorang anak.

TATA LAKSANA

Pelayanan gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status gizi optimal dalam kondisi sehat atau sakit

Peningkatan status gizi dan kesehatan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab tim asuhan gizi. Tim asuhan gizi merupakan seluruh tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mempercepat kesembuhan pasien

Tim asuhan gizi merupakan tenaga kesehatan, meliputi:

1. Dietisien/ahli gizi
2. Dokter DPJP
3. Perawat
4. Ahli Farmasi
5. Tenaga Kesehatan lain

Komunikasi antar disiplin ilmu sangat diperlukan untuk memberikan asuhan yang terbaik bagi pasien. Oleh karena itu perlu mengetahui peranan masing-masing tenaga kesehatan tersebut dalam memberikan pelayanan (Kemenkes, 2013).

Tim asuhan gizi terdiri dari berbagai macam profesi yang mempunyai peran, sbb :

a. Dietisien

1. Mengkaji hasil skrining gizi dari perawat dan order diet dari dokter
2. Melakukan pengkajian gizi lanjut pada pasien beresiko malnutrisi, atau kondisi khusus meliputi pengumpulan, analisa, dan interpretasi riwayat gizi atau makanan, biokimia, pemeriksaan fisik/klinis, antropometri, dan riwayat personal pasien
3. Mengidentifikasi dan menetapkan diagnosis gizi berdasarkan hasil pengkajian gizi
4. Menyusun intervensi diet meliputi tujuan dan preskripsi diet yang lebih terperinci serta merencanakan konseling gizi
5. Melakukan kerjasama dengan dokter terkait diet definitive
6. Melakukan koordinasi dengan tim asuhan gizi untuk melaksanakan intervensi gizi
7. Melakukan evaluasi terhadap proses dan dampak asuhan gizi yang diberikan
8. Melakukan edukasi gizi
9. Mencatat dan melaporkan hasil asuhan gizi pada dokter
10. Melakukan pengkajian ulang jika tujuan tidak tercapai

b. Dokter DPJP

1. Bertanggung jawab dalam aspek gizi pasien yang terkait dengan aspek klinis
2. Menentukan preskripsi diet awal
3. Menetapkan diet definitive dengan ahli gizi
4. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai peran asuhan gizi
5. Merujuk pasien yang membutuhkan konseling gizi
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait masalah gizi

- c. Perawat
 1. Melakukan skrining gizi pasien awal perawatan
 2. Merujuk pasien beresiko malnutrisi ke ahli gizi
 3. Melakukan pengukuran antropometri secara berkala
- d. Farmasi
 1. Mempersiapkan obat dan zat gizi terkait seperti vitamin, mineral, elektrolit dan nutrisi parenteral
 2. Menentukan kompatibilitas zat gizi yang diberikan kepada pasien
 3. Membantu mengawasi dan mengevaluasi penggunaan obat dan cairan parenteral oleh pasien bersama perawat
 4. Berkolaborasi dengan dietisien dalam pemantauan interaksi obat dan makanan
 5. Memberikan edukasi ke pasien dan keluarga mengenai interaksi obat dan makanan
- e. Tenaga Kesehatan lain misalnya tenaga terapi okupasi dan terapi wicara berkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi pada pasien dengan gangguan menelan yang berat

5.1 ASUHAN GIZI

1. Pengertian

Asuhan gizi merupakan sarana dalam pemenuhan zat gizi pasien. Pelayanan gizi rawat inap sering disebut juga dengan Terapi Gizi Medik. Pelayanan kesehatan paripurna seorang pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, secara teoritis memerlukan tiga jenis asuhan yang pada pelaksanaannya dikenal sebagai pelayanan. Ketiga jenis asuhan tersebut adalah asuhan medik, asuhan keperawatan, dan asuhan gizi.

2. Tujuan

Tujuan utama Asuhan Gizi adalah memenuhi kebutuhan zat gizi pasien secara optimal baik berupa pemberian makanan pada pasien yang dirawat maupun konseling gizi pada rawat jalan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama tim yang terdiri dari unsur terkait untuk melaksanakan urutan kegiatan, yang dikelompokkan menjadi lima kegiatan, yaitu:

- a. Membuat diagnosis masalah gizi
- b. Menentukan kebutuhan terapi gizi. Dalam pelaksanaan asuhan gizi, penentuan terapi gizi pasien perlu mempertimbangkan tiga macam kebutuhan, yaitu penggantian (*replacement*), pemeliharaan (*maintenance*), dan penambahan akibat kehilangan (*loss*) yang berkelanjutan dan untuk pemulihan jaringan dengan berpedoman kepada tepat zat gizi (bahan makanan), tepat formula, tepat bentuk, tepat cara pemberian, serta tepat dosis dan waktu.
- c. Memilih dan mempersiapkan bahan/makanan/formula khusus (oral, enteral, dan parenteral) sesuai kebutuhan.
- d. Melaksanakan pemberian makanan
- e. Evaluasi/pengkajian gizi dan pemantauan

3. Peran Nutrisi/Dietisien

- a. Mengkaji status gizi klien/pasien berdasarkan rujukan
- b. Melakukan anamnesis riwayat diet klien/pasien
- c. Menerjemahkan rencana diet ke dalam bentuk makanan yang disesuaikan dengan kebiasaan makan serta keperluan terapi
- d. Memberikan saran kepada dokter berdasarkan hasil pemantauan/evaluasi terapi gizi

- e. Memantau masalah yang berkaitan dengan asuhan gizi kepada klien/pasien dan keluarganya
 - f. Memberikan penyuluhan, motivasi, dan konseling gizi pada klien/pasien dan keluarganya
 - g. Melakukan kunjungan keliling (*visite*) kepada klien/pasien
 - h. Mengevaluasi status gizi klien/pasien secara berkala, asupan makanan, dan bila perlu melakukan perubahan diet pasien
 - i. Mengkomunikasikan hasil terapi gizi
 - j. Menentukan rencana diet awal/ sementara bila belum ada penentuan diet dari dokter
 - k. Melakukan pemantauan interaksi obat dan makanan
4. Prosedur Kerja Asuhan Gizi di Ruang Rawat Inap
- Berikut ini tabel tentang prosedur kerja asuhan gizi di ruang rawat inap.

Tabel 6. Prosedur Kerja Asuhan Gizi Ruang Rawat Inap :

No.	Kegiatan	Mekanisme	Unsur Terkait	Penanggung Jawab
1.	Penentuan status gizi a. Klinis b. Deteksi c. Antropometri d. Laboratorium	Dilakukan untuk setiap pasien baru dan dimonitor setiap hari Dilakukan pada saat pasien masuk Pengukuran dilakukan seminggu sekali Glukosa darah, Hb, UL, feses	Dokter Dokter Dokter/ Dietisien/ Nutrision Dokter/ Analisis	Dokter Dokter dan kepala ruangan Kepala ruangan Dokter/ Analis
2.	Intervensi a. Klinis b. Diet	Mengatasi semua gejala penyakit (Hipogikeia, hipotermia, dehidrasi, infksi, dll) • Menentukan diet • Pemantauan • Konsumsi makanan • Status gizi • Penyuluhan gizi • Pemberian diet • Persiapan pulang • Pencatatan gizi	Dokter/ Perawat Dietisien/ Nutrision	Dokter Dietisien/ Nutrision
3.	Pelaporan	Berdasarkan rekam medis: • Ruang rawat jalan • Ruang rawat inap	Dietisien/ Nutrision	Dietisien/ Nutrision

5. Asuhan Gizi Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap

Dalam pelayanan gizi Rumah Sakit Prima Husada, asuhan gizi dilakukan kepada pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.

a. Asuhan Gizi Pasien Rawat Jalan

Pengertian dari Asuhan Gizi Pasien Rawat Jalan adalah serangkaian proses kegiatan pelayanan gizi yang berkesinambungan dimulai dari perencanaan diet, pelaksanaan konseling diet hingga evaluasi rencana diet kepada klien/pasien rawat jalan.

Tujuannya adalah memberikan pelayanan gizi kepada pasien rawat jalan agar memperoleh asupan makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Kegiatannya meliputi:

1) Pengkajian status gizi

a) Antropometri

Dilakukan dengan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Bila pasien tidak dapat dilakukan pengukuran tersebut dapat dilakukan pengukuran lingkaran lengan atas (LiLa) maupun tinggi lutut.

b) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan klinis yang berhubungan dengan gangguan gizi atau untuk menentukan hubungan sebab akibat antara status gizi dengan kesehatan, serta menentukan terapi obat dan diet. Pemeriksaan fisik meliputi: tanda-tanda klinis kurang gizi (sangat kurus, pucat, atau bengkak) atau gizi lebih (gemuk atau sangat gemuk/obesitas); sistem kardiovaskuler; sistem pernapasan, sistem gastrointestinal; sistem metabolik/endokrin dan sistem neurologik/psikiatrik.

c) Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan biokimia dalam rangka mendukung diagnosa penyakit serta menegaskan masalah gizi klien/pasien. Pemeriksaan ini dilakukan juga untuk menentukan intervensi gizi dan memonitor/mengevaluasi terapi gizi.

2) Riwayat gizi

Anamnesis riwayat gizi pasien ada dua macam, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Anamnesis kualitatif dilakukan untuk memperoleh gambaran kebiasaan makan/pola makan sehari-hari berdasarkan frekuensi penggunaan bahan makanan, sedangkan anamnesis kuantitatif dilakukan untuk mendapat gambaran asupan zat gizi sehari dengan menggunakan recall 24 jam yang diukur dengan food model. Analisis asupan gizi menggunakan Daftar Penukar Bahan Makanan maupun menggunakan *software* tertentu.

3) Penentuan kebutuhan gizi sesuai dengan status gizi dan penyakitnya

Penentuan kebutuhan gizi diberikan kepada klien/pasien atas dasar status gizi, pemeriksaan klinis, dan data laboratorium. Selain itu perlu juga memperhatikan kebutuhan untuk penggantian zat gizi, kebutuhan harian, kebutuhan tambahan karena kehilangan serta tambahan untuk pemulihan jaringan atau organ yang sedang sakit.

4) Menentukan macam atau jenis diet sesuai dengan status gizi dan penyakitnya serta cara pemberian makanan .

Jenis diet disesuaikan dengan keadaan/penyakit yang diderita serta kemampuan pasien untuk menerima makanan dengan memperhatikan Prinsip Menu Seimbang (energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air, dan serat) dan kebiasaan/pola makan.

5) **Konseling gizi**

Sebelum melaksanakan kegiatan konseling gizi, terlebih dahulu dibuat rencana konseling, yang mencakup penetapan tujuan, sasaran, strategi, materi, metode, penilaian, dan tindak lanjut. Tujuan konseling gizi adalah membuat perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku makan, serta pola makan sesuai dengan kebutuhan klien/pasien. Hal ini akan terlihat dari seberapa jauh kepatuhan untuk melaksanakan diet yang telah ditentukan dan pemecahan masalah yang timbul dalam melaksanakan rencana diet tersebut.

6) **Pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut terapi gizi (kunjungan ulang)**

Evaluasi terhadap pelayanan asuhan gizi rawat jalan diperoleh melalui kunjungan ulang pasien ke Poli Gizi. Evaluasi tersebut mencakup rencana diet yang diberikan dan kepatuhan menjalankan rencana diet, klinis dan laboratorium, dan status gizi. Tindak lanjut yang dibutuhkan tergantung hasil evaluasi pelayanan gizi yang diperoleh di rumah, bila perlu dilakukan perubahan rencana diet atau kunjungan rumah.

7) **Alur pelayanan konseling gizi di Rawat Jalan**

Pasien Rawat Jalan → Poliklinik → Skrining gizi awal oleh perawat
→ Pasien malnutrisi & kondisi khusus dikirim ke gizi →
Konseling gizi

b. **Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap**

Pengertian dari asuhan gizi pasien rawat inap adalah serangkaian proses kegiatan pelayanan gizi yang berkesinambungan dimulai dari perencanaan diet hingga evaluasi rencana diet pasien di ruang rawat inap. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada pasien rawat inap agar memperoleh gizi yang sesuai dengan kondisi penyakit, dalam upaya mempercepat proses penyembuhan. Mekanisme pelayanan gizi rawat inap tahapan pelayanan diawali dengan skrining oleh perawat ruang IGD dan penetapan order diet awal oleh dokter. Skrining gizi bertujuan untuk mengidentifikasi pasien yang beresiko, tidak beresiko malnutrisi atau kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksud adalah pasien dengan kelainan metabolik, hemodialisis, anak geriatic, kanker dengan kemoterapi / luka bakar.

Skrining dilakukan pada pasien baru 1x24 jam setelah pasien masuk RS oleh perawat IGD. Bila hasil skrining gizi menunjukkan pasien beresiko malnutrisi, maka dilakukan assesmen/pengkajian lanjut oleh ahli gizi dengan langkah PAGT. Pasien dengan status gizi baik atau tidak beresiko malnutrisi, dianjurkan dilakukan skrining ulang setelah 1 minggu.

Rangkaian kegiatannya:

1) **Pengkajian status gizi**

a) **Antropometri**

Setiap pasien diukur data antropometri, berupa tinggi badan atau panjang badan dan berat badan. Bila tidak memungkinkan pasien diukur tinggi badan atau panjang badan dan berat badan, dapat dilakukan pengukuran lingkaran lengan atas (LiLa) dan tinggi lutut.

b) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan klinis yang berhubungan dengan gangguan gizi atau untuk menentukan hubungan sebab akibat antara status gizi dengan kesehatan, serta menentukan terapi obat dan diet. Pemeriksaan fisik meliputi: tanda-tanda klinis kurang gizi (sangat kurus, pucat, atau bengkak) atau gizi lebih (gemuk atau sangat gemuk/obesitas); sistem kardiovaskuler; sistem pernapasan, sistem gastrointestinal; sistem metabolik/endokrin dan sistem neurologik/psikiatrik.

c) Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan biokimia dalam rangka mendukung diagnosa penyakit serta menegaskan masalah gizi klien/pasien. Pemeriksaan ini dilakukan juga untuk menentukan intervensi gizi dan memonitor/mengevaluasi terapi gizi.

2) Riwayat gizi

Setiap pasien rawat inap dianalisis kebiasaan makan sebelum dirawat yang meliputi asupan zat gizi, pola makan, bentuk dan frekuensi makan, serta pantangan makan. Asupan zat gizi diukur dan selanjutnya dianalisis zat gizinya dengan menggunakan Daftar Bahan Makanan Penukar. Analisis asupan gizi memberikan informasi perbandingan antara asupan dengan kebutuhan gizi dalam sehari. Setiap pasien rawat inap akan dianamnesis untuk mengetahui asupan makanan sebelum dirawat yang meliputi asupan zat gizi, pola makan, bentuk dan frekuensi makan, serta pantangan makan. Semua data antropometri, klinis dan biokimia yang didapat dicatat dalam formulir pencatatan gizi. Kajian riwayat gizi hasilnya akan dibandingkan dengan perhitungan kebutuhan gizi dan saran diet sesuai kondisi pada saat melakukan konseling.

3) Penentuan kebutuhan gizi

Penentuan kebutuhan gizi diberikan kepada klien/pasien atas dasar status gizi, pemeriksaan klinis, dan data laboratorium. Selain itu perlu juga memperhatikan kebutuhan untuk penggantian zat gizi, kebutuhan harian, kebutuhan tambahan karena kehilangan serta tambahan untuk pemulihan jaringan atau organ yang sedang sakit.

4) Penentuan macam dan jenis diet

Setelah dokter menentukan diet pasien, ahli gizi akan mempelajari dan menyusun rencana diet dan bila sudah sesuai, selanjutnya akan menterjemahkan ke dalam menu dan porsi makanan serta frekuensi makan yang akan diberikan. Makanan diberikan dalam berbagai bentuk,/ konsistensi (biasa, lunak, maupun cair) sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan zat gizi yang dibutuhkan serta macam dan jumlah bahan makanan yang digunakan. Apabila dari rencana diet tersebut diperlukan penyesuaian, maka ahli gizi akan mengkonsultasikan kepada dokter.

5) Konseling dan Penyuluhan gizi

Sebelum melakukan kegiatan konseling gizi, terlebih dahulu dibuat rencana konseling yang mencakup penetapan tujuan, sasaran, strategi, materi, metode, penilaian, dan tindak lanjut. Tujuan konseling gizi adalah membuat perubahan perilaku makan pasien. Hal ini diwujudkan melalui penjelasan diet yang perlu dijalankan oleh pasien, yang diperlukan untuk proses

penyembuhan, kepatuhan pasien untuk melaksanakan diet yang ditentukan, dan pemecahan masalah yang timbul dalam melaksanakan diet tersebut.

6) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut

Aktivitas utama dari proses evaluasi pelayanan gizi pasien adalah memantau pemberian makanan secara berkesinambungan untuk menilai proses penyembuhan dan status gizi pasien. Pemantauan tersebut mencakup antara lain perubahan diet, bentuk makanan, asupan makanan, toleransi terhadap makanan yang diberikan, mual, muntah, keadaan klinis defekasi, hasil laboratorium, dan lain-lain.

Tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil evaluasi pelayanan gizi antara lain perubahan diet, yang dilakukan dengan mengubah perskripsi diet sesuai kondisi pasien. Apabila perlu, dilakukan kunjungan ulang atau kunjungan rumah. Untuk pasien yang dirawat walaupun tidak memerlukan diet khusus tetapi tetap perlu mendapatkan perhatian agar tidak terjadi "*Hospital Malnutrition*" terutama pada pasien-pasien yang mempunyai masalah dalam asupan makanannya seperti adanya mual, muntah dan penurunan nafsu makan.

7) Pencatatan Pelaporan

Pencatatan dan laporan kegiatan asuhan gizi merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan dan komunikasi. Terdapat berbagai cara dalam dokumentasi antara lain Subjective Objective Assessment Planning (SOAP) dan Assessment Diagnosis Intervensi Monitoring & Evaluasi (ADIME). Format ADIME merupakan model yang sesuai dengan langkah PAGT.

5.2 PELAYANAN MAKANAN DI RUMAH SAKIT

1. Pengertian

Pelayanan makanan rumah sakit adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada konsumen dalam rangka pencapaian status kesehatan yang optimal melalui pemberian diet yang tepat. Termasuk kegiatan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi.

2. Tujuan

Pelayanan makanan di rumah sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan makanan yang kualitasnya baik dan jumlah yang sesuai kebutuhan serta pelayanan yang layak dan memadai bagi klien atau konsumen yang membutuhkan.

3. Sasaran

Sasaran pelayanan makanan di Rumah Sakit Prima Husada adalah pasien, pengunjung (pasien rawat jalan atau keluarga pasien yang mengunjungi kantin).

4. Bentuk pelayanan makanan di Rumah Sakit Prima Husada

Bentuk pelayanan makanan di Rumah Sakit Prima Husada adalah dengan sistem swakelola, sehingga melaksanakan semua kegiatan pelayanan makanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

5. Mekanisme kerja pelayanan makanan di Rumah Sakit Prima Husada

Mekanisme kegiatan pelayanan makanan di Rumah Sakit Prima Husada meliputi:

a. Perencanaan Menu

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu yang akan diolah untuk memenuhi selera konsumen pasien, dan kebutuhan zat gizi yang memenuhi prinsip gizi seimbang.

Tujuannya untuk menyediakan siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di rumah sakit, yaitu siklus menu 10 hari.

Langkah perencanaan menu:

- 1) Membentuk tim kerja untuk menyusun menu yang terdiri dari ahli gizi dan kepala dapur
- 2) Mengumpulkan tanggapan/keluhan konsumen mengenai menu dengan cara menyebarkan kuesioner
- 3) Membuat jumlah konsumen yang akan dilayani
- 4) Mengumpulkan data peralatan dan perlengkapan dapur yang tersedia
- 5) Menyesuaikan penyusunan menu dengan macam dan jumlah tenaga
- 6) Menetapkan siklus menu yang akan dipakai
- 7) Menetapkan standar porsi
- 8) Menyusun menu dengan cara:
 - a) Mengumpulkan berbagai jenis hidangan, dikelompokkan berdasarkan jenis makanan (kelompok lauk hewani, kelompok nabati, kelompok sayuran, kelompok buah) sehingga memungkinkan variasi yang lebih banyak
 - b) Menyusun pola menu yang memuat garis besar frekuensi penggunaan bahan makanan harian dengan siklus menu yang berlaku
 - c) Memasukkan hidangan hewani yang serasi warna, komposisi, konsistensi bentuk dan variasinya, kemudian lauk nabati, sayur, buah, dan snack
 - d) Menilai menu dengan beberapa penilaian objektif
 - e) Melakukan pre-test untuk mengetahui tanggapan konsumen/pasien

b. Perhitungan kebutuhan bahan makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah kegiatan penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan

Tujuannya adalah supaya tercapainya usulan anggaran dan kebutuhan bahan makanan untuk pasien dalam satu tahun anggaran

Langkah perencanaan kebutuhan bahan makanan adalah:

- 1) Menentukan jumlah pasien
- 2) Menentukan standar porsi tiap bahan makanan dan membuat dalam berat kotor

Menghitung berapa kali pemakaian bahan makanan serta siklus menu

c. Perencanaan anggaran belanja makanan

Perencanaan anggaran belanja makanan adalah suatu kegiatan penyusunan anggaran biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi konsumen/pasien yang dilayani

Tujuannya adalah untuk menyediakan taksiran anggaran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan bagi konsumen/pasien yang dilayani sesuai dengan standar kecukupan gizi.

Langkah perencanaan anggaran belanja makanan:

- 1) Menetapkan macam dan jumlah konsumen/pasien
- 2) Mengumpulkan harga bahan makanan dari beberapa pasar dengan melakukan survey pasar, kemudian menentukan harga rata-rata bahan makanan
- 3) Membuat standar porsi ke dalam berat kotor
- 4) Menghitung indeks harga makanan perorangan perhari sesuai dengan konsumen yang mendapat makanan
- 5) Menghitung anggaran belanja makanan setahun untuk masing-masing konsumen/pasien
- 6) Melaporkan hasil perhitungan anggaran dilaporkan kepada manajemen

d. Pemesanan dan pembelian bahan makanan

Pemesanan dan pembelian bahan makanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu atau pedoman menu dan rata-rata jumlah konsumen atau pasien yang dilayani. Tujuannya adalah untuk menyediakan daftar pesanan bahan makanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan.

e. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran bahan makanan

1) Penerimaan dan pemilahan bahan makan

Penerimaan bahan makan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan, dan pelaporan tentang macam, kualitas, dan kuantitas bahan makanan yang diterima sesuai dengan pesanan serta spesifikasi yang telah ditetapkan

Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan makanan yang siap untuk diolah.

Langkah penerimaan dan pemilahan bahan makanan:

a) Bahan makanan mentah (segar) yaitu makanan yang perlu pengolahan sebelum dihidangkan seperti :

1. Daging, susu, telur, ikan/udang, buah dan sayuran harus dalam keadaan baik, segar dan tidak rusak atau berubah bentuk, warna dan rasa, serta sebaiknya berasal dari tempat resmi yang diawasi.
2. jenis tepung dan biji-bijian harus dalam keadaan baik, tidak berubah warna, tidak bernoda dan tidak berjamur.
3. makanan fermentasi yaitu makanan yang diolah dengan bantuan mikroba seperti ragi atau cendawan, harus dalam keadaan baik, tercium aroma fermentasi, tidak berubah warna, aroma, rasa serta tidak bernoda dan tidak berjamur.

b) Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dipakai harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

c) Makanan olahan pabrik yaitu makanan yang dapat langsung dimakan tetapi digunakan untuk proses pengolahan makanan lebih lanjut yaitu :

1. Makanan dikemas
 - a. Mempunyai label dan merk
 - b. Terdaftar dan mempunyai nomor daftar
 - c. Kemasan tidak rusak/ pecah atau kembung
 - d. Belum kadaluwarsa
 - e. Kemasan digunakan hanya sekali pemakaian
2. Makanan Tidak Dikemas
 - a. Baru dan segar
 - b. Tidak basi, busuk, rusak, atau berjamur

c. Tidak mengandung bahan berbahaya

2) Penyimpanan bahan makanan

Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporannya

Tujuannya untuk menyediakan bahan makanan siap pakai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan perencanaan

Langkah penyimpanan bahan makanan:

- a) Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, harus segera dibawa ke ruang penyimpanan, gudang, atau ruang pendingin
- b) Apabila bahan makanan langsung akan digunakan, setelah ditimbang dan diawasi oleh bagian penyimpanan bahan makanan setempat dibawa ke ruang persiapan bahan makanan

Langkah penyimpanan bahan makanan kering:

- a) Bahan makanan ditempatkan secara teratur menurut macam, golongan, ataupun urutan pemakaian bahan makanan
- b) Menggunakan bahan makanan yang diterima terlebih dahulu (FIFO= First In First Out).
- c) Gudang dibuka pada waktu yang telah ditentukan.
- d) Semua bahan makanan ditempatkan dalam tempat tertutup, terbungkus rapat dan tidak berlubang. Diletakkan di atas rak bertingkat dan tidak menempel pada dinding.
- e) Pintu selalu terkunci pada saat tidak ada kegiatan serta dibuka pada waktu-waktu yang ditentukan. Pegawai yang masuk-keluar gudang juga hanya pegawai yang ditentukan
- f) Suhu ruangan kering, berkisar antara 25-26° C
- g) Pembersihan ruangan dilakukan secara periodik, 2 kali seminggu
- h) Semua lubang di gudang berkasa, serta bila terjadi pengrusakan oleh binatang pengerat segera diperbaiki

Langkah penyimpanan bahan makanan basah:

- a) Suhu tempat disesuaikan dengan keperluan bahan makanan, agar tidak rusak
- b) Pengecekan terhadap suhu dilakukan 2 kali sehari dan pembersihan lemari es dilakukan setiap hari
- c) Pencairan es pada lemari es segera dilakukan setelah terjadi pengerasan
- d) Semua bahan yang akan dimasukkan ke lemari pendingin dibungkus plastik
- e) Tidak menempatkan bahan makanan yang berbau keras bersama bahan makanan yang tidak berbau
- f) Suhu penyimpanan sayuran sangat diperhatikan. Sedangkan buah-buahan diperhatikan sifat buahnya sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin

Tabel 7. Penyimpanan bahan makanan basah/segar :

No.	Jenis bahan makanan	Lama waktu penyimpanan		
		< 3 hari	<1 minggu	>1 minggu
1.	Daging, ikan, udang, dan hasil olahannya	-5 – 0 °C	-10 – -5°C	< - 10 °C

No.	Jenis bahan makanan	Lama waktu penyimpanan		
		< 3 hari	<1 minggu	>1 minggu
2.	Telur, buah, dan hasil olahannya	5 – 7 °C	-5 – 0 °C	< -5 °C
3.	Sayur, buah, dan minuman	10 °C	10 °C	10 °C
4.	Tepung dan biji-bijian	25 °C	25 °C	25 °C

Tabel 8. Standart Penyimpanan Bahan Makanan Basah dan Kering :

1.	Daging merah dengan penyimpanan suhu -5 - 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 - -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu. Dengan penyimpanan kering (15-25°C) Tidak dianjurkan. Daging kaleng penyimpanan di lemari es (0-4°C) bertahan 1 tahun.
2.	Ikan dengan penyimpanan suhu -5 - 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 – -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu. Penyimpanan di Lemari es (0-4°C) bertahan 2-3hari. Penyimpanan di freezer (-18°C) bertahan 3-6 bulan.
3.	Udang dengan penyimpanan suhu -5 - 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 - -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu
4.	Suhu penyimpanan yang baik pangan olahan Daging dan Ikan:
	✓ Nugget dengan penyimpanan suhu -5 - 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 - -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu
	✓ Bakso dengan penyimpanan suhu -5 - 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 - -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu
	✓ Sosis dengan penyimpanan suhu -5 – 0°C bertahan <3 hari, pada suhu -10 - -5°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -10°C bertahan > 1 minggu
5.	Susu murni/segar penyimpanan pada suhu 2°C - 7°C (mikroba terhambat pertumbuhannya dan kerja enzim menjadi tidak aktif) sedangkan penyimpanan pada suhu ruangan akan mempercepat pertumbuhan bakteri dan berakibat pada semakin cepatnya kerusakan Susu
6.	Suhu penyimpanan yang baik pangan olahan susu :
	✓ Yougurt penyimpanan pada suhu 2°C - 7°C
	✓ Yakult penyimpanan pada suhu 2°C - 7°C
	✓ Keju penyimpanan pada suhu 2°C - 7°C
7.	Daya tahan susu murni/segar :
	✓ 5 – 8 jam untuk susu yang telah diperah, belum dipasteurisasi dan disimpan pada suhu normal ruangan
	✓ 12 jam untuk susu yang telah dipasteurisasi dan disimpan dalam suhu normal dan kondisi terbuka
	✓ 2 – 3 hari : untuk susu yang telah dipasteurisasi kemudian didinginkan segera dan disimpan tertutup rapat di dalam kulkas (rak paling atas atau tempat keluarnya udara dingin
	✓ 3 – 5 hari untuk susu yang telah dipasteurisasi kemudian didinginkan segera dan disimpan tertutup rapat di dalam freezer
8.	Telur dengan penyimpanan suhu 5 - 7°C bertahan <3 hari, pada suhu -5 - 0°C bertahan <1 minggu, pada suhu < -5°C bertahan > 1 minggu. Penyimpanan kering (15-25°C) bertahan 7 hari.
9.	Buah dengan penyimpanan di lemari es (0-4°C) bertahan 5-7 hari, penyimpanan di freezer tidak dianjurkan. Buah dalam kemasan kaleng

	disimpan di penyimpanan kering (15-25°C) bertahan 12 bulan. Buah dalam kondisi kering bertahan 2 minggu di penyimpanan kering (15-25°C).
10.	Sayur dengan penyimpanan di lemari es (0-4°C) bertahan 5-7 hari, penyimpanan di freezer tidak dianjurkan. Sayur dalam kemasan kaleng disimpan di penyimpanan kering (15-25°C) bertahan 12 bulan. Sayur dalam kondisi kering bertahan 2 minggu di penyimpanan kering (15-25°C).
11.	Tepung dengan penyimpanan suhu 25°C bertahan <3 hari, pada suhu 25°C bertahan <1 minggu, pada suhu 25°C bertahan > 1 minggu
12.	Biji-bijian atau produk cereal dilakukan di penyimpanan kering (15-25°C) bertahan 2 bulan.

ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga bahan makanan beku tetap layak untuk digunakan saat listrik padam, yakni :

- a) Tidak membuka pintu kulkas dan *freezer*. Dalam keadaan tidak ada listrik, *freezer* dapat menahan suhu selama 48 jam sementara kulkas akan menjaga makanan dingin selama 4 jam. Hal ini berlaku dengan catatan semua pintu harus tertutup rapat.
- b) Melakukan pengecekan suhu di dalam kulkas dan freezer. Jika listrik sudah padam lebih dari 2 jam dan suhu di dalam lemari es serta *freezer* mencapai diatas 4°C, sebaiknya buang makanan di dalamnya. Dikarenakan suhu tersebut dapat membuat bahan makanan seperti daging, ayam, makanan laut, dan juga telur membusuk.
- c) Makanan yang sudah cair bisa dibekukan kembali, dengan catatan, jika makanan beku di dalam kulkas sudah terlanjur mencair dapat membekukannya kembali ketika listrik menyala dan makanan tersebut masih mengandung kristal es atau memiliki suhu lebih rendah dari 4°C.

3) Penyaluran bahan makanan

Penyaluran bahan makanan adalah tata cara mendistribusikan bahan makanan berdasarkan permintaan harian.
Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan makanan siap pakai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan pesanan

f. Persiapan bahan makanan

Persiapan bahan makanan adalah serangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan, yaitu meliputi berbagai proses antara lain membersihkan, memotong, mengupas, mengocok, merendam, dan sebagainya.

Tujuannya adalah mempersiapkan bahan-bahan makanan, serta bumbu-bumbu sebelum dilakukan kegiatan memasak.

g. Pengolahan bahan makanan

Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan mengubah (memasak) bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Pengolahan makanan harus selalu menggunakan alat pelindung kerja untuk menghindari kecelakaan kerja selama melakukan proses pengolahan.

Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kehilangan zat-zat gizi bahan makanan, meningkatkan nilai cerna, meningkatkan dan mempertahankan warna, rasa, keempukan, dan penampilan makanan, dan menghilangkan dari organisme maupun zat yang berbahaya bagi tubuh.

Kontaminasi silang, terutama dari makanan mentah ke makanan yang sudah dimasak adalah salah satu sumber infeksi makanan. Kontaminasi silang dapat juga disebabkan oleh tangan yang terkontaminasi, permukaan meja, papan alas untuk memotong makanan, ataupun kain yang digunakan untuk mengelap permukaan meja atau mengeringkan piring. Selain itu, permukaan yang digunakan untuk menyiapkan makanan; alat makan, perlengkapan masak, panci, dan wajan yang digunakan untuk menyiapkan makanan dan juga nampan, piring, serta alat makan yang digunakan untuk menyajikan makanan juga dapat menimbulkan risiko infeksi apabila tidak dibersihkan dan disanitasi secara tepat.

Proses pemasakan yang dilakukan di Rumah Sakit Prima Husada adalah:

- 1) Pemasakan dengan medium udara, yaitu membakar/mengepan dan memanggang
- 2) Pemasakan dengan medium air, yaitu merebus, mengetim, mengukus, dan menggunakan tekanan uap (presto)
- 3) Pemasakan dengan medium minyak, yaitu menggoreng, menumis
- 4) Pemasakan langsung melalui dinding panci, yaitu mendadar dan menyangrai

Resiko Kontaminasi makanan, ada beberapa jenis kerusakan bahan makanan yaitu :

- a)Kerusakan mikrobiologis: kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme
- b)Kerusakan mekanis: kerusakan yang diakibatkan oleh adanya gesekan atau tekanan saat panen, penyimpanan atau distribusi
- c)Kerusakan fisik: kerusakan yang diakibatkan oleh insekta atau rodentia, kondisi lingkungan seperti suhu, sinar matahari.
- d)Kerusakan biologis: kerusakan yang diakibatkan oleh respirasi bahan pangan
- e)Kerusakan kimia: kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi kimia seperti reaksi oksidasi, hidrolisis, reaksi enzimatis

A. Kerusakan Mikrobiologis

1. Jamur

- a. Jamur dapat memanfaatkan berbagai senyawa untuk hidupnya, dan memerlukan oksigen agar dapat hidup (bersifat aerob).
- b. Rentang suhu optimalnya (suhu terbaik dimana pertumbuhan jamur dapat maksimal) adalah 20-35°C.
- c. Jamur masih tumbuh dalam refrigerator, yaitu suhu antara 10-15°C. Jamur dan sporanya dapat mati pada suhu 100°C, atau pada suhu 71-82°C dalam waktu yang cukup.
- d. Cahaya matahari dapat menghambat pertumbuhan sebagian jamur, tetapi ada juga yang tumbuh dalam cahaya terang.

Bahan-bahan yang biasa diserang jamur, antara lain:

- a. Bahan-bahan yang bergula, contohnya: selai
- b. Bahan hewani, contohnya daging, keju, mentega
- c. Bahan segar, sayuran dan buah

Ada jenis jamur yang berbahaya, yaitu Aspergillus flavus, yang menghasilkan aflatoksin. Jamur ini biasanya tumbuh pada kacang-kacangan. Akan tetapi, jamur juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan asam sitrat, pembuatan kecap, dan membentuk flavor pada keju.

2. Bakteri

- a. Bakteri terdapat di air, tanah, udara, dan pada makanan. Bakteri ada yang bersifat aerob maupun anaerob.
- b. Salah satu peranan bakteri menguntungkan adalah kemampuannya dalam menghasilkan flavor yang disukai.
- c. Misalnya bau laktat pada mentega, cita rasa asinan pada sayuran, dan flavor keju.
- d. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa bakteri dapat pula menghasilkan senyawa yang berbahaya bagi kesehatan
- e. Suhu optimumnya (secara general) adalah 20-55°C, dengan kandungan air sebesar 25-30%.
- f. Klasifikasi bakteri :
 - 1) Bakteri termofil : > 45°C
 - 2) Bakteri psikrofil : < 10°C
 - 3) Bakteri mesofil : 20-45°C
- g. Low Acid Food (makanan dengan pH <4,5) lebih mudah diawetkan karena bakteri dan spora lebih mudah mati.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya mikroorganisme

- a. Nutrisi : Unsur dasar yang dibutuhkan mikroba → C, N, H, O₂, S, F, M, Fe dan logam lainnya.
- b. Waktu, Suhu, pH, Ketersediaan oksigen, Aw, Senyawa kimia, Radiasi

B. Kerusakan Mekanis

1. Ciri-ciri umum kerusakan mekanis :
 - a. Memar akibat tertindih atau tertekan
 - b. Sobek
 - c. Terpotong
 - d. Pecah
 - e. Hancur
2. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan lama penggetaran berpengaruh nyata terhadap peningkatan rata-rata nilai kerusakan mekanis, susut berat, tingkat kelunakan dan laju respirasi pada buah pisang.
3. Tingkat kerusakan mekanis pada buah pisang mencapai 100% pada lama penggetaran selama 6-12 jam

C. Kerusakan Fisik

1. Insekta, parasit atau tikus → berlubang, ada bekas gigitan
2. Suhu tinggi → memar, lembek
3. Kelembaban relatif → rendah dapat menyebabkan kehilangan air. Kalau kehilangan air dari dalam produk yang telah dipanen jumlahnya relatif masih kecil mungkin tidak akan menyebabkan kerugian atau dapat ditolerir, tetapi apabila kehilangan air tersebut jumlahnya banyak akan menyebabkan hasil panen yang diperoleh menjadi layu dan bahkan dapat menyebabkan produk hortikultura menjadi mengkerut.
4. Udara/oksigen
5. Sinar matahari

D. Kerusakan Biologis

- 1. Respirasi adalah suatu proses pertukaran gas yang melibatkan proses metabolisme perombakan senyawa makromolekul (karbohidrat, protein, lemak) menjadi CO₂, air dan sejumlah energi.
- 2. Laju respirasi yang sangat cepat → mempercepat proses kebusukan
- 3. Laju dari proses respirasi dalam produk hortikultura akan menentukan daya tahan dari produk tersebut baik buah-buahan maupun sayur-sayuran yang telah dipanen,
- 4. sehingga ada produk yang tahan disimpan lama setelah dipanen seperti pada biji-bijian, umbi-umbian tetapi banyak tidak tahan disimpan lama, seperti pada produk buah-buahan yang berdaging maupun produk hortikultura yang lunak-lunak seperti sayur-sayuran daun.

Kebusukan Bahan Makanan merupakan perubahan karakteristik fisik dan kimiawi suatu bahan makanan yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari karakteristik normal. Kerusakan bahan pangan akan berakibat kebusukan.

Ciri-ciri Kebusukan pada Bahan Pangan :

- 1. Bau tidak sedap
- 2. Perubahan bentuk secara drastis
- 3. Kehilangan daya tarik
- 4. Perubahan nilai gizi → merugikan

Kebusukan bahan pangan atau makanan dapat berlangsung secara cepat atau lambat, tergantung dari :

- 1. Jenis bahan pangan atau makanan yang bersangkutan
- 2. Kondisi lingkungan penyimpanan.

h. Pendistribusian makanan

Pendistribusian makanan adalah serangkaian kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah porsi dan jenis makanan konsumen yang dilayani (makanan biasa maupun makanan khusus).Tujuannya supaya konsumen mendapatkan makanan sesuai diet dan ketentuan yang berlaku. Selama proses pendistribusian di dampingi oleh ahli gizi sebagai *Quality control* (QC) tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian diet pasien dan tidak terjadi ketidak sesuaian dalam pembagian porsi diet pasien.

Jenis penyaluran makanan yang digunakan di Rumah Sakit Prima Husada adalah penyaluran makanan dan minuman didistribusikan secara terpusat, yaitu di dapur *central*.

Upaya mengurangi resiko infeksi pada pelayanan gizi. Jadwal pemberian makanan harus tidak bersamaan dengan jam pembagian linen / jam pembuangan sampah hal ini termasuk upaya untuk mengurangi resiko infeksi lewat makanan.

Tabel 9. Jadwal pemberian makanan di rawat inap :

Pembagian makan	Rentang waktu
Pagi	06.30 – 07.30 wib
Siang	12.00 – 12.30 wib
Sore	16.30 - 17.30 wib
Snack	09.00 – 09.30 wib

Tabel 10. Jadwal pemberian makanan maksimal pada pasien baru :

Pembagian makan	Batas Waktu Pembagian Makan
Pagi	08.00 wib
Siang	13.00 wib
Sore	18.00 wib
Snack	10.00 wib

Keterangan : Apabila terdapat pasien baru datang di Instalasi Gawat Darurat (IGD) ataupun pasien baru datang dengan rencana operasi (Pasien Loadingan) tetapi masih diperbolehkan makan. Maka akan diberikan dengan maksimal waktu yang telah ditentukan. Jika pasien datang melebihi batas maksimal waktu pemberian makanan maka ahli gizi/ perawat yang bertugas memberikan edukasi pemberian makan di jam makan berikutnya.

Rentan waktu dari pengolahan makanan ke pendistribusian kepada pasien dilakukan dengan kondisi suhu $>60^{\circ}\text{C}$, dan untuk makanan yang belum segera disajikan dengan suhu -10°C dan tidak lebih dari 4 jam setelah makanan matang, karena jika dilakukan pendistribusian dibawah suhu $<60^{\circ}\text{C}$ dan makanan disajikan lebih dari 4 jam merupakan danger zone yang dimana memungkinkan bakteri berkembang biak pada makanan. Apabila pendistribusian tetap diberikan maka bisa menimbulkan resiko infeksi / *foodborne disease*.

- i. Alur Pemesanan diet pasien
 - 1) DPJP menuliskan diet di CPPT
 - 2) Perawat menyampaikan diet pasien ke ahli gizi
 - 3) Ahli gizi menerima pesanan diet perawat dan ahli gizi mengkaji ulang untuk kepastian diet pasien
 - 4) Ahli gizi menetapkan diet pasien
 - 5) Ahli gizi menulis dibuku daftar diet
 - 6) Ahli gizi yang bertugas *quality control* menulis di form pemesanan diet dan memastikan kebenaran diet pasien

5.3 TERAPI GIZI TERINTEGRASI

Proses pelayanan dan asuhan pasien bersifat dinamis dan melibatkan banyak PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yang dapat melibatkan berbagai unit pelayanan. Integrasi dan koordinasi kegiatan pelayanan dan asuhan pasien merupakan sasaran yang menghasilkan efisiensi, penggunaan SDM dan sumber lainnya efektif, dan hasil asuhan pasien yang lebih baik.

Proses perencanaan bersifat kolaboratif menggunakan data berasal dari asesmen awal dan asesmen ulang yang dilakukan oleh dokter dan PPA lainnya (perawat, ahli gizi, apoteker, dsb.) untuk mengetahui dan menetapkan prioritas tindakan, prosedur, dan asuhan PPA lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Pasien pada asesmen awal diskriminasi untuk risiko nutrisi. Pasien ini dikonsultasikan ke ahli gizi untuk dilakukan asesmen lebih lanjut. Jika ditemukan risiko nutrisi maka dibuat rencana terapi gizi dan dilaksanakan.

Kemajuan keadaan pasien dimonitor dan dicatat di rekam medis pasien. DPJP, perawat, ahli gizi, dan keluarga pasien bekerjasama dalam konteks asuhan gizi terintegrasi. Asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi.

Pasien dan keluarga dilibatkan dalam proses perencanaan. Rencana asuhan diselesaikan dalam waktu 24 jam terhitung saat diterima sebagai pasien rawat inap. Berdasarkan atas hasil assesmen ulang, rencana asuhan diperbaharui atau disempurnakan untuk dapat menggambarkan kondisi pasien terkini. Rencana asuhan didokumentasikan di rekam medik pasien.

5.4 PELAYANAN GIZI PASIEN HIV

Sejak seseorang terinfeksi HIV, terjadi gangguan sistem kekebalan tubuh sampai ke tingkat yang lebih parah hingga terjadi pula penurunan status gizi. Salah satu faktor yang berperan dalam penurunan sistem imun adalah defisiensi zat gizi baik makro maupun gizi mikro.

Untuk mengatasi masalah gizi pada pasien HIV/AIDS, maka diberikan makanan tinggi kalori-protein, kaya vitamin dan mineral serta cukup air. Pemberian diet TKTP pada pasien HIV/AIDS rawat inap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Energi tinggi, yaitu 40 - 45 kkal/kg BB.
2. Protein tinggi, yaitu 2 - 2,5 g/kg BB.
3. Lemak cukup, yaitu 10 - 25% dari kebutuhan energi total.
4. Karbohidrat cukup, yaitu sisa dari kebutuhan energi total.
5. Vitamin dan mineral cukup, sesuai kebutuhan normal.
6. Makanan diberikan dalam bentuk mudah cerna.

Pada pasien HIV cara pelayanan gizi mulai dari persiapan bahan makanan sampai dengan pendistribusian makanan diberlakukan sama dengan pelayanan pasien lainnya, hanya yang membedakan pada proses sterilisasi peralatan makan. Untuk pasien HIV peralatan makanan harus direndam dengan air panas pada suhu $>80^{\circ}\text{C}$ selama 15 - 30 menit, kemudian cuci bersih menggunakan sabun cuci piring. Tempat makan yang digunakan pasien HIV juga berbeda dengan pasien biasanya untuk menghindari resiko infeksi antara pasien satu dengan pasien yang lainnya.

5.5 PELAYANAN GIZI PASIEN STUNTING DAN WASTING

A. Definisi Stunting dan Wasting

Malnutrisi adalah kondisi yang dapat berupa defisiensi, kelebihan dan atau ketidakseimbangan asupan energi dan zat gizi. Stunting erupakan perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan Panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 SD pada kurva pertumbuhan WHO, disebabkan kekurangan gizi kronik yang berhubungan dengan sosioekonom rendah, asupan nutrisi dan kesehatan ibu yang buruk, riwayat sakit berulang dan praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak tepat. Kurva pertumbuhan yang digunakan untuk diagnosis *stunting* adalah kurva WHO *child growth standard* tahun 2006 yang merupakan baku emas pertumbuhan optimal seorang anak.

Stunting selalu diawali dengan kenaikan berat badan yang tidak adekuat (*weight faltering*). *Weight faltering* yang tidak ditatalaksana secara optimal akan memperlambat laju pertumbuhan linier karena tubuh berusaha untuk mempertahankan status gizi.

B. Penyebab Stunting dan Wasting

Penyebab potensial perlambatan pertumbuhan adalah:

1. Penyebab asupan kalori yang tidak adekuat
 - a. Gastroesophageal refluks

-
- b. Pasokan ASI tidak adekuat atau perlekatan tidak efektif
 - c. Penyiapan susu formula yang salah
 - d. Gangguan mekanik dalam menyusui (celah bibir/langit-langit)
 - e. Penelantaran atau kekerasan anak
 - f. Kebiasaan makan yang buruk
 - g. Gangguan koordinasi neuromotor oral
 - h. Gangguan gastrointestinal yang diinduksi toksin (misal peningkatan kadar timbal menyebabkan anoreksia, konstipasi, atau nyeri perut)
2. Absorpsi yang tidak adekuat
 - a. Anemia defisiensi besi
 - b. Atresia bilier
 - c. Gangguan gastrointestinal kronis (misal *irritable bowel syndrome*), infeksi
 - d. Fibrosis kistik
 - e. Kelainan metabolisme bawaan
 - f. Alergi susu sapi
 - g. Kolestasis, penyakit hati
 3. Peningkatan Metabolisme
 - a. Infeksi kronik (HIV-AIDS, TBC)
 - b. Kelainan jantung bawaan
 - c. Penyakit paru kronik (pada bayi dengan riwayat prematur)
 - d. Keganasan
 - e. Gagal ginjal
 - f. Hipertiroid
 - g. Kondisi inflamasi (misal asma, *inflammatory bowel disease*)
- C. Dampak Stunting dan Wasting
- Stunting* akan memengaruhi perkembangan otak jangka panjang yang selanjutnya berdampak pada kemampuan kognitif dan prestasi sekolah. Selain itu, gangguan pertumbuhan linear akan memengaruhi daya tahan tubuh dan kapasitas kerja. Efek jangka panjang juga berhubungan dengan penurunan kemampuan oksidasi lemak sehingga menyebabkan risiko mengalami obesitas dan penyakit-penyakit degeneratif antara lain hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit-penyakit kardiovaskular.
- D. Diagnosis
1. Anamnesa

Keluhan utama pada anamnesis adalah anak lebih pendek dibandingkan anak lain seusianya. Hal-hal yang harus ditanyakan pada anamnesis meliputi faktor ibu, faktor anak dan lingkungan. Faktor-faktor ibu yaitu riwayat prakonsepsi, kehamilan dan laktasi, riwayat Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) dan kelahiran prematur. Faktor anak berupa evaluasi praktik pemberian ASI dan MPASI, imunisasi, perkembangan dan riwayat penyakit infeksi berulang. Beberapa penyakit infeksi berhubungan dengan kejadian *stunting* yaitu HIV-AIDS, sifilis, diare, tuberkulosis dan penyakit infeksi saluran pernapasan.
 2. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik utama pada *stunting* berupa pengukuran antropometrik terdiri dari Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB), Lingkar Kepala (LK) dan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U). Pemeriksaan spesifik sistem organ tubuh dilakukan secara menyeluruh termasuk pemeriksaan perkembangan untuk mencari adanya *red flags* penyebab organik pada *stunting*.
 3. Kriteria Antropometrik

Kriteria antropometrik *stunting* adalah berdasarkan indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin (PB/U atau TB/U) <-2 SD berdasarkan kurva WHO 2006 untuk anak 0-5 tahun.

Rekomendasi WHO mengenai pengukuran antropometrik pada bayi

dan anak, terutama di bawah 5 tahun, terdiri dari:

a. Pengukuran Berat Badan

1) Persiapan, yaitu:

- a) Tunjukkan timbangan kepada orang tua/pengasuh dan jelaskan bahwa alat tersebut yang akan digunakan dan beri tahu orang tua/pengasuh bahwa bantuan mereka mungkin diperlukan.
- b) Tempatkan timbangan pada permukaan keras dan rata. Pastikan pencahayaan cukup untuk membaca tampilan timbangan, namun jangan letakkan langsung di bawah panas karena dapat merusak timbangan. Pastikan permukaan timbangan bersih sebelum menimbang. Saat tidak digunakan, pastikan timbangan tertutup dan terlindung dari debu dan kerusakan.
- c) Minta bantuan orang tua/pengasuh untuk melepaskan kaus kaki, sepatu, pakaian dan popok bayi dan anak sebelum menimbang. Pada anak lebih besar dapat menggunakan celana dalam.

2) Cara Penggunaan Alat

a) Timbangan Tidur Digital

- (1) Nyalakan timbangan dengan menekan tombol START (atau ikuti petunjuk). Tunggu hingga angka 0.000 muncul pada layar.
- (2) Letakkan bayi dengan lembut sampai punggung bayi berada di tengah papan timbangan dengan bantuan orangtua/pengasuh untuk membantu menenangkan bayi jika mulai menangis/bergerak. Tetap dekat dengan bayi dan pastikan bayi tidak terjatuh.
- (3) Baca berat bayi dengan keras yang terdapat pada tampilan digital saat angka tidak lagi berubah dan saat bayi diam.
- (4) Asisten terlatih mencatat dan melakukan plot BB bayi yang terdekat dengan 10 gram.
- (5) Periksa kembali BB yang direkam atau diplot agar lebih akurat.

b) Timbangan Berdiri Digital

- (1) Pastikan timbangan berada di skala nol. Metode yang digunakan bisa berbeda tergantung jenis timbangan. Beberapa timbangan dapat diubah ke nol dengan menutupi panel surya selama satu detik. Ketika tampilan 0.00 maka timbangan siap digunakan. Jenis timbangan lain perlu diinjak terlebih dahulu.
- (2) Minta orangtua/pengasuh atau asisten terlatih untuk membantu memposisikan anak di tengah timbangan

dan bantu menjaga anak agar tetap tenang.

- (3) Tunggu hingga BB ditampilkan dan sudah tidak berubah pada tampilan.
- (4) Baca berat anak dengan keras hingga 10 gram terdekat dan asisten terlatih mencatat dan melakukan plot BB anak.
- (5) Bantu keluarkan anak dari timbangan dengan hati-hati dan kembalikan ke orang tua/pengasuh.
- (6) Periksa kembali BB yang direkam atau diplot agar lebih akurat.

b. Pengukuran Tinggi/Panjang Badan

1. Persiapan, yaitu:

- (1) Tunjukkan papan pengukur panjang badan (infantometer) kepada orangtua/pengasuh dan jelaskan bahwa alat tersebut yang akan digunakan. Beri tahu orangtua/pengasuh bahwa bantuan mereka mungkin diperlukan.
- (2) Minta orangtua/pengasuh untuk melepaskan sepatu dan hiasan kepala anak yang dapat mengganggu pengukuran.
- (3) Pastikan permukaan papan pengukuran bersih sebelum meletakkan bayi/ anak.
- (4) Ukur panjang badan anak di bawah usia dua tahun dengan berbaring. Jika anak usia di bawah 2 tahun diukur dengan cara berdiri maka perlu ditambahkan 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi panjang badan. Anak berusia di atas dua tahun dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan, diukur tinggi badannya sambil berdiri. Jika anak usia di atas 2 tahun diukur dengan cara telentang maka perlu dikurangi 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi tinggi badan.

2. Pemilihan dan Cara Menggunakan Alat

a. Mengukur panjang badan menggunakan papan pengukur

- (1) Letakkan papan pengukuran secara horizontal pada permukaan yang keras dan rata. Pastikan papan pengukuran stabil.
- (2) Jika papan pengukur berada di tanah/lantai, pemeriksa berlutut di sisi kanan bawah (tempat kaki akan diletakkan). Minta asisten/orangtua untuk berlutut pada bagian alas kepala. Minta asisten/orangtua untuk meletakkan anak dengan lembut ke papan dan menopang bagian belakang kepala anak dengan tangan. Pemeriksa menopang batang tubuh anak.
- (3) Letakkan kepala anak pada alas kepala sehingga

anak melihat lurus ke atas.

- (4) Bahu anak harus menyentuh papan dan tulang belakang tidak boleh melengkung.
- (5) Jika anak bergerak, asisten/orang tua harus memberi tahu pemeriksa dan menyesuaikan kembali posisi anak.
- (6) Pastikan anak berbaring rata di tengah papan dan letakkan lutut dan kaki anak pada posisi yang benar. Terdapat tiga posisi lutut dan kaki anak yang benar
- (7) Letakkan tangan kiri pemeriksa di atas lutut anak dan tekan ke bawah dengan lembut untuk meluruskan kaki.
- (8) Periksa kembali posisi anak. Jika posisi anak sudah benar, gerakkan alas kaki ke tumit anak. Pastikan telapak kaki rata dengan jari kaki mengarah ke atas.
- (9) Bacakan panjang badan sampai 0.1 cm terdekat. Asisten terlatih mencatat dan membuat plot PB.
- (10) Angkat anak dari papan dan kembalikan ke orang tua/pengasuh.
- (11) Periksa kembali panjang badan yang diukur atau di plot agar lebih akurat.

b. Mengukur panjang badan menggunakan Stadiometer

- (1) Tempatkan papan pengukuran secara vertikal pada permukaan yang keras dan rata. Pastikan papan stabil.
- (2) Minta anak yang akan diukur untuk berdiri di tengah papan pengukuran dengan kaki rata di lantai dan punggung menempel pada papan. Saat mengukur, minta orang tua/pengasuh untuk berlutut di sisi kanan anak. Pemeriksa berlutut di sisi kiri anak.
- (3) Tentukan apakah tumit anak harus menjauhi bagian belakang papan pengukuran dengan membuat garis khayal dari ujung bahu ke tumit (garis mid-aksilaris). Garis ini harus tegak lurus (90^0) dari dasar papan pengukuran.
- (4) Angkat dagu anak sehingga mata melihat lurus ke depan.
- (5) Terdapat tiga posisi lutut dan kaki anak yang benar
- (6) Dengan bantuan asisten terlatih/orang tua, pastikan lengan anak menggantung di sisi tubuh dengan posisi bahu rata dan bokong anak menyentuh bagian belakang papan. Pada anak usia prasekolah dengan BB kurang atau normal, bagian belakang kepala,

bahu, betis dan tumit akan sepenuhnya menyentuh bagian belakang papan.

- (7) Periksa kembali posisi anak. Minta asisten terlatih untuk menggeser alas kepala ke bawah hingga menyentuh ubun-ubun kepala anak. Jika asisten tidak ada, pemeriksa sendiri yang menggeser alas kepala.
- (8) Bacakan panjang badan sampai 0.1 cm terdekat. Asisten terlatih mencatat dan membuat plot TB.
- (9) Lepaskan alas kepala dan bantu anak turun dari papan pemeriksaan.
- (10) Periksa kembali tinggi badan yang diukur atau di plot agar lebih akurat.

c. Pengukuran Lingkar Kepala

Lingkar kepala diukur menggunakan pita ukur pada lingkar terbesar kepala, yaitu melalui dahi tepat di atas alis, bagian atas daun telinga dan bagian belakang kepala yang paling menonjol. Lingkarkan pita ukur melalui titik-titik tersebut secara lekat (CDC 2016). Setelah diukur, lingkar kepala harus diplot ke kurva lingkar kepala Nellhaus. Lingkar kepala dikatakan normal apabila terletak di antara +2 SD hingga -2 SD, mikrosefali apabila terletak di bawah -2 SD dan makrosefali apabila terletak di atas +2 SD. Pengukuran lingkar kepala harus dilakukan setiap bulan pada usia 0-1 tahun, setiap 2 bulan pada usia 1-2 tahun dan setiap kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan pada usia selanjutnya.

4. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan jika terdapat *red flags* atau jika dari anamnesis dan pemeriksaan fisik didapatkan hal-hal yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Pemeriksaan-pemeriksaan dasar seperti pemeriksaan darah perifer lengkap, urinalisis dan feses rutin dapat dilakukan jika ada indikasi. Pemeriksaan lainnya seperti kultur urin, darah samar dan analisis feses, profil besi, elektrolit darah, fungsi ginjal, fungsi hati, hormon tiroid (termasuk skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir), eksplorasi infeksi tuberkulosis dan penyebab infeksi lain, dapat dilakukan jika ada kecurigaan klinis. Pada kecurigaan terhadap alergi susu sapi dilakukan pemeriksaan Immunoglobulin E radioallergosorbent test (IgE RAST). Dan jika ada kecurigaan terhadap kelainan metabolisme bawaan atau IEM, lakukan pemeriksaan skrining rutin kelainan metabolik yaitu Gula Darah Sewaktu (GDS), Analisis Gas Darah (AGD), senjang anion, laktat, ammonia, keton darah dan urin, profil asam amino dan *acylcarnitine*, serta asam organik urin. Pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan sesuai dengan indikasi adalah pencitraan yaitu pemeriksaan usia tulang, toraks dan pencitraan otak.

E. Tata Laksana Stunting dan Wasting

Tata laksana stunting meliputi tata laksana nutrisi dengan pemberian makan yang benar dan energi yang cukup (Protein energy ratio, 10-15%), Jadwal tidur teratur dengan waktu tidur malam mulai 21.00 untuk mencapai tidur dalam, serta melakukan olahraga/ aktivitas fisik teratur paling tidak 30-60 menit, minimal 3-5 hari dalam seminggu.

Tujuan tata laksana selanjutnya adalah mencapai kejar tumbuh (*catch-up growth*) untuk memperoleh kecepatan pertumbuhan optimal. Strategi pencapaian tujuan ini adalah dengan memberikan tata laksana nutrisi sesuai dengan langkah-langkah asuhan nutrisi pediatrik yang terdiri dari penilaian, penentuan kebutuhan nutrisi, penentuan cara/rute pemberian, pemilihan jenis makanan dan pemantauan.

a. Penilaian

Penilaian yang dilakukan meliputi anamnesis, pengukuran antropometri, pemeriksaan fisik dan penunjang.

b. Penentuan Kebutuhan

Secara umum, kebutuhan kalori pada anak yang tidak sakit kritis ditentukan berdasarkan *Recommended Dietary Allowance* (RDA) atau Angka Kecukupan Gizi (AKG). Kebutuhan total kalori dihitung berdasarkan berat badan ideal dikalikan RDA menurut usia tinggi (*height age*). Nilai RDA dapat dilihat pada tabel 11.

Untuk anak dengan status gizi buruk, kebutuhan energi mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita.

Tabel 11. Perkiraan RDA/AKG berdasarkan usia sesuai usia tinggi.

Usia	Kebutuhan Energi	
0-6 bulan	120 kkal/kg/hari	
6-12 bulan	110 kkal/kg/hari	
1-3 tahun	100 kkal/kg/hari	
4-6 tahun	90 kkal/kg/hari	
7-9 tahun	80 kkal/kg/hari	
	Laki-laki	Perempuan
10-12 tahun	60-70 kkal/kg/hari	50-60 kkal/kg/hari
12-18 tahun	50-60 kkal/kg/hari	40-50 kkal/kg/hari

c. Penentuan Cara Pemberian

Rute pemberian dapat berupa oral, enteral dan parenteral. Pemberian nutrisi melalui oral merupakan pilihan utama karena sesuai dengan proses fisiologi normal. Indikasi pemberian nutrisi enteral melalui selang adalah jika akseptabilitas tidak baik (<80%) atau terdapat kondisi medis tertentu yang menyebabkan asupan per

oral sulit atau tidak diperbolehkan.

d. Penentuan Jenis Makanan

Stunting dengan berbagai jenis status gizi diberikan PKMK secara penuh atau sebagian (oral atau per enteral) beserta makanan dengan komposisi seimbang yang mengutamakan sumber protein hewani. Pemberian PKMK harus berdasarkan indikasi dan diresepkan oleh dokter spesialis anak. Penggunaannya juga harus berada di bawah pengawasan dokter spesialis anak.

World Health Organization (WHO) merekomendasikan 10-15% dari asupan energi berasal dari protein untuk menunjang tumbuh kejar.

Bayi prematur, khususnya bayi sangat prematur (usia gestasi <32 minggu) dan bayi berat lahir sangat rendah (<1500 gram) juga membutuhkan PKMK yang dapat meningkatkan kandungan protein dan mineral ASI yang disebut *Human Milk Fortifier* (HMF) dan susu formula prematur. Meskipun keduanya dapat meningkatkan pertumbuhan dengan cepat tetapi berisiko juga mengalami kelebihan asupan energi dan protein. Berdasarkan kondisi tersebut, jika menemukan bayi BBLR atau prematur harus dirujuk dan ditatalaksana oleh dokter spesialis anak.

Tata laksana gizi buruk usia 6-59 bulan

- A. Fase Stabilisasi (hari 1 dan 2)
 - a. mencegah dan mengatasi hipoglikemia (berikan 50 ml larutan glukosa (1 sdt munjung gula pasir + 50 ml air putih) dilanjutkan dengan pemberian formula F-75 diberikan 2 jam sekali dalam 24 jam pertama
 - b. mencegah dan mengatasi hipotermi (hangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut
 - c. mencegah dan mengatasi dehidrasi (berikan resomal yaitu larutan campuran oralit WHO, gula pasir, dan mineral mix sebanyak 5-10 ml/kgBB/Jam selang seling dengan F-75 dengan takaran yang sama
- B. Fase transisi (hari 3-7) dimulai jika komplikasi medis teratasi, tidak ada hipoglikemia, nafsu makan pulih, edema berkurang. terapi dengan memberikan F-100
- C. Fase Rehabilitasi (minggu ke 2-6) pemberian makanan dengan kebutuhan energi 150-220kkal/kgBB/hari. Protein 4-6g/kgBB/hari, cairan 150-200ml/kg/B/h
- D. Fase tindak lanjut (minggu ke 7-26) pemantauan berat badan. Kurang yaitu bila kenaikan BB kurang dari 5g/Kg BB/hari. Sedang bila kenaikan BB 5-10 g/kg BB/hari. Baik yaitu bila kenaikan BB lebih dari 10g/KgBB/hari.

BAB VI

LOGISTIK

NO.	PERSEDIAAN BARANG	JUMLAH STOK BARANG MINIMAL
-----	-------------------	----------------------------

ATK		
1.	Bolpoint	12 pcs
2.	Gunting kecil	1 pcs
3.	Isi staples kecil	2 Pack
4.	Label 107	50 pack
5.	Label 109	25 pack
6.	Calculator	1 pcs
7.	Printer	1 pcs
8.	PC	1 set
9.	Tinta Printer	4 pcs
10.	Kertas Folio	1 rim
RUMAH TANGGA		
BAHAN MAKANAN KERING		
1.	Agar-agar	12 pcs
2.	Beras	10 karung
3.	Bihun	10 pcs
4.	Blue band	5 pcs
5.	Coklat bubuk	1 Kg
6.	Cuka Masak	2 botol
7.	Fermipan	2 pack
8.	Garam halus	5 pcs
9.	Gula DM Tropicana Slim	1 pack
10.	Gula Jawa Tropicana	2 botol
11.	Gula merah (jawa)	88 pcs
12.	Gula pasir	50 kg
13.	Kacang hijau	10 kg
14.	Kacang Tanah	80 kg
15.	Kemiri	1 kg
16.	Ketumbar	1 ons
17.	Kopi Nescafee sachet	48 pcs
18.	Knor	1 kg
19.	Makaroni	1 kg
20.	Meses	1 kg
21.	Minyak Goreng Kemasan 2 l	30 pcs
22.	Minyak Wijen	2 botol
23.	Merica halus	1 bal
24.	Merica utuh	500 gram
25.	Nutrijell	12 pcs
26.	Saos Raja rasa	2 botol
27.	Teh Naga bubuk	2 bal
28.	Teh Celup Naga	2 box
29.	Tepung beras	24 pcs
30.	Tepung kanji	24 pcs
31.	Tepung ketan	6 pcs
32.	Tepung panir	1 Kg

33.	Tepung Maizena	24 pcs
34.	Tepung Terigu	24 pcs
35.	Vanili bubuk	1 pack
36.	Wijen	1 kg
BAHAN MAKANAN BASAH		
1.	Asam Jawa	12 pcs
2.	Bawang bombay	5 kg
3.	Bawang Merah	5 kg
4.	Bawang prey	100 gram
5.	Bawang Putih	5 kg
6.	Bunga kol	1 kg
7.	Cabe hijau besar	500 gram
8.	Cabe merah	500 gram
9.	Cabe Rawit	1 kg
10.	Daun jeruk	1 ons
11.	Daun salam	1 ons
12.	Jamur es	1 pack
13.	Jamur kuping	500 gram
14.	Jeruk nipis	100 ons
15.	Kacang merah segar	500 gram
16.	Kentang	5 kg
17.	Kunci	100 ons
18.	Kunyit	100 ons
19.	Lengkuas	100 ons
20.	Sawi hijau	500 gram
21.	Wortel	1 kg
22.	Brokoli	1 kg
BUAH		
1.	Melon	5 Kg
2.	Papaya	5 Kg
3.	Pisang ambon	5 Kg
4.	Pisang candi	5 Kg
5.	Semangka	20 kg
LAUK		
1.	Ayam	5 kg
2.	Bakso	10 pack
3.	Daging sapi	5 kg
4.	Nugget ayam	10 pack
5.	Sosis sapi	10 pack
6.	Sosis ayam	10 pack
7.	Tahu	10 kotak
8.	Tempe	10 kotak
PERALATAN		
1.	Baki makan pasien	80 kotak
2.	Sendok makan	10 lusin
3.	Garpu makan	5 lusin
4.	Lemper/cobek batu besar	2 pcs
5.	Mangkuk sayur	36 pcs
6.	Panci kecil	6 pcs
7.	Panci tanggung	4 pcs
8.	Panci besar	2 pcs
9.	Lap piring	24 pcs

10.	Piring lauk pasien	24 pcs
11.	Piring lauk untuk tamu	24 pcs
12.	Pisau dapur	10 pcs
13.	Regulator LPG	2 pcs
14.	Saringan santan stainless stel	2 pcs
15.	Saringan stainless stel tanggung	2 pcs
16.	Talenan plastic	6 pcs
17.	Tampah	1 pcs
18.	Wajan Teflon besar	1 pcs
19.	Wajan Teflon kecil	1 pcs
20.	Wajan besar	1 pcs
21.	Wajan kecil	1 pcs
22.	Tempat sampah injak	6 pcs
23.	Tempat gula kopi	12 pcs
24.	Sendok teh	10 pcs
25.	Blender jus	2 pcs
26.	Blender bumbu/gilingan bumbu listrik	1 pcs
27.	Mixer	1 pcs
RUMAH TANGGA		
1.	Kresek hitam besar	2 pack
2.	Kresek hitam tanggung	2 pack
3.	Kresek hitam kecil	2 pack
4.	Lap piring	10 pcs
5.	Sabun ekonomi reffil	12 pcs
6.	Wash hand	12 pcs
7.	Sabut cuci plastik	5 pcs
8.	Garpu buah	5 pack
9.	Sedotan Bengkok	1 kg
10.	Suma nova L6 (detergent disc washer)	5 liter
11.	Suma kristal A8 (Cairan pembilasan)	5 Liter
12.	Suma drain (cairan pembersih lemak)	5 Liter
13.	Deversol (cairan penghilang noda susah hilang)	1 kg
11.	Soklin lantai	12 pcs

KESELAMATAN PASIEN

7.1 PENGERTIAN

1. Keselamatan pasien RS adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.
2. Kesalahan pemberian diet adalah suatu kesalahan dalam pemberian makanan sesuai dengan kondisi medis pasien
3. Adanya benda asing dalam makanan merupakan kesalahan dalam pemberian makanan pada pasien berkaitan dengan adanya benda selain makanan seperti rambut, ulat, kawat cuci alat masak.
4. Manajemen risiko adalah suatu metode yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan mengkomunikasikan risiko yang ada pada suatu kegiatan.
5. Insiden Keselamatan Pasien (IKP) adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi.
6. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan ("commission") atau karena tidak bertindak ("omission"), bukan karena "underlying disease" atau kondisi pasien.
7. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) adalah suatu Insiden yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien.
8. Kejadian Tidak Cedera (KTC) adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak menimbulkan cedera, dapat terjadi karena "keberuntungan"(misal; pasien terima suatu obat kontraindikasi tetapi tidak timbul reaksi obat), atau "peringanan" (suatu obat dengan reaksi alergi diberikan, diketahui secara dini lalu diberikan antidotumnya).
9. Kondisi Potensial Cedera (KPC) adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden.
10. Kejadian Sentinel (Sentinel Event) adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius; biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima seperti: operasi pada bagian tubuh yang salah. Pemilihan kata "sentinel" terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi (misalnya Amputasi pada kaki yang salah, dan sebagainya) sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku.
11. Laporan insiden keselamatan pasien RS (Internal) Pelaporan secara tertulis setiap kejadian nyaris cedera (KNC) atau kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian tidak cedera (KTC) atau kondisi potensial cedera (KPC) yang menimpa pasien.
12. Sanitasi makanan merupakan salah satu upaya pencegahan yang menitikberatkan pada kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi selama proses pengolahan, penyiapan pengangkutan, penjualan sampai pada saat makanan dan minuman tersebut siap dikonsumsi kepada konsumen (Direktorat Hygiene dan Sanitasi, Ditjen Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular).
13. Salah satu kegiatan dari sanitasi makanan adalah penyehatan makanan dan minuman. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kuman pada makanan dan minuman. Faktor-faktor tersebut berasal dari proses penanganan makanan, minuman, lingkungan, dan

orangnya; sehingga makanan dan minuman yang disajikan rumah sakit tidak menjadi mata rantai penularan penyakit.

7.2 TUJUAN

Kegiatan penyehatan makanan dan minuman di Rumah Sakit ditujukan untuk:

- a. Tersedianya makanan yang berkualitas baik dan aman bagi kesehatan konsumen
- b. Menurunnya kejadian risiko penularan penyakit atau gangguan kesehatan melalui makanan
- c. Terwujudnya perilaku kerja yang sehat dan benar dalam penanganan makanan.

7.3 TATA LAKSANA KESELAMATAN PASIEN

1. Pelaksanaan Sanitasi Makanan dalam penyelenggaraan makanan

a. Ruang Pengolahan (Dapur)

- 1) Tersedianya fasilitas kamar toilet khusus bagi pegawai dapur, locker untuk menyimpan pakaian kerja dan ruang untuk ganti pakaian
- 2) Ruang dalam dapur harus bersih, tersedia tempat sampah sementara yang diberi kantong plastik yang kemudian dibuang dengan plastiknya ke tempat pengumpulan sampah diluar. Diruang ruangan dapur terdapat fasilitas tempat pengumpulan sampah yang tertutup.

b. Bangunan

- 1) Pintu-pintu tempat ruang persiapan dan masak harus dibuat membuka/menutup sendiri (*self closing door*), dilengkapi peralatan anti lalat seperti kasa, tirai, dan pintu rangkap.
- 2) Fasilitas Cuci Tangan:
 - a) Terletak di luar ruang ganti pakaian, wc/kamar mandi
 - b) Tersedia air yang mengalir
 - c) Tersedia sabun dan kain lap pengering
 - d) Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, kuat, antikarat dan permukaan halus
- 3) Saluran limbah, sebagai pembuangan limbah pengolahan makanan yang aman dari binatang pengganggu.

c. Sarana dan peralatan untuk pelaksanaan sanitasi makanan

1) Air bersih

Tersedianya air yang bersih dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dan memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 01/Birhukmas/II/1975. Standar mutu air tersebut, meliputi:

- a) Standar bersih, yaitu suhu, warna, bau, dan rasa
- b) Standar biologi, yaitu kuman-kuman parasit, kuman-kuman patogen, dan bakteri *E. coli*
- c) Standar kimiawi, yaitu derajat keasaman (pH) jumlah zat padat dan bahan-bahan kimia lainnya
- d) Standar radio aktif meliputi benda-benda radioaktif yang mungkin terkandung dalam air

2) Alat pengangkut/roda/kereta makanan dan minuman harus tertutup sempurna, dibuat dari bahan kedap air, permukaannya halus dan mudah dibersihkan. Menurut PGRS (2013) ada 2 jenis trolley makanan yang digunakan di rumah sakit, yaitu trolley makanan dengan pemanas dan tanpa pemanas. Alat transportasi makanan atau trolley makanan sebelum mengangkut makanan dibersihkan dahulu untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada ditrolley agar tidak terjadi kontaminasi. Prosedur harian dalam pemeliharaan trolley makanan:

- a) Membersihkan trolley dengan lap sebelum ditempatkan makanan
- b) Membawa ke ruangan-ruangan untuk melakukan distribusi makanan
- c) Setelah pendistribusian makanan trolley dipakai untuk mengambil peralatan makan pasien

d) Kemudian dibersihkan kembali dengan lap

Prosedur mingguan dalam pemeliharaan trolley makanan:

a) Membersihkan trolley dengan air dan sabun pembersih menggunakan lap basah

b) Lalu mengeringkan trolley dengan lap kering sebelum digunakan kembali

Prosedur yang dilakukan setiap bulan dalam pemeliharaan trolley makanan yaitu selalu mengecek roda dan pintu trolley, apabila ada kerusakan segera diperbaiki.

3) Rak-rak penyimpanan bahan makanan/makanan harus mudah dipindahkan-pindahkan dengan menggunakan roda-roda penggerak untuk kepentingan proses pembersihan.

4) Peralatan yang kontak dengan makanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Permukaan utuh (tidak cacat), dan mudah dibersihkan

b) Lapisan permukaan tidak mudah rusak akibat asam/basah, atau garam-garaman yang lazim dijumpai

c) Tidak terbuat dari logam berat yang dapat menimbulkan keracunan, misalnya: timah hitam (Pb), Arsenium (As), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Cadmium (Cd), dan Antimoni (Stibium)

d) Wadah makanan, alat penyajian dan distribusi makanan harus tertutup

2. Prinsip Penyehatan Makanan dalam Penyelenggaraan Makanan

Prinsip penyehatan makanan menggunakan teknik HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) meliputi bahan makanan, penjamah makanan, dan cara kerja yang dilakukan serta upaya pengendalian pertumbuhan kuman berbahaya.

a. Bahan makanan (sumber, mutu cara penanganan)

1) Sumber bahan makanan

Harus diketahui asal lokasinya secara pasti, tidak tercemar dari sampah atau pupuk yang dipakai, bebas dari insektisida, peptisida, atau bahan kimia lainnya.

2) Mutu bahan makanan

Harus dipilih bahan makanan yang bermutu baik, yaitu bahan makanan segar, yang aman, utuh, baik dan bergizi, misalnya: utuh, tidak berlubang/berulat, besar dan bentuk seragam, tidak busuk, tidak kotor dan tidak layu, cukup masak/matang (untuk buah).

3) Cara penanganan bahan makanan, harus memperhatikan cara penanganan yang tepat dan baik, misalnya

a) Dengan menggunakan kemasan yang memenuhi syarat

b) Memperhatikan pengangkutan yang layak

b. *Hygiene* tenaga penjamah makanan

1) Syarat

Untuk mewujudkan penyehatan perorangan yang layak dalam penyelenggaraan makanan, diperlukan tenaga penjamah yang memenuhi syarat:

a) Bukti sehat diri dan bebas dari penyakit

b) Tidak menderita penyakit kulit, penyakit menular, scabies ataupun luka bakar

c) Bersih diri, pakaian, dan seluruh badan

d) Mengikuti pemeriksaan kesehatan secara periodik

e) Mengetahui proses kerja dan pelayanan makanan yang benar dan tepat

f) Mengetahui teknik dan cara menerapkan hygiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan

g) Berperilaku yang mendukung terwujudnya penyehatan makanan

2) Perilaku, kebiasaan, dan sikap bekerja

Hal-hal yang harus dilakukan tenaga penjamah makanan adalah:

a) Cuci tangan dengan sabun sebelum mulai/sesudah bekerja, setiap keluar dari WC, sesudah menjamah bahan yang kotor

b) Sebelum dan selama bekerja tidak boleh menggaruk kepala, muka, hidung, dan bagian tubuh lain yang dapat menimbulkan kuman

c) Alihkan muka dari makanan dan alat-alat makan dan minum bila batuk atau

bersin

- d) Menggunakan masker/tutup hidung dan muka bila diperlukan
- e) Pengolahan makanan hendaknya dilakukan menurut proses yang ditetapkan, sesuai dengan peralatan masak, waktu, dan suhu ataupun tingkat pemasakan
- f) Jangan sekali-sekali menjamah makanan yang sudah masak, penggunaan sendok, garpu, atau alat yang lainnya
- g) Makan di ruang makan yang disediakan
- h) Merokok tidak boleh di ruang kerja
- i) Selalu menjaga agar tempat kerja, ruang ganti pakaian, kamar mandi, dan WC serta alat-alat tetap bersih sepanjang waktu
- j) Penjamah makanan dianjurkan untuk memakai sarung tangan

c. Prosedur kerja

Kontaminasi makanan atau kontaminasi ulang dapat disebabkan oleh perilaku si penjamah makanan selama bekerja. Hal ini disebabkan karena pegawai tidak bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang ada.

d. Upaya pengendalian

Upaya pengendalian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kuman pada makanan dan minuman, dapat dilakukan dengan pemantauan titik-titik rawan pada jalur penanganan makanan dan minuman yang diperkirakan memudahkan timbulnya bakteri dan fungi. Titik-titik rawan dalam proses penanganan makanan dan minuman adalah:

- 1) Proses pembersihan makanan
Pada proses ini hendaknya tidak ada makanan dan minuman yang membusuk setelah proses pembersihan bahan.
- 2) Proses persiapan bahan makanan. Pada proses ini hendaknya:
 - a) Tersedianya air bersih yang cukup
 - b) Kran-kran air dan saluran ruangan persiapan dalam keadaan bersih
 - c) Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang kuat dan mudah dibersihkan/dilapisi kantong plastik
- 3) Proses penyimpanan
Proses ini tidak akan mengalami kerawanan bila:
 - a) Dalam penyimpanan bahan mentah
Bahan mentah disimpan dalam ruangan/tempat yang terpisah dari ruang makanan terolah yang suhunya diatur sesuai dengan yang seharusnya.
 - b) Penyimpanan bahan terolah
Bahan mentah disimpan dalam ruangan/tempat yang terpisah dari ruang makan terolah yang suhunya diatur sesuai dengan yang seharusnya
 - (1) Penyimpanan makanan terolah yang tidak cepat membusuk dan dalam keadaan tertutup dilakukan pada suhu 10°C
 - (2) Penyimpanan makanan terolah yang cepat membusuk harus disimpan pada suhu 4°C selama 6 jam, jika > 6 jam harus disimpan pada suhu -5°C sampai -1°C
- 4) Proses pemasakan dan penghangatan makanan
Untuk kepentingan pengolahan biasanya bahan makanan diproses dengan bantuan panas dengan teknik/cara pemasakannya, sehingga tidak memungkinkan kuman tumbuh dan berkembang biak.
- 5) Proses pembersihan ruang dan pencucian alat masak
 - a) Pembersihan ruang dilakukan segera setelah proses pekerjaan/penanganan selesai yang sesuai dengan prosedurnya. Proses pembersihan meliputi ruang, lantai, dan langit-langit
 - b) Pencucian alat masak dilakukan setiap kali selesai masak, dengan langkah sebagai berikut: membuang sisa makanan yang melekat pada alat, bila perlu rendam dengan air panas, disabun, dibilas dengan air/air panas dan dikeringkan.

- 6) Proses pengangkutan makanan ke ruangan
Alat pengangkutan makanan dan minuman yang dipakai dilengkapi dengan tutup untuk menghindari debu diluar gedung dapur. Alat dibersihkan secara periodik.
- 7) Proses penyajian makanan di ruang rawat
 - a) Alat-alat makan yang akan dipakai untuk menyajikan makanan harus dalam keadaan bersih (sudah dicuci dengan sabun/desinfektan dan dibilas/direbus dengan air panas)
 - b) Tidak ada tanda-tanda vektor (lalat, lipas, tikus), ataupun bekas jejaknya di ruangan dapur
 - c) Penyajian makanan kepada pasien harus dalam keadaan tertutup.

3. Pengawasan Sanitasi dalam Penyelenggaraan Makanan

- Meliputi:
- a. Penjamah makanan, dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan usap dubur/kulit secara berkala
 - b. Bahan makanan dan makanan meliputi pemeriksaan kualitas bahan makanan dan makanan melalui berbagai uji, post control serta penilaian kualitas makanan melalui metode HACCP
 - c. Peralatan dengan melakukan uji sanitasi peralatan, misalnya: uji usap meja kerja dan peralatan masak
 - d. Lingkungan dengan melakukan uji sanitasi lingkungan misalnya dengan uji sanitasi lantai dan dinding

Idealnya setiap KTD/ KNC/ Kejadian Sentinel yang terkait dengan pelayanan gizi harus dikaji terlebih dahulu oleh ahli gizi yang berpengalaman sebelum diserahkan kepada Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Tujuan pengkajian untuk memastikan bahwa laporan tersebut sudah sesuai, dan kejadian yang dilaporkan benar, dan memasukkan dalam kategori insiden yang benar. Kategori kesalahan dalam pemberian obat di Instalasi Gizi adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Kategori Kesalahan di Instalasi Gizi

Instalasi Gizi	Kejadian kesalahan penyiapan makanan pasien	KPC/ KTC/ KTD
	Kejadian kesalahan penempelan label pada box makan pasien	KPC
	Kejadian kesalahan pemberian diet	KPC/ KTC/ KTD
	Kejadian kesalahan penulisan diet pada label makanan pasien dan rekam medis pasien	KPC/ KTC/ KTD
	Kejadian adanya benda asing dalam makanan pasien	KTC/ KTD
	Insiden kesalahan pemberian diet pasien	KTC/ KTD

7.4 Alur Pelaporan Insiden ke Tim Keselamatan Pasien (KP) di Rumah Sakit

1. Apabila terjadi suatu insiden (KNC/ KTD/ Kejadian Sentinel) terkait dengan pelayanan gizi, wajib segera ditindaklanjuti (dicegah/ ditangani) untuk mengurangi dampak/ akibat yang tidak diharapkan.
2. Setelah ditindaklanjuti, segera buat laporan insidennya dengan mengisi Formulir Laporan Insiden pada akhir jam kerja/ shift kepada ahli gizi penanggung jawab dan jangan menunda laporan (paling lambat 2 x 24 jam).
3. Laporan segera diserahkan kepada ahli gizi penanggung jawab
4. Ahli gizi penanggungjawab memeriksa laporan dan melakukan *grading risiko* terhadap insiden yang dilaporkan.
5. Hasil *grading* akan menentukan bentuk investigasi dan analisis yang akan dilakukan.
6. Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden dilaporkan ke Tim KP di RS.
7. Tim KP di RS akan menganalisis kembali hasil investigasi dan Laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan *Root Cause Analysis (RCA)*

- dengan melakukan *Regrading*.
- Untuk Grade kuning/merah, Tim KP di RS akan melakukan *Root Cause Analysis* (RCA).
 - Setelah melakukan *Root Cause Analysis* (RCA), Tim KP di RS akan membuat laporan dan Rekomendasi untuk perbaikan serta “pembelajaran” berupa : Petunjuk / *Safety alert* untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali.
 - Hasil *Root Cause Analysis* (RCA), rekomendasi dan rencana kerja dilaporkan kepada Direksi.
 - Rekomendasi untuk “Perbaikan dan Pembelajaran” diberikan umpan balik kepada instalasi gizi.
 - Ahli gizi penanggungjawab akan membuat analisis dan tren kejadian disatuan kerjanya.
 - Monitoring dan evaluasi perbaikan oleh Tim KP di RS.

7.5 Analisis Matriks Grading Risiko

Penilaian matriks risiko adalah suatu metode analisa kualitatif untuk menentukan derajat risiko suatu insiden berdasarkan dampak dan probabilitasnya.

- Dampak (consequences)
Penilaian dampak/akibat suatu insiden adalah seberapa berakibat yang dialami pasien mulai dari tidak ada cedera sampai meninggal.

Tabel 13. Penilaian Dampak Klinis/ Konsekuensi/ Severity

Tingkat Risiko	Deskripsi	Dampak
1	Tidak signifikan	Tidak ada cedera
2	Minor	- Cedera ringan misal Luka lecet - Dapat diatasi dengan pertolongan pertama.
3	Moderat	- Cedera sedang mis. Luka robek - Berkurangnya fungsi motorik/ sensorik/ psikologis atau intelektual (reversibel), tidak berhubungan dengan penyakit.
4	Mayor	- Cedera luas/ berat misal cacat, lumpuh - Kehilangan fungsi motorik/ sensorik/ psikologis atau intelektual (irreversibel), tidak berhubungan dengan penyakit.
5	Katastropik	Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

- Probabilitas/ frekuensi/ *likelihood*
Penilaian tingkat probabilitas/ frekuensi risiko adalah seberapa seringnya insiden tersebut terjadi.

Tabel 14. Penilaian Probabilitas/ Frekuensi

Tingkat risiko	Probabilitas
1	Sangat jarang/ rare (>5 thn/kali)
2	Jarang/ unlikely (>2-5 thn/kali)
3	Mungkin/ possible (1-2 thn/kali)
4	Sering/ likely (bebrp kali /thn)
5	Sangat sering/ almost certain (tiap minggu/ bulan)

Setelah nilai dampak dan probabilitas diketahui, dimasukkan dalam tabel matriks grading risiko untuk menghitung skor risiko dan mencari warna *bands risiko*.Skor Risiko :

$$\text{SKOR RISIKO} = \text{Dampak} \times \text{Probabilitas}$$

- Cara menghitung skor risiko :
- Untuk menentukan skor risiko digunakan matriks grading risiko :
- a. Tetapkan frekuensi pada kolom kiri
 - b. Tetapkan dampak pada baris ke arah kanan,
 - c. Tetapkan warna bandsnya, berdasarkan pertemuan antara frekuensi dan dampak.

Tabel 14. Matriks Grading Risiko

Probabilitas	Tidak signifikan 1	Minor 2	Moderat 3	Mayor 4	Katastropik 5
Sangat sering terjadi (tiap minggu/ bulan)	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Sering terjadi (beberapa kali/ thn)	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Mungkin terjadi (1 - <2 thn/ kali)	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Jarang terjadi (>2 - <5 thn/ kali)	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim
Sangat jarang terjadi (>5 thn/ kali)	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim

Keterangan:

Warna bands : hasil pertemuan antara nilai dampak yang diuru kebawah dan nilai probabilitas yang diurut ke samping kanan

Contoh :

Pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal kejadian seperti ini di rs x terjadi pada 2 tahun yang lalu

Nilai dampak : 5 (katastropik) karena pasien meninggal

Nilai probabilitas : 3 (mungkin terjadi) karena pernah terjadi 2 tahun

Lalu scoring risiko : 5 x 3 = 15 → warna bands : merah (ekstrim)

3. Bands Risiko

Bands risiko adalah derajat risiko yang digambarkan dalam empat warna yaitu : biru, hijau, kuning dan merah. Warna "bands" akan menentukan investigasi yang akan dilakukan :

Tabel 16. Tindakan Sesuai Tingkat dan Bands Risiko

Level / bands	Tindakan
---------------	----------

Extreme (sangat tinggi)	Risiko ekstrim, dilakukan RCA paling lama 45 hari membutuhkan tindakan segera, perhatian sampai ke direktur,
High (tinggi)	Risiko tinggi, dilakukan rca paling lama 45 hari kaji dengan detail & perlu tindakan segera serta membutuhkan perhatian top manajemen,
Moderate (sedang)	Risiko sedang, dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Manajer/ pimpinan klinis sebaiknya menilai dampak terhadap biaya dan kelola risiko
Low (rendah)	Risiko rendah, dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan dengan prosedur rutin

Keterangan:
 Bands biru dan hijau: investigasi sederhana oleh Ahli Gizi Penanggung Jawab.
 Bands kuning dan merah : investigasi komprehensif/ *Root Cause Analysis* (RCA) oleh Tim KP di RS.

KESELAMATAN KERJA

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari kegiatan yang berkaitan erat dengan kejadian yang disebabkan oleh kelalaian petugas, yang dapat mengakibatkan kontaminasi bakteri terhadap makanan. Kondisi yang padat mengurangi bahaya dan terjadinya kecelakaan dalam proses penyelenggaraan makanan antara lain karena pekerjaan yang terorganisir, dikerjakan sesuai dengan prosedur, tempat kerja yang aman dan terjamin kebersihannya, istirahat yang cukup. Kecelakaan tidak terjadi dengan sendirinya, biasanya terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan ataupun tidak diharapkan, serta dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat, makanan, dan "melukai" pegawai.

1. Pengertian

Keselamatan kerja (*safety*) adalah segala upaya atau tindakan yang harus diterapkan dalam rangka menghindari kecelakaan yang terjadi akibat kesalahan kerja petugas ataupun kelalaian/kesengajaan.

2. Tujuan

Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja Tahun 1970, syarat-syarat keselamatan kerja meliputi seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya, dengan tujuan:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
- f. Memberi perlindungan pada pekerja
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik/psikis, keracunan, infeksi, dan penularan
- i. Menyelenggarakan penyaluran udara yang cukup
- j. Memelihara kebersihan antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerja
- k. Memperoleh kebersihan antara tenaga kerja alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya
- l. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang
- m. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- n. Mengamankan dan memelihara pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang
- o. Mencegah terkena aliran listrik
- p. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

3. Identifikasi Bahaya Potensial

Identifikasi bahaya potensial merupakan langkah pertama manajemen risiko kesehatan di tempat kerja. Pada tahap ini dilakukan identifikasi potensi bahaya kesehatan yang terpajan pada tenaga gizi meliputi:

Tabel 17. Identifikasi Bahaya Potensial

NO	BAHAYA POTENSIAL	LOKASI	PEKERJAAN YANG BERISIKO
A.	KIMIA		
1.	Desinfektan.	Semua area.	Tenaga gizi yang terpapar desinfektan.
B.	BIOLOGI		
1.	Tuberculosis.	Instalasi rawat inap dan rawat jalan	Tenaga gizi saat melakukan KIE diet pasien.
C.	ERGONOMI		
1.	Pekerjaan yang dilakukan secara manual	Gudang penyimpanan bahan makanan .	Tenaga pengolahan
2.	Postur yang salah dalam melakukan pekerjaan	Instalasi gizi	Tenaga gizi
3.	Pekerjaan yang berulang	Semua area.	Tenaga gizi
D.	PSIKOSOSIAL		
1.	Sering kontak dengan pasien, kerja berlebih, ancaman secara fisik.	Semua area.	Tenaga gizi
E	MEKANIKAL		
1.	Terjepit mesin, tergulung, terpotong, tersayat, tertusuk.	Semua area yang terdapat peralatan mekanikal.	Tenaga gizi
F	ELEKTRIKAL		
1	Tersetrum, terbakar, ledakan.	Semua area yang terdapat arus atau instalasi listrik.	Tenaga gizi
G	LIMBAH		
1	Tertumpah, tertelan, terciprat, terhirup, tertusuk.	Semua area yang menggunakan menghasilkan limbah padat, limbah cair dan limbah gas, limbah.	Tenaga gizi

Pada kasus terkait dengan bahan kimia, maka perlu dipelajari *Material Safety Data Sheets* (MSDS) untuk setiap bahan kimia yang digunakan, meliputi :

1. Pengelompokan bahan kimia menurut jenis bahan aktif yang terkandung.
2. Identifikasi bahan pelarut yang digunakan.
3. Identifikasi bahan inert termasuk efek toksiknya.

-
4. Interaksi antar bahan yang menjadi lebih berbahaya atau mungkin juga menjadi kurang berbahaya.
 4. Prinsip keselamatan kerja pegawai dalam proses penyelenggaraan makanan sebagai pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembalian teknis mencangkup
 - 1) Letak, bentuk dan konstruksi alat sesuai dengan kegiatan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan
 - 2) Ruang dapur cukup luas, denah sesuai dengan arus kerja dan dapur dibuat dari bahan-bahan atau konstruksi yang memenuhi syarat
 - 3) Perlengkapan alat kecil yang cukup disertai tempat penyimpanan yang praktis
 - 4) Penerapan dan ventilasi yang cukup memenuhi syarat
 - 5) Tersedianya ruang istirahat untuk pegawai.
 - b. Adanya pengawasan kerja yang dilakukan oleh penanggung jawab dan terciptanya kebiasaan kerja yang baik oleh pegawai.
 - c. Pekerjaan yang ditugaskan hendaknya sesuai dengan kemampuan kerja dari pegawai.
 - d. Volume kerja yang dibebankan hendaknya sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Dan pegawai diberi waktu untuk istirahat setelah 3 jam bekerja, karena kecelakaan kerja sering terjadi setelah pegawai bekerja > 3 jam.
 - e. Perawatan alat dilakukan secara kontinyu agar peralatan tetap dalam kondisi yang layak pakai
 - f. Adanya pendidikan mengenai keselamatan kerja bagi pegawai
 - g. Adanya fasilitas/peralatan pelindung dan peralatan pertolongan pertama yang cukup
 - h. Petunjuk penggunaan alat keselamatan kerja
 5. Prosedur keselamatan kerja
 - a. Ruang penerimaan dan penyimpanan Bahan Makanan
 - 1) Menggunakan alat pembuka bungkus bahan makanan menurut cara yang tepat dan jangan melakukan dan meletakkan posisi tangan pada tempat ke arah bagian alat yang tajam (berbahaya).
 - 2) Barang yang berat selalu ditempatkan di bagian bawah dan angkatlah dengan alat pengangkit yang tersedia untuk barang tersebut
 - 3) Pergunakan tutup kotak/tutup panci yang sesuai dan hindari tumpahan bahan
 - 4) Tidak diperkenankan merokok di ruang penerimaan dan penyimpanan bahan makanan
 - 5) Lampu harus dimatikan bila tidak dipergunakan/diperlukan
 - 6) Tidak mengangkat barang berat, bila tidak sesuai dengan kemampuan pekerja
 - 7) Tidak mengangkat barang dalam jumlah yang banyak, yang dapat membahayakan badan dan kualitas makanan
 - 8) bahan yang tumpah atau keadaan licin di ruang penerimaan dan penyimpanan.
 - b. Di ruang persiapan dan pengolahan makanan
Keamanan dan keselamatan kerja di ruang ini akan tercapai bila:
 - 1) Menggunakan peralatan yang sesuai dengan cara yang baik, misalnya gunakan pisau, golok, parutan kelapa dengan baik, dan jangan bercakap-cakap selama menggunakan alat tersebut
 - 2) Menggunakan alat pelindung kerja selama di ruang persiapan dan pengolahan makanan seperti celemek, topi, baju kerja, sepatu dan lain-lain
 - 3) Tidak menggaruk, batuk, selama mengerjakan atau mengolah bahan makanan
 - 4) Menggunakan berbagai alat yang tersedia sesuai dengan petunjuk pemakaiannya
 - 5) Membersihkan mesin menurut petunjuk dan matikan mesin sebelumnya
 - 6) Menggunakan serbet sesuai dengan macam dan peralatan yang akan dibersihkan
 - 7) Berhati-hati bila membuka dan menutup, menyalakan atau mematikan mesin, lampu gas/listrik, dan lain-lain

-
- 8) Meneliti dulu semua peralatan sebelum digunakan
 - 9) Pada saat selesai menggunakannya, teliti kembali apakah semua alat sudah dimatikan mesinnya
 - 10) Mengisi panci-panci menurut ukuran semestinya, dan jangan melebihi porsi yang ditetapkan
 - 11) Tidak memuat kereta makanan melebihi kapasitasnya
 - 12) Meletakkan alat menurut tempatnya dan diatur dengan rapi
 - 13) Bila ada alat pemanas atau baki perhatikan cara penggunaan dan pengisiannya
 - 14) Bila membawa air panas, tutup dengan rapat dan jangan mengisi terlalu penuh
 - 15) Perhatikan bila membawa makanan pada baki, jangan sampai tertumpah atau makanan tersebut tercampur
 - 16) Perhatikan posisi tangan sewaktu membuka dan mengeluarkan isi kaleng.
- c. Di ruang pembagian makanan di instalasi gizi
- 1) Tidak mengisi panci/piring terlalu penuh
 - 2) Tidak mengisi kereta makan melebihi kapasitas kereta makan
 - 3) Meletakkan alat dengan teratur dan rapi
 - 4) Bila ada alat pemanas, perhatikan waktu menggunakannya
 - 5) Bila membawa air panas, tutup dengan rapat atau tidak mengisi tempat tersebut sampai penuh
 - 6) Menggunakan alat pelindung kerja selama di ruang pembagian makanan seperti celemek, topi, *hand gloves* dan lain-lain
- d. Di dapur ruang rawat inap
- Keamanan dan keselamatan kerja di dapur ruangan dapat tercapai bila:
- 1) Menggunakan peralatan yang bersih dan kering
 - 2) Menggunakan dengan baik peralatan sesuai dengan fungsinya
 - 3) Menggunakan alat pelindung kerja selama di dapur ruangan seperti celemek, topi, dan lain-lain
 - 4) Tidak menggaruk, batuk selama menjamah makanan
 - 5) Menggunakan serbet sesuai dengan macam dan peralatan yang dibersihkan
 - 6) Berhati-hati dan teliti bila membuka dan menutup atau menyalakan dan mematikan kompor, lampu, gas, listrik (untuk listrik blender, mixer, dan sebagainya)
 - 7) Meneliti dulu semua peralatan sebelum digunakan
 - 8) Menata makanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
 - 9) Mengikuti petunjuk/prosedur kerja yang ditetapkan. Sebelum mulai bekerja dan bila akan meninggalkan ruangan harus cuci tangan dengan menggunakan sabun atau desinfektan
 - 10) Membersihkan/mencuci peralatan di dapur maupun kereta makan sesuai prosedur
 - 11) Membuang/membersihkan sisa makanan/sampah segera setelah alat makan/alat dapur selesai digunakan
 - 12) Tidak meninggalkan dapur ruangan sebelum yakin bahwa kompor, lampu, gas, listrik sudah dimatikan, dan kemudian pintu dapur harus ditinggalkan dalam keadaan tertutup/terkunci.
- e. Alat pelindung kerja
- 1) Baju kerja, celemek dan topi terbuat dari bahan yang tidak panas, tidak licin, dan enak dipakai, sehingga tidak mengganggu gerak pegawai sewaktu kerja
 - 2) Menggunakan sandal yang tidak licin bila berada di lingkungan dapur (tidak menggunakan hak tinggi)
 - 3) Menggunakan cempal/serbet pada tempatnya

-
- 4) Tersedia alat sanitasi yang sesuai, misalnya air dalam keadaan bersih dan jumlah yang cukup, sabun, alat pengering, dan sebagainya
 - 5) Tersedia alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik di tempat yang mudah terjangkau
 - 6) Tersedia alat/obat P3K.

PENGENDALIAN MUTU

Peningkatan mutu pada pelayanan gizi di Rumah Sakit Prima Husada terdiri dari pengawasan dan pengendalian.

9.1 PENGERTIAN

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan atau kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, standar, peraturan dan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Selain itu pengawasan bertujuan untuk membina aparatur negara yang bersih dan berwibawa.

2. Pengendalian

Pengendalian merupakan bentuk atau bahan untuk melakukan pembetulan atau perbaikan pelaksanaan yang terjadi sesuai dengan arah yang ditetapkan. Pengertian pengawasan dan pengendalian hampir sama. Perbedaannya jika pengawasan mempunyai dasar hukum dan tindakan administratif, sedangkan pengendalian tidak. Pengawasan dan pengendalian bertujuan agar semua kegiatan-kegiatan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasilguna, dilaksanakan sesuai dengan rencana, pembagian tugas, rumusan kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan pengendalian merupakan unsur penting yang harus dilakukan dalam proses manajemen.

3. Evaluasi/penilaian

Evaluasi merupakan salah satu implementasi fungsi manajemen. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang disusun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Melalui penilaian, pengelola dapat memperbaiki rencana yang lalu bila perlu, ataupun membuat rencana program yang baru. Pada kegiatan evaluasi, tekanan penilaian dilakukan terhadap proses, masukan, luaran, dampak untuk menilai relevansi kecukupan, kesesuaian dan kegunaan. Dalam hal ini diutamakan luaran atau hasil yang dicapai.

9.2 BENTUK-BENTUK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data kegiatan pelayanan gizi rumah sakit dalam jangka waktu tertentu, untuk menghasilkan bahan bagi penilaian kegiatan pelayanan gizi rumah sakit maupun untuk pengambilan keputusan. Pencatatan ini dilakukan pada setiap langkah kegiatan yang dilakukan. Pelaporan dilakukan berkala sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Kegiatan pencatatan dan pelaporan di instalasi gizi:

a. Pencatatan dan pelaporan pengadaan makanan

1) Formulir pemesanan bahan makanan harian

-
- 2) Pencatatan bahan makanan yang diterima oleh bagian gudang instalasi gizi pada hari itu
 - 3) Pencatatan sisa bahan makanan (harian/bulanan), meliputi bahan makanan basah dan bahan makanan kering
- b. Pencatatan dan pelaporan tentang penyelenggaraan makanan
 - 1) Buku laporan timbang terima antara pergantian rotasi (berisi pesan-pesan yang penting)
 - 2) Buku laporan pasien baru/ yang berdiet khusus
 - 3) Buku laporan pasien baru makanan biasa
 - c. Pencatatan dan pelaporan anggaran belanja bahan makanan
 - 1) Pencatatan tentang pemasukan dan pemakaian bahan makanan harian selama 1 kali putaran menu
 - 2) Perhitungan tentang rencana kebutuhan bahan makanan untuk yang akan datang selama triwulan/tahunan
 - 3) Rekapitulasi tentang pemasukan dan pemakaian bahan makanan
 - 4) Pencatatan tentang penggunaan bahan bakar perbulan
 - d. Pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi di ruang rawat inap
 - 1) Buku catatan harian pasien tentang perkembangan diet
 - 2) Formulir permintaan makanan untuk pasien baru
 - 3) Formulir permintaan makan pagi, siang, dan sore
 - 4) Laporan harian tentang kegiatan penyuluhan
 - e. Pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi di ruang rawat jalan
 - 1) Mencatat registrasi pasien yang baru datang (nama, diagnosa, jenis diet, antropometri)
 - 2) Membuat/mengisi leaflet sesuai standar dan penyakitnya
 - 3) Formulir anamnesis
 - 4) Formulir status pasien
 - 5) Membuat laporan penyuluhan (pada Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit, laporan penyuluhan pada pasien rawat jalan dan rawat inap). Semua laporan dikumpulkan, lalu dibuat rangkuman kemudian disampaikan kepada Kepala Instalasi Gizi untuk dimanfaatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan rumah sakit.
2. Pengawasan standar porsi
 - a. Untuk bahan makanan (padat) pengawasan porsi dilakukan dengan penimbangan.
 - b. Untuk bahan makanan yang cair/setengah cair seperti susu dan bumbu dipakai gelas ukuran/liter matt, sendok ukuran atau alat ukur lain yang sudah distandarisasi atau bila perlu ditimbang.
 - c. Untuk pemotongan bentuk bahan makanan yang sesuai untuk jenis hidangan, dapat dipakai alat-alat pemotong atau dipotong menurut petunjuk.
 - d. Untuk memudahkan persiapan sayuran dapat diukur dengan kontainer/panci yang standar dan bentuk sama.
 - e. Untuk mendapatkan porsi yang tetap (tidak berubah-ubah) harus digunakan standar porsi dan standar resep.
 3. Pengawasan harga

Langkah-langkah yang perlu dilakukan:

 - a. Tetapkan kebijakan keuangan yang ingin dicapai

-
- b. Buat format isian pelaksanaan pencatatan pelaporan yang baku untuk pengawasan
 - 1) Pencatatan pemasukan bahan makanan, harga pemakaian bahan makanan untuk setiap putaran menu, bulanan, triwulan, dan tahunan
 - 2) Kalkulasi harga pemasukan bahan makanan, harga pemakaian bahan makanan untuk setiap putaran menu, bulanan, triwulan, dan tahunan
 - 3) Perhitungan stok bahan makanan akhir
 - 4) Kumpulkan data klien harian, satu putaran menu, bulanan, triwulan, dan tahunan
 - 5) Biaya overhead (dalam hal ini penyusutan) dicatat harian, setiap putaran menu, bulanan, triwulan, dan tahunan
 - c. Kalkulasi pemasukan bahan makanan berikut nilai rupiahnya setiap saat dan pada periode tertentu yang telah ditentukan.

4. Pengendalian biaya

Pengendalian biaya adalah suatu proses dimana pimpinan atau pengelola mencoba mengatur biaya guna mencegah pemborosan dari biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dimaksud disini yaitu biaya makan.

Biaya bahan makanan dapat meningkat atau menurun dari harga yang diperkirakan. Oleh karena itu biaya makanan dapat dikendalikan melalui berbagai cara; seperti menukar, mengubah, atau mengganti bahan makanan dengan bahan makanan lain. Pengendalian biaya ini merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan aktivitas-aktivitas seperti perencanaan menu, pembelian (pemesanan), penerimaan, pengolahan, dan juga tenaga/personelnya.

a. Tujuan pengendalian biaya makanan

- 1) Menganalisa biaya yang direncanakan dibandingkan dengan harga yang sesungguhnya digunakan untuk penyelenggaraan makanan
- 2) Menilai harga penawaran bahan makanan
- 3) Mencegah sisa bahan makanan yang tidak efisien
- 4) Menyediakan data untuk laporan penyelenggaraan institusi
- 5) Membandingkan dua atau lebih kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan makanan.

b. Cara pengendalian biaya makanan

- 1) Kembangkan kebijakan keuangan bagi institusi. Hal ini tergantung pada tujuan dan bentuk kegiatan, target keuntungan dan persentase dari makanan, tenaga, dan biaya overhead lainnya yang dapat dicapai
- 2) Kembangkan pengendalian secara rutin. Pengendalian kegiatan harus mencakup prosedur kerja karyawan dan pemeriksaan menyeluruh mulai dari perencanaan menu, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, produksi, distribusi serta penyajian/penjualan
- 3) Pengendalian pada pos kegiatan. Hal ini berkaitan dengan laporan biaya makan, perhitungan hasil, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan

c. Kendala dalam pengendalian biaya makanan

- 1) Banyak menggunakan bahan makanan yang mudah rusak
- 2) Banyak volume kegiatan yang tidak dapat diperkirakan sehingga sulit membuat perkiraan jumlah makanan (secara tepat) yang harus disiapkan
- 3) Tidak stabilnya kondisi pasar sehingga dapat mempengaruhi harga makanan
- 4) Banyaknya variasi makanan yang harus diproduksi

-
- d. Langkah-langkah dalam proses pengendalian
- 1) Membuat dasar untuk pelaksanaan, yaitu:
 - a) Standar kualitas adalah suatu mutu dari bahan jadi dan pelayanan serta jasa yang harus ditentukan atau dibuat patokan (tolak ukur). Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian, standar ini dapat berupa peraturan, pembakuan instruksi yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan institusi
 - b) Standar kuantitas adalah ukuran berat, jumlah, dan volume yang diwujudkan dalam ukuran bentuk.
 - c) Standar biaya adalah harga taksiran dari suatu barang atau jasa yang digunakan untuk mengukur biaya lain. Hal ini berguna dalam menghitung daya guna dari suatu pelaksanaan yang dibandingkan dengan biaya sebenarnya. Juga merupakan petunjuk dari apa yang sedang dikerjakan dibandingkan dengan apa yang seharusnya dikerjakan.
 - d) Standar prosedur. Berkenaan dengan cara/teknik yang ditetapkan sebagai cara yang benar untuk kegiatan sehari-hari dalam proses penyelenggaraan makanan.
 - 2) Melatih tenaga penyelenggaraan makanan untuk memahami dan melaksanakan standar-standar yang telah ditetapkan
 - 3) Memonitor, melihat, mengukur, mengecek pelaksanaan yang dilakukan kemudian membandingkan antara pelaksanaan kegiatan yang benar-benar dilakukan dengan standar yang telah dibuat sebelumnya. Bila terjadi ketidaksamaan atau penyimpangan-penyimpangan yang merupakan umpan balik (feed back) yang harus diperbaiki.
 - 4) Menetapkan tindakan perbaikan/koreksi untuk mengatasi penyimpangan dengan melaksanakan cara-cara yang telah disepakati berdasarkan data kegiatan terdahulu
5. Pengendalian biaya tenaga/ harga tenaga
- a. Tujuan
Untuk memaksimalkan efisiensi tenaga kerja secara berdaya guna sesuai dengan standar kualitas dan pelayanan yang dilakukan, sehingga dapat tercapai tujuan yang optimal
 - b. Faktor yang mempengaruhi biaya
 - 1) Tipe menu dan besarnya persiapan yang diperlukan
 - 2) Jenis pelayanan
 - 3) Jumlah hidangan yang disajikan setiap hari
 - 4) Peralatan yang digunakan.
 - 5) Jumlah tenaga kerja
 - c. Penghematan penggunaan tenaga
 - 1) Menu yang disajikan harus sederhana dan spesifik
 - 2) Gunakan bahan makanan setengah jadi
 - 3) Buat standar performance dan produktivitas
 - 4) Perencanaan dan taksiran tenaga yang dibutuhkan
 - 5) Perencanaan staff harus tepat
 - 6) Jadwal harus ketat dan tepat
 - 7) Gunakan tenaga paruh waktu atau secara kontrak
 - 8) Awasi kelebihan waktu
 - 9) Gunakan peralatan yang tepat dan cukup

-
- 10) Sederhanakan setiap prosedur
 - 11) Latih tenaga kerja untuk meningkatkan performance
 - 12) Tanamkan disiplin pada pegawai
 - 13) Gunakan catatan yang tepat
 - 14) Awasi pertukaran pegawai
 - 15) Lakukan reorganisasi bila perlu
 - 16) Perbaiki layout fasilitas

PENUTUP

Demikianlah Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi disusun yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi dengan baik dan benar sesuai ketentuan standar pelayanan kesehatan bidang gizi sehingga pelayanan kesehatan prima dapat terwujud.

Pedoman pelayanan Instalasi Gizi ini disusun dengan memperhitungkan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya senantiasa untuk dilengkapi sesuai kebutuhan tuntutan pelayanan.

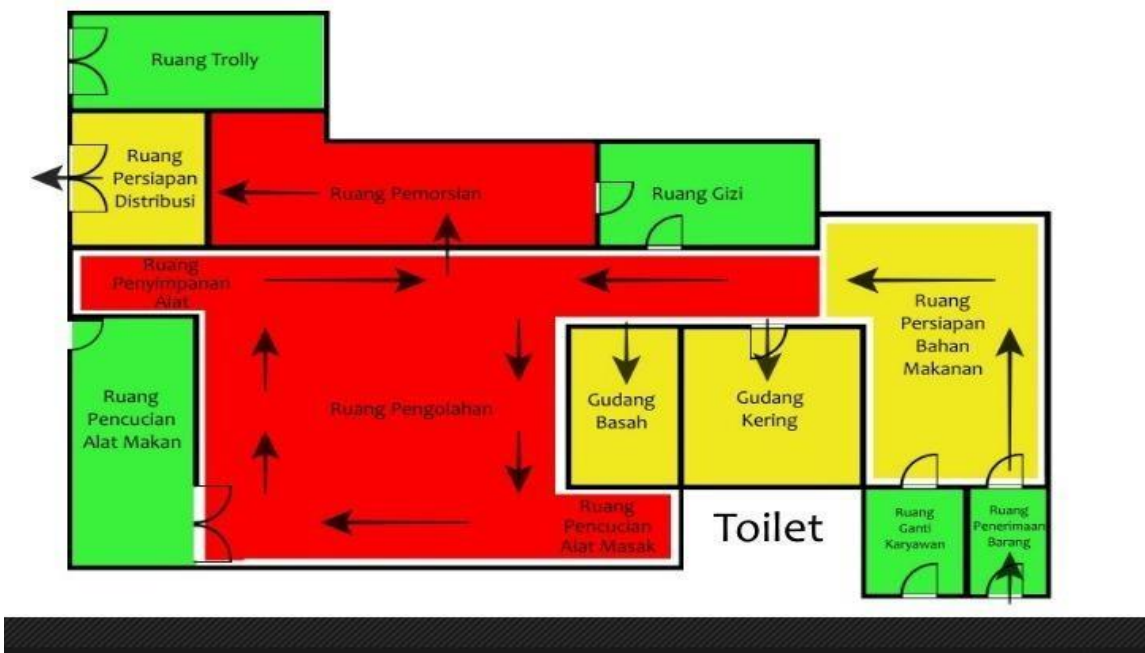
Akhirnya semoga pedoman pelayanan Instalasi Gizi ini dapat dipergunakan oleh seluruh Instalasi Gizi dan bermanfaat bagi peningkatan mutu layanan di pelayanan Gizi Rumah Sakit Prima Husada.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

1. Denah Dapur



2. Daftar kebutuhan makanan pasien di RS Prima Husada (buat tabel sesuai diagnosis)

No.	Kode	Diagnosis gizi	Diagnosis penyakit	Diet	Rute pemberian diet	Frekuensi pemberian diet
1.	N1 5.4	Penurunan kebutuhan Na Disebabkan HT ditandai dengan TD >normal	Hipertensi	Rendah Garam	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
2.	NC 2.2	Perubahan nilai Lab. Terkait gula darah disebabkan gangguan fungsi endokrin ditandai dengan GD >normal	Diabetes Mellitus	DM	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
3.	NI- 51.2	Kelebihan intake lemak disebabkan pola makan yang salah ditandai dengan LDL,TG,Chol >normal	Kardiovaskuler	DJ 1/2/3/4	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
4.	NC 2.2	Perubahan nilai Lab. Terkait BUN/SC disebabkan gangguan fungsi ginjal ditandai	CKD	Rendah protein	Oral	3 x makanan utama 1 x snack

No.	Kode	Diagnosis gizi	Diagnosis penyakit	Diet	Rute pemberian diet	Frekuensi pemberian diet
		dengan BUN/SC >normal				
5.	NC 2.2	Perubahan nilai lab. Terkait Hb disebabkan perdarahan/gangguan fungsi organ ditandai dengan HB <normal	Anemia	Tinggi Fe	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
6.	NI 1.1	Peningkatan kebutuhan energi disebabkan adanya infeksi usus ditandai dengan hasil widal +	Thypoid	TKTP rendah serat	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
7.	NI- 55.1	Kekurangan intake mineral kalium disebabkan karena tidak suka makan sayur dan buah/diare/pendarahan Ditandai dengan K rendah	Hipokalemi	Tinggi kalium	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
8.	NI 3.1	Kekurangan intake cairan disebabkan gangguan fungsi pencernaan ditandai dengan diare >3x sehari	GEA	Rendah serat free lactosa	Oral	3 x makanan utama 1 x snack
9.	NC 2.2	Perubahan nilai lab. Terkait kadar trombosit disebabkan kuman nyamuk aedes aegypti Ditandai dengan trombosit <normal	DHF	TKTP	Oral	3 x makanan utama 1 x snack

3. Makanan dan Jenis Makanan yang digunakan di RS Prima Husada

No.	Bahan Makanan	Nama Menu/ Makanan	Pengolahan
1.	Ayam Telur ayam Wortel Daun bawang	Rolade Ayam	Dikukus
2.	Tahu Buncis Ayam fillet Daun bawang tomat	Semur	Direbus

3.	Jagung manis Wortel Daun bawang Telur ayam	Bakwan Jagung	Digoreng
4.	Telur ayam	Telur ceplok	Digoreng
5.	Daging sapi Wortel Daun bawang	Semur daging	Direbus
6.	Tahu kedelai	Tahu goreng	Digoreng
7.	Suun Wortel Polong Bakso	Sop sayur	Direbus
8.	Kentang Telur ayam Daun bawang Ayam Giling	Perkedel kentang Ayam	Digoreng
9.	Ayam fillet bagian dada	Ayam Fillet Panggang	Dipanggang
10.	Sawi putih Wortel Daun bawang Ayam suwir	Cah Sayur	Ditumis
11.	Tempe kedelai murni	Tempe goreng	Digoreng
12.	Sayur bayam Jagung manis Labu siam	Bening bayam	Direbus
13.	Telur Ayam	Telur Pindang	Direbus
14.	Jamur Tiram	Jamur Goreng	Digoreng

15.	Wortel Bunga kol Sawi daging Daging ayam	Capjay	Ditumis
16.	Telur Ayam	Telur Dadar Tebal	Digoreng
17.	Daging Sapi	Lapis Daging	Direbus
18.	Sawi daging Daging ayam Wortel	Sup sawi	Ditumis
19.	Tahu Wortel Telur ayam Bakso Daun bawang	Sapo tahu	Digoreng dan direbus
20.	Telur ayam	Telur Rebus	Direbus
21.	Labu siam Buncis Bakso	Sup Kuning	Direbus
22.	Wortel Kacang polong Bakso Jamur es	Sop sayur	Direbus
23.	Daging ayam	Ayam wijen	Digoreng, ditumis
24.	Telur ayam Wortel Daun bawang Kacang polong	Fuyunghai	Digoreng
25.	Tahu Telur ayam Wortel	Sayur masak kuning	Digoreng Direbus
26.	Ayam suwir Kubis Sohun	Soto ayam	Digoreng Direbus

4. Sayur dan buah yang sering digunakan di RS Prima Husada Malang

No.	Sayur yang sering dipakai di RSPH	Buah yang sering dipakai di RSPH
1.	Wortel	1. Semangka
2.	Buncis	2. Melon
3.	Sawi daging	3. Pisang
4.	Jagung manis	4. Pepaya
5.	Kacang polong	
6.	Sawi putih	
7.	Jamur tiram	
8.	Jamur es	
9.	Kentang	
10.	Labu siam	
11.	Kacang Panjang	
12.	Timun	
13.	Gambas / oyong	
14.	Kembang Kol	
15.	Kacang kapri	
16.	Kubis	
17.	Sawi hijau	
18.	Brokoli	
19.	Touge	
20.	Tomat	

4. Spesifikasi Bahan Makanan

No.	Nama Bahan Makanan	Spesifikasi
	a. DAGING	
1.	Daging ayam	Bersih, segar, tanpa lemak, tanpa isi perut, tanpa kaki, tanpa lemak
2.	Daging sapi	Bersih, warna merah, tidak berurat, tidak berlemak, tidak busuk
3.	Ikan	Bersih, segar, ingsan warna merah, mata tidak cekung, tidak berlendir, tidak bau
4.	Hati ayam / ampela	Segar, bersih, tidak hancur dan tidak bau
5.	Udang	Segar, bersih, tidak busuk/bau, utuh, tidak bertelur
6.	Telur	Bersih, tidak busuk, cangkang utuh, tidak bonyok
7.	Bakso daging sapi	Segar, mulus, ukuran sedang, bersertifikat halal, tanpa formalin/boraks, tidak kadaluarsa, kemasan utuh
8.	Sosis dan nugget	Segar, tidak bau ,bersertifikat halal, tanpa formalin/boraks, tidak kadaluarsa, kemasan utuh
	b. SAYUR	
9.	Bayam	Segar, muda, bersih, daun utuh, tidak berulat, warna hijau, tidak busuk
10.	Buncis	Segar, muda, bersih, tidak berlubang, tidak busuk, warna hijau, panjang 7-10 cm
11.	Jagung Manis	Segar, bersih, tidak busuk, berbiji rata dan utuh, warna kuning, manis, tidak berulat
12.	Jagung Muda	Segar, bersih, tidak busuk, muda, tidak berulat, warna kuning
13.	Kembang Kol	Segar, bersih, tidak berulat, tidak busuk, tanpa tangkai dan daun
14.	Brokoli	Segar, bersih, tidak berulat, warna hijau
15.	Kacang Panjang	Segar, muda, tidak berlubang dan berulat, warna hijau tua
16.	Wortel	Segar, bersih, muda, tidak berulat, tidak bonyok, kulit mulus, warna merah orange merata, tidak berdaun
17.	Oyong	Segar, muda, bersih, tidak berlubang, tidak busuk, biji kecil, warna hijau
18.	Kentang	Segar, bersih, permukaan licin/tidak banyak mata, tua, utuh, tidak berlubang, tidak berulat
19.	Labu siam	Segar, muda, tidak berulat, bersih, belum keluar biji, warna hijau dan utuh

No.	Nama Bahan Makanan	Spesifikasi
20.	Sawi Hijau	Segar, muda, daun utuh, bersih, tidak berulat, tidak berlubang, warna hijau
21.	Sawi putih	Segar, muda, daun utuh, bersih, tidak berulat, tidak berlubang, warna putih
22.	Touge	Segar, keras, tidak busuk, tidak lembab/basah, tidak bau, berwarna putih, akar tidak panjang
23.	Terong	Segar, muda, utuh, bersih, tidak berulat/berlubang, warna kulit ungu/hijau muda
24.	Tomat	Segar, bersih, masak, tidak bonyok, warna merah merata, tidak busuk/berulat
25.	Timun	Segar, bersih, tidak busuk, warna hijau muda, besar rata dari pangkal ke ujung
26.	Tahu Putih	Segar, padat, tidak hancur, bersih, tidak berformalin/boraks, tidak berlendir, tidak asam, bahan kedelai murni
27.	Tempe	Segar, bersih, bau khas tempe kedelai, tidak asam, tidak pecah, bentuk persegi panjang
	c. BUAH	
28.	Pisang	Segar, manis, tua, daging padat, kuning merata, tidak busuk, panjang 10-12 cm
29.	Pepaya	Segar, manis, tua, masak, daging warna merah, tidak busuk/bonyok, utuh
30.	Melon	Segar, manis, tidak busuk, warna kulit hijau muda, matang, daging putih kehijauan
31.	Semangka	Segar, manis, tua masak, biji sedikit, warna daging merah merata, tidak berulat, tidak busuk
32.	Apel	Segar, bersih, tidak bonyok/busuk/berulat, warna merah merata
33.	Pear	Segar, bersih, kulit mulus, warna kuning merata, tidak busuk, tidak berulat
34.	Jeruk	Segar, tua, manis, warna kulit hijau kekuningan, tidak busuk, dan tidak bonyok
	d. LAIN-LAIN	
35.	Roti Tawar	Warna putih, tidak berjamur, bentuk kotak, tidak kadaluarsa, sudah dipotong-potong dan kemasan utuh

5. Materi Pembatasan Diet

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
DM	Ayam tanpa kulit, ikan, putih telur, daging tidak berlemak Tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai Sayur tinggi serat: kangkung, tomat, daun kacang, terong, oyong, ketimun, labu siam, kembang kol, lobak, sawi, selada, seledri Jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, belimbing (sesuai kebutuhan)	Semua sumber karbohidrat dibatasi: nasi, bubur, roti, mie, kentang, singkong, ubi, sagu, gandum, pasta, jagung, talas, havermout, sereal, ketan, macaroni Protein hewani tinggi lemak jenuh: (kornet, otak, sosis, sarden, jeroan, kuning telur) Bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, wortel, daun singkong, pare, daun katuk, daun ketela, jagung muda, kapri, kacang panjang Nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo, semangka, nangka	Keju, susu full cream, dendeng, abon Buah manis dan diawetkan: durian, nangka, alpukat, kurma, manisan buah. Minuman beralkohol, susu kental manis, soft drink, es krim, yoghurt, susu Gula pasir, gula merah, gula batu, madu, cake, kue-kue manis, dodol, tarcis, sirup, selai manis, coklat, permen, tape, mayonaise	Roti gandum (2 lembar) Selai kacang (2 sdm) Telur rebus (1 btr) Lalap daun selada + Tomat Jam 10.00 Apel (1 buah)	Nasi (150 gr) Semur daging (50 gr) Tempe goreng (50 gr) Pecel Jeruk (1 buah) Jam 15.00 (Selingan) Puding pepaya	Nasi (150 gr) Pepes ikan (50 gr) Cah tahu (50 gr) Tumis kangkung Apel (1 buah) Jam 20.00 (Selingan) Crackers tawar atau buah

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
		Makanan yang digoreng dan yang menggunakan santan kental, kecap, saus tiram				
JANTUNG	Sumber karbohidrat: nasi, nasi tim, bubur roti gandum, macaroni, jagung, kentang, ubi dan talas, havermout, sereal Daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, putih telur, susu rendah lemak (low fat) Tempe, tahu, kacang hijau, kedelai Bayam, buncis, labu kuning, labu siam, wortel, kangkung, kacang panjang, tomat, gambas, kecipir, daun kacang	Mie, roti putih, ketan, kue-kue, cake, biskuit, gula Daging tanpa lemak 1x/minggu, ayam 3x/minggu, bebek, sarden (makanan kaleng) dan kuning telur 1x/minggu Kacang tanah maksimal 25 gr	Daging berlemak, jeroan, sosis, daging asap, gajih, otak, kepiting, kerang, keju, susu full cream Kacang merah, oncom, kacang mente Sayuran yang dapat menimbulkan gas: kol, kembang kol, lobak, sawi, nangka muda Buah yang dapat menimbulkan gas dan tinggi lemak: durian, cempedak, nangka, nanas	Nasi Tim (100 gr) Ikan Pindang (50 gr) Orak-arik wortel Teh manis encer Selingan Juice Pepaya (200 ml)	Nasi Tim (150 gr) Daging bumbu tomat (50 gr) Oseng tempe (50 gr) Bening Bayam Buah : Jeruk Manis (1 buah)	Nasi Tim (100 gr) Ayam panggang bumbu kecap (50 gr) Pepes Tahu (50 gr) Cah Sayuran Buah : Pisang Ambon (1 buah)

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	panjang, daun kenikir, ketimun, daun selada dan toge Jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, belimbing, mangga Cara pengolahan: direbus, dikukus, dipanggang, ditumis		Kopi, teh kental, minuman bersoda dan beralkohol Berbumbu tajam (pedas, asin, asam), bumbu olahan yang mengandung Natrium Cara pengolahan digoreng			
HIPERTENSI	Sumber karbohidrat, protein nabati dan hewani, sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung serat Makanan yang diolah tanpa atau sedikit menggunakan garam natrium, vetsin, kaldu bubuk Sumber protein hewani: penggunaan	Pemakaian garam dapur Penggunaan bahan makanan yang mengandung natrium seperti soda kue	Otak, ginjal, paru, jantung, daging kambing Makanan yang diolah menggunakan garam natrium Crackers, pastries Kerupuk, keripik dan makanan kering yang asin	Nasi (125 gr) Telur balado (50 gr) Tumis buncis Jam 10.00 (Selingan) Jus buah (200 ml)	Nasi (150 gr) Ikan pepes (50 gr) Sambal goreng kering tempe (50 gr) Sayur bening Bayam Buah: papaya (100 gr)	Nasi (125 gr) Ayam bakar (50 gr) Oseng-oseng tahu (50 gr) Cah sayuran Buah: jeruk manis (1 buah) Pukul 21.00 Crackers tawar atau buah

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	daging/ ayam/ ikan ±100 gram/ hari. Telur ayam/ bebek 1 butir/ hari. Susu segar 200 ml/ hari		Makanan/ minuman kaleng: sarden, sosis, kornet, sayuran dan buah- buahan dalam kaleng Makanan yang diawetkan: dendeng, abon, ikan asin, ikan pindang, telur asin, udang kering, telur pindang, acar, selai kacang, manisan buah Mentega dan keju Bumbu-bumbu: kecap asin, terasi, petis, garam, saus tomat, saus sambal, tauco dan bumbu penyedap lainnya Makanan yang mengandung alkohol: durian, tape			

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
RENDAH LEMAK & KOLESTEROL (DISLIPIDEMIA)	Beras merah, roti, gandum, havermout, makaroni, jagung, kentang, ubi dan talas, sereal Ayam/ bebek tanpa kulit, ikan segar, susu non fat Tempe, tahu, oncom dan kacang-kacangan (kacang ijo, kacang tanah, kedelai) Semua jenis buah dan sayuran Lemak tak jenuh dalam jumlah sesuai kebutuhan: minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak wijen, minyak biji bunga matahari, minyak zaitun dan	Kue-kue, cake, biskuit, pastries, gula Daging tanpa lemak, udang, kuning telur (max. 2x/minggu)	Daging berlemak, otak, limpa, ginjal, hati, ham, sosis, babat, usus, cumi, sarden kaleng. Lemak jenuh: lemak sapi, babi, kam bing, susu full cream, keju, mentega. Minuman beralkohol: Arak, bir dan soft drink	Nasi (125 gr) Pepes Ikan (50 gr) Oseng Tempe (50 gr) + kacang panjang Jam 10.00 (Selingan) Asinan buah (100 gr)	Nasi (150 gr) Ayam panggang (50 gr) Tahu bacem (50 gr) Sayur asam Apel Jam 16.00 (Selingan) Puding buah	Nasi (150 gr) Ikan bumbu kuning (50 gr) Perkedel tahu (50 gr) Cah sayuran Jeruk Jam 21.00 (Selingan) Susu rendah lemak (200 gr)

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	margarine Makanan yang tidak berlemak dan menggunakan santan encer Memasak dengan merebus, mengukus, mengungkep, menumis, memanggang lebih dianjurkan daripada menggoreng					
LAMBUNG / GEA/ TF	Sumber karbohidrat: nasi, nasi tim, bubur, roti gandum, makaroni, jagung, kentang, ubi dan talas, havermout, sereal Daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit,	Mie, roti putih, ketan, kue-kue, cake, biskuit, pastries Daging tanpa lemak 1x/minggu, ayam 3x/minggu, bebek, sarden (makanan kaleng) dan kuning telur 1x/minggu	Daging berlemak, jeroan, sosis, daging asap, gajih, otak, kepiting, kerang, keju, susu full cream Kacang merah, oncom, kacang mente Sayuran yang dapat	Nasi Tim (100 gr) Telur Dadar (50 gr) Setup Wortel Teh manis encer Selingan Snack Biskuit	Nasi Tim (125 gr) Semur daging (50 gr) Tim Tahu (50 gr) Sayur Bening Pepaya Selingan Snack Puding Susu	Nasi Tim (125 gr) Ikan panggang bumbu tomat (50 gr) Tumis Tempe (50 gr) Setup Buncis Pisang (1 buah) Selingan

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	ikan, putih telur, susu rendah lemak Tempe, tahu, kacang hijau, kedelai Sayuran: toge, bayam, buncis, labu kuning, labu siam, wortel, kacang panjang, tomat, gambas, kangkung, kecipir, daun kacang panjang, daun kenikir, ketimun, daun selada Buah/ sari buah: jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, belimbing, mangga Garam, kecap, kunyit, laos, terasi, seledri, kayu manis, cengkeh, bawang merah dalam jumlah terbatas	kacang tanah, kacang bogor, maksimal 25 gr	menimbulkan gas: kol, kembang kol, lobak, sawi, nangka muda dan sayuran mentah Buah yang dapat menimbulkan gas dan tinggi lemak: durian, nangka, cempedak, nanas dan buah-buahan yang diawetkan Minuman beralkohol dan bersoda Cuka, merica, cabai, acar Santan kental, goreng- gorengan			Susu rendah lemak (200ml)

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	Santan encer, minyak, margarine, mentega					
RENDAH PURIN	Nasi, bubur, bihun, roti, pasta, gandum, makaroni, jagung, kentang, ubi, talas, singkong, havermout Telur, susu skim/ susu rendah lemak Wortel, labu siam, kacang panjang, terong, pare, oyong, ketimun, labu air, selada air, tomat, selada, lobak Semua macam buah- buahan Semua macam minuman yang tidak beralkohol	Daging, ayam, ikan tongkol, tenggiri, bawal, bandeng, kerang, udang dibatasi (Maks. 50 gram/ hari) Tempe, tahu (maks. 50 gram/ hari) dan kacang-kacangan (kacang hijau, kacang tanah, kedelai) maks. 25 gram/ hari Bayam, buncis, daun/ biji melinjo, kapri, kacang polong, kembang kol, asparagus, kangkung dan jamur (maks. 100 gram/ hari) Teh kental atau kopi	Tinggi purin (150- 800 mg/100 gram): hati, ginjal, jantung, limpa, otak, ham, sosis, babat, usus, paru, sarden, kaldu daging, bebek, burung, angsa, remis dan ragi. Minuman bersoda dan beralkohol: soft drink, arak, ciu, bir	Nasi (125 gr) Telur dadar isi wortel dan tomat (50 gr) Teh manis Jam 10.00 (Selingan) Semangka (100 gr)	Nasi (150 gr) Ikan bakar saos kecap (30 gr) Tempe bacem (25 gr) Sayur sop Buah jeruk (1 buah)	Nasi (150 gr) Semur daging (30 gr) Pepes tahu (30 gr) Tumis sawi dan tomat Buah pisang ambon (1 buah)

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	Semua macam bumbu secukupnya	Makanan berlemak, digoreng, santan kental				
RENDAH PROTEIN (CKD)	Sumber Karbohidrat sederhana: gula, selai, sirup, permen, madu untuk menambah energi, agar-agar, jelly Semua buah dan sayuran (kecuali untuk pasien dengan hiperkalemia) Minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak kedelai, dan margarin rendah garam	Sumber Karbohidrat Kompleks: nasi, jagung, kentang, makaroni atau pasta, havermout, ubi/ talas Daging kambing, ayam, ikan, hati, keju, udang, telur Tahu, tempe, oncom, kacang tanah, kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang kedelai Sayuran tinggi Kalium (jika pasien hiperkalemi): kentang, rebung, bokchoy, peterseli, buncis, bayam, daun papaya, talas, ubi jalar, labu kuning, seledri, lobak, sawi	Bila ada edema (bengkak di kaki), tekanan darah tinggi, perlu mengurangi garam dan menghindari bahan makanan sumber natrium lainnya, seperti soda, kaldu instan, ikan asin, telur asin, makanan yang diawetkan.	Nasi (125 gr) Orak arik telur + wortel (50 gr) Teh manis Selingan Melon (100 gr)	Nasi (150 gr) Ayam balado (30 gr) Tahu balado (25 gr) Tumis jamur Selingan Bubur sagu (100 gr)	Nasi (150 gr) Asem-asem ikan (30 gr) + labu siam Tempe bacem (25 gr) Stroberi Selingan Agar agar

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
		Buah-buahan tinggi Kalium (jika pasien hiperkalemi): sukun, apel, alpukat, jeruk, pisang, pir, pepaya, kurma, kiwi, markisa, jambu merah, srikaya, semangka, mangga, Apabila pasien mengalami hiperkalemia Minyak kelapa sawit, santan kental, mentega, dan lemak hewan				
HATI/ HEPAR	Nasi, kentang, roti, mie, makaroni, bihun, gula, tepung-tepungan yang dibuat bubur atau puding. Sayuran yang tidak banyak serat dan tidak menimbulkan gas:	Daging tidak berlemak, hati, ikan, ayam, (dipanggang, diungkep, disemur, ditim), telur (direbus/ didadar) Kacang-kacangan Kopi encer, susu skim	Ketan, ubi, singkong, talas, kue gurih dan cake Daging berlemak, daging asap, sosis, sarden, daging/ ikan yang diawetkan.	Nasi tim (100 gr) Telur dadar (50 gr) Asem-asem buncis Teh manis (150 ml) Selingan	Nasi tim (125 gr) Semur ayam (50 gr) Tahu bumbu kuning (50 gr) Cah wortel dan jagung muda Pepaya (100 gr) Selingan	Nasi tim (100 gr) Perkedel daging (50 gr) Tempe bacem (50 gr) (50 gr) Sup sayuran Pisang (1 buah) Selingan Roti bakar dan

DIET / DIAGNOSA	JENIS MAKANAN			CONTOH MENU		
	DIANJURKAN	DIBATASI	DIHINDARI	PAGI	SIANG	SORE
	bayam, labu kuning, labu siam, wortel, kacang panjang dll Pepaya, pisang, melon, jeruk, semangka dll	Garam, margarine, mentega, minyak goreng, santan encer	Susu full cream, susu kental manis dan hasil olahnya, keju, es krim Sayuran yang berserat dan bergas: kol, sawi, lobak, daun singkong, nangka muda, kembang kol Buah-buahan tinggi serat, tinggi lemak, bergas: nangka, nanas, durian, kedondong Minuman bersoda dan beralkohol: arak, bir, soft drink Goreng-gorengan, santan kental, tape kelapa Bumbu: cabe, cuka, lada, kecap asin, saos tomat	Selada buah (100 gr) dan Sirup (150 ml)	Puding susu dan sari buah jeruk (150 ml)	teh manis (150 ml)

6. Siklus Menu Pasien

Siklus	Pagi (Pukul 06.30)	Siang (Pukul 12.00)	Sore (Pukul 16.30)
1	Nasi / Nasi Tim	Nasi / Nasi Tim	Nasi / Nasi Tim
	Rolade ayam panir + tahu goreng+buncis	Semur Daging+wortel+daunan	Sup (Suun, wortel, polong, bakso)
	Bakwan jagung	Tahu Goreng	Perkedel kentang ayam
		Semangka	Pisang
VIP	Telur mata sapi/rebus	Abon	Ayam Roster Saos Kecap
Penunggu	Nasi Goreng, Telur Mata Sapi, Acar, Kerupuk	Sama Dengan Pasien	Sama Dengan Pasien
2	Nasi / Nasi Tim	Nasi / Nasi Tim	Nasi / Nasi Tim
	Cah sawi putih + wortel+daunan+ ayam suwir	Bening bayam, oyong	Cap jay (Wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)
	Rolade ayam potong serong	Bakwan jagung	Telur Dadar tebal
		Telur Pindang	Jelly Cup
		Melon	
Penunggu	Sama Dengan Pasien	Tahu Tetor Kerupuk	Sama Dengan Pasien
VIP	Tempe goreng	Jamur Goreng	Tempe goreng
3	Nasi / Nasi Tim	Nasi / Nasi Tim	Nasi / Nasi Tim
	Semur (ayam fillet, buncis, daunan, tomat)	Sup (Sawi daging, ayam dadu, wortel)	Sapo (Tahu goreng, wortel, bakso, daunan, saos tiram)
	Perkedel kentang ayam	Bakwan jagung	Telur Rebus
		Pisang	Melon
VIP	Telur dadar tebal	Lapis Daging	Tempe goreng
Penunggu	Mie goreng ayam + telur ceplok , acar	Sama Dengan Pasien	Sama Dengan Pasien
4	Nasi / Nasi Tim	Nasi / Nasi Tim	Nasi / Nasi Tim
	Manisah, Buncis, Bakso masak kuning	Sup (Wortel, polong, bakso, jamur es)	Fuyung hai (Telur+wortel+daunan) + saos polong orange
	Telur pindang	Ayam roster saos wijen	Jamur goreng
		Semangka	Puding marmer potong
VIP	Jamur goreng	Perkedel kentang ayam	Abon
Penunggu	Sama Dengan Pasien	Sama Dengan Pasien	Sama Dengan Pasien
5	Nasi / Nasi Tim	Nasi / Nasi Tim	Nasi / Nasi Tim
	Tahu ,Telur, Wortel masak kuning	Bening(Jagung sisir, bayam, manisah)	Soto ayam
	Perkedel kentang ayam	Ayam roster saos teriyaki	Telur rebus
		Pisang	Melon
VIP	Abon	Telur ceplok/rebus	Perkedel ayam
Penunggu	Sama Dengan Pasien	Sama Dengan Pasien	Sama Dengan Pasien

Menu Pengganti Untuk Diet Khusus:

DIET BIASA	DIET KHUSUS
Tempe Goreng	Tempe Kukus
Telur Ceplok	Telur Rebus
Perkedel	Tahu Kukus / Optional
Telur Gulung	Telur Rebus
Bakso Goreng	Bakso Kuah
Telur Dadar Tebal	Telur + Sayur Kukus
Tempe Bacem	Tempe/Tahu Bacem
Telur Dadar	Telur Rebus
Kripik Kentang	Kripik Kentang
Bakwan Jagung/Tahu	Tahu Kuning
Ayam Goreng	Ayam Bumbu Kecap / Ungkep
Jamur Krispi	Tahu/Tempe
Ayam Fillet Tepung	Ayam Panggang
Tahu Goreng	Tahu Bumbu Merah / Opor Tahu

Siklus Menu Snack:

SIKLUS	DIET BIASA	DIET KHUSUS
1	Lapis hongkong warna hijau coklat	Pisang Rebus
2	Bubur Sagu	Kentang Rebus
3	Setup pisang	Sari kacang hijau tawar
4	Bubur kacang hijau	Air kacang hijau jernih
5	Brulee bomb isi keju	Ubi Kukus

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SAHABAT MENUJU SEHAT	PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA 2025
STUNTING DAN WASTING	
1. Pengertian (Definisi)	Stunting merupakan perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO, disebabkan kekurangan gizi kronik yang berhubungan dengan status sosioekonomi rendah, asupan nutrisi dan kesehatan ibu yang buruk, riwayat sakit berulang dan praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak tepat. Wasting (Gizi buruk) adalah keadaan gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda berikut:: i) edema, minimal pada kedua punggung kaki; ii) BB/PB atau BB/TB kurang dari -3 SD; Lingkar lengan atas (LiLA) <11,5 cm pada balita usia 6-59 bulan.
2. Anamnesis	Identitas Dasar 1. Usia 2. Jenis kelamin 3. Riwayat Pertumbuhan Janin terhambat (PJT) 4. Riwayat kelahiran (BBLR, Prematur, Asfiksia) 5. Evaluasi pemberian imunisasi 6. Evaluasi tumbuh kembang anak (sesuai kurva atau tidak) 7. Berat badan dan Panjang badan lahir 8. Persalinan normal atau melalui operasi 9. Usia kehamilan saat melahirkan Riwayat gizi dan Pola makan 1. Evaluasi praktik pemberian ASI eksklusif (diberikan atau tidak, berapa lama pemberian ASI) 2. Evaluasi praktik pemberian MPASI (Dimulai usia berapa, kualitas diversifikasi makanan, frekuensi dan porsi) 3. Kebiasaan makan sebelum sakit, jumlah makanan dan cairan yang didapat pada beberapa hari terakhir Riwayat Penyakit 1. Infeksi berulang (diare, ISPA, pneumonia, TB) 2. Alergi makanan, intoleransi laktosa 3. Penyakit kronik (jantung bawaan, ginjal, malabsorbsi) 4. Riwayat kontak dengan penderita campak atau TBC paru 5. RPD dalam 3 bulan terakhir Riwayat Tumbuh Kembang 1. Perbandingan pertumbuhan dengan saudara sebaya 2. Riwayat milestone perkembangan (duduk, jalan, bicara) Riwayat Keluarga dan Sosial Ekonomi 1. Tinggi badan orang tua (apakah ada faktor genetik) 2. Pendidikan dan pola asuh orang tua 3. Kondisi ekonomi dan ketersediaan makanan 4. Akses air bersih, sanitasi, kepadatan rumah 5. Riwayat sakit orang tua atau keluarga
3. Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik 1. Pemeriksaan Antropometri a. Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), Lingkar kepala (LK), Lingkar lengan atas (LiLa) : Tinggi Badan/Panjang Badan (TB/PB), BB/TB atau BB/PB <- 3 SD dari median <i>WHO Child Growth</i> , atau didapatkan

	nutritional, dan pada anak umur 5-59 bulan lingkaran atas <11,5 cm b. Untuk remaja usia 6-18 tahun menggunakan <i>CDC Chart growth</i> untuk menentukan %BBI. % BBI Normal : 90 – 110% % BBI Kurang : 80 – 89% %BBI Buruk : <80 % c. Pada keadaan stunting (TB/U rendah), nilai cut off/batas ambang menjadi <-2 SD dari median referensi NCHS /WHO 2. Fisik Klinis a. Stunting 1. Tinggi badan anak tidak sesuai dengan anak seusianya 2. Riwayat berat badan tidak naik atau kenaikan berat badan tidak sesuai standar (<i>Weight Faltering</i>) 3. TB/U atau BB/U <-2 SD 4. Sering disertai gangguan kognitif, daya tahan tubuh lemah, dan risiko penyakit metabolik saat dewasa b. Marasmus 1. rambut jarang 2. wajah tampak tua 3. mata cekung atau cowong (tanda dehidrasi) , kelainan kornea konjungtiva (tanpa defisiensi vitamin A) 4. kulit keriput dan berlipat, jaringan lemak bawah kulit sangat tipis 5. didapatkan iga gambang 6. perut cekung c. Kwashiorkor 1. Rambut mudah rontok atau kemerahan 2. Wajah sembab 3. Kelainan kornea dan konjungtiva (tanda defisiensi vitamin A) 4. Edema anasarca 5. Dada tidak ada iga gambang 6. Hepatomegaly, ascites 7. Pitting edema pada extremitas 3. Pemeriksaan Sistemik a. Vital sign (HR, RR, suhu, TD), b. Status hidrasi c. Pemeriksaan jantung-paru (infeksi kronik) d. Abdomen (hepatomegali pada malnutrisi) e. Pemeriksaan neurologis (tonus, refleks, milestone)
4. Kriteria Diagnosis	Berdasarkan Kemenkes dan PNPK 2022, terdapat satu atau lebih kriteria berikut: a. Stunting 1. Terlihat pendek 2. TB/U < - 2 SD b. Wasting 1. Terlihat sangat kurus 2. Nutritional edema 3. BB/TB <-3 SD 4. LiLA <11,5 cm (pada anak usia 5-59 bulan) 5. Untuk remaja usia 6-18 tahun menggunakan %BBI, nilai %BBI <80% 6. Lingkaran kepala dikatakan normal apabila terletak di antara +2 SD hingga -2 SD, mikrosefali apabila terletak di

	bawah -2 SD dan makrosefali apabila terletak di atas +2 SD. 7. Indeks Panjang badan atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin (PB/U atau TB/U) <-2 SD berdasarkan kurva WHO 2006 untuk anak 0-5 tahun dan kurva CDC pada anak > 5 tahun
5. Diagnosis Kerja	Moderate protein-energy malnutrition (E44.0) Mild protein-energy malnutrition (E44.1)
6. Diagnosis Banding	a. Tuberkulosis (TB) b. Penyakit jantung bawaan c. Penyakit hati kronis d. Anemia defisiensi besi berat
7. Pemeriksaan Penunjang	a. Pemeriksaan-pemeriksaan dasar seperti pemeriksaan darah perifer lengkap, urinalisis dan feses rutin dapat dilakukan jika ada indikasi b. Pemeriksaan lain seperti kultur urin, darah samar, dan analisis feses, profil besi, elektrolit darah, fungsi ginjal, fungsi hati, hormone tiroid (termasuk skrining hipotiroid konginetal pada bayi baru lahir). c. Skrining TBC dan pemeriksaan penunjang untuk menentukan ada tidaknya TBC pada anak stunting dilakukan pada yang terindikasi. d. Pada kecurigaan terhadap alergi susu sapi dilakukan pemeriksaan Immunoglobulin E radioallergosorbent test (IgE RAST) e. Jika ada kecurigaan terhadap kelainan metabolisme bawaan lakukan pemeriksaan rutin kelainan metabolic yaitu Gula Darah Sewaktu (GDS), Analisis Gas Darah (AGD) , senjang anion, laktat, ammonia, keton darah dan urin. f. Pemeriksaan HIV jika ada indikasi
8. Terapi	1. Tata laksana stunting dilakukan oleh dokter spesialis anak yang meliputi tata laksana nutrisi dengan pemberian makan yang benar dan energi yang cukup (Protein energy ratio, 10-15%), Jadwal tidur teratur dengan waktu tidur malam mulai 21.00 untuk mencapai tidur dalam, serta melakukan olahraga/ aktivitas fisik teratur paling tidak 30-60 menit, minimal 3-5 hari dalam seminggu. 2. Tata laksana gizi buruk usia 6-59 bulan E. Fase Stabilisasi (hari 1 dan 2) a. mencegah dan mengatasi hipoglikemia (berikan 50 ml larutan glukosa (1 sdt munjung gula pasir + 50 ml air putih) dilanjutkan dengan pemberian formula F-75 diberikan 2 jam sekali dalam 24 jam pertama b. mencegah dan mengatasi hipotermi (hangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut c. mencegah dan mengatasi dehidrasi (berikan resomal yaitu larutan campuran oralit WHO, gula pasir, dan mineral mix sebanyak 5-10 ml/kgBB/Jam selang seling dengan F-75 dengan takaran yang sama F. Fase transisi (hari 3-7) dimulai jika komplikasi medis teratasi, tidak ada hipoglikemia, nafsu makan pulih, edema berkurang. terapi dengan memberikan F-100 G. Fase Rehabilitasi (minggu ke 2-6) pemberian makanan dengan kebutuhan energi 150-220kkal/kgBB/hari. Protein 4-6g/kgBB/hari, cairan 150-200ml/kg/BH/hr H. Fase tindak lanjut (minggu ke 7-26) pemantauan berat badan. Kurang yaitu bila kenaikan BB kurang dari 5g/Kg BB/hari. Sedang bila kenaikan BB 5-10

	g/kg BB/hari. Baik yaitu bila kenaikan BB lebih dari 10g/KgBB/hari. 3. Tata laksana fase awal pada anak > 5 tahun a. umur 6-10 tahun : kebutuhan energi 75kkal/kgBB i. Fase Stabilisasi formula 75 : 4,2 ml/kgBB/jam ii. Fase Stabilisasi formula 100 : 3,0 ml/kgBB/jam b. umur 11-14 tahun: kebutuhan energi 60 kkal/kgBB i. Fase Stabilisasi formula 75 : 3,5 ml/kgBB/jam ii. Fase Stabilisasi formula 100 : 2,5 ml/kgBB/jam c. Umur 5-18 tahun: kebutuhan energi 50kkal/kgBB i. Fase Stabilisasi formula 75 : 2,8 ml/kgBB/jam ii. Fase Stabilisasi formula 100 : 2,0 ml/kgBB/jam 4.Selanjutnya pada fase rehabilitasi ditingkatkan sampai mencapai RDA sesuai dengan berat badan ideal berdasarkan tinggi badan 5.Tata laksana fase awal pada bayi <6 bulan dengan pemberian formula sebagai berikut: a. Kemungkinan mendapatkan ASI i. Berikan ASI setiap 3 jam selama paling tidak 20 menit, lebih sering jika anak menangis atau terlihat menginginkan menyusu ii. Antara 30 menit dan satu jam setelah menyusu normal berikan jumlah pemeliharaan F-75 (dengan edema) atau F100 yang diencerkan (tanpa edema) atau susu formula menggunakan teknik <i>supplemental suckling</i> b. Tanpa kemungkinan mendapatkan ASI Tata laksana sama dengan tata laksana anak usia 6-59 bulan dengan formula 75 dan formula 100 yang diencerkan 6. Tata laksana pemberian mikronutrien a. Vitamin A (diberikan hari ke-1, ke-2, dan ke-15) i. 0-5 bulan : 50.000 IU ii. 6-12 bulan : 100.000 IU iii. 12 bulan : 200.000 IU b. Asam folat i. <6 bulan : 2,5 mg dosis tunggal ii. 6-59 bulan : 5 mg pada hari pertama, selanjutnya 1 mg tiap 24 jam (oral) selama 6 minggu c. Zinc : 2 mg/kgBB/hari tiap 24 jam oral selama 6 minggu atau hingga status gizi baik d. Copper (tembaga) 0,3 mg/kgBB/hari tiap 24 jam oral selama 6 minggu atau hingga status gizi baik e. Fe elemental 1-3 mg/kgBB/hari diberikan mulai hari ke-14 (fase rehabilitasi) selama 4 minggu atau lebih sampai kadar Hb normal selama 2 bulan berturut-turut I. Tata laksana infeksi Semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat dating kefaskes dan segera diberi antibiotic spektrum luas a. Tidak ada komplikasi : kotrimokazol oral b. Komplikasi sesuai dengan penyakit dasar
9. Edukasi	a. Pemberian Informasi Diagnosis b. Pemberian Informasi Tindakan c. Gizi dan Pola Hidup
10. Prognosis	Dubia ad bonam
11. Kriteria Pulang	Tidak ada komplikasi medis, nafsu makan baik, secara klinis baik
12. Tingkat Evidens	IV
13. Tingkat Rekomendasi	A
14. Penelaah Kritis	dr. Dicky Faturrachman, Sp.A, M.BIOMED dr. Fiona Paramita Sp.A
15. Indikator Medis	Vital sign normal Tidak ditemukan gangguan intestinal maupun hemodinamik

16. Kepustakaan	a. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata laksana Stunting b. Pedoman Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita
-----------------	--